Optimal Untuk Negeri

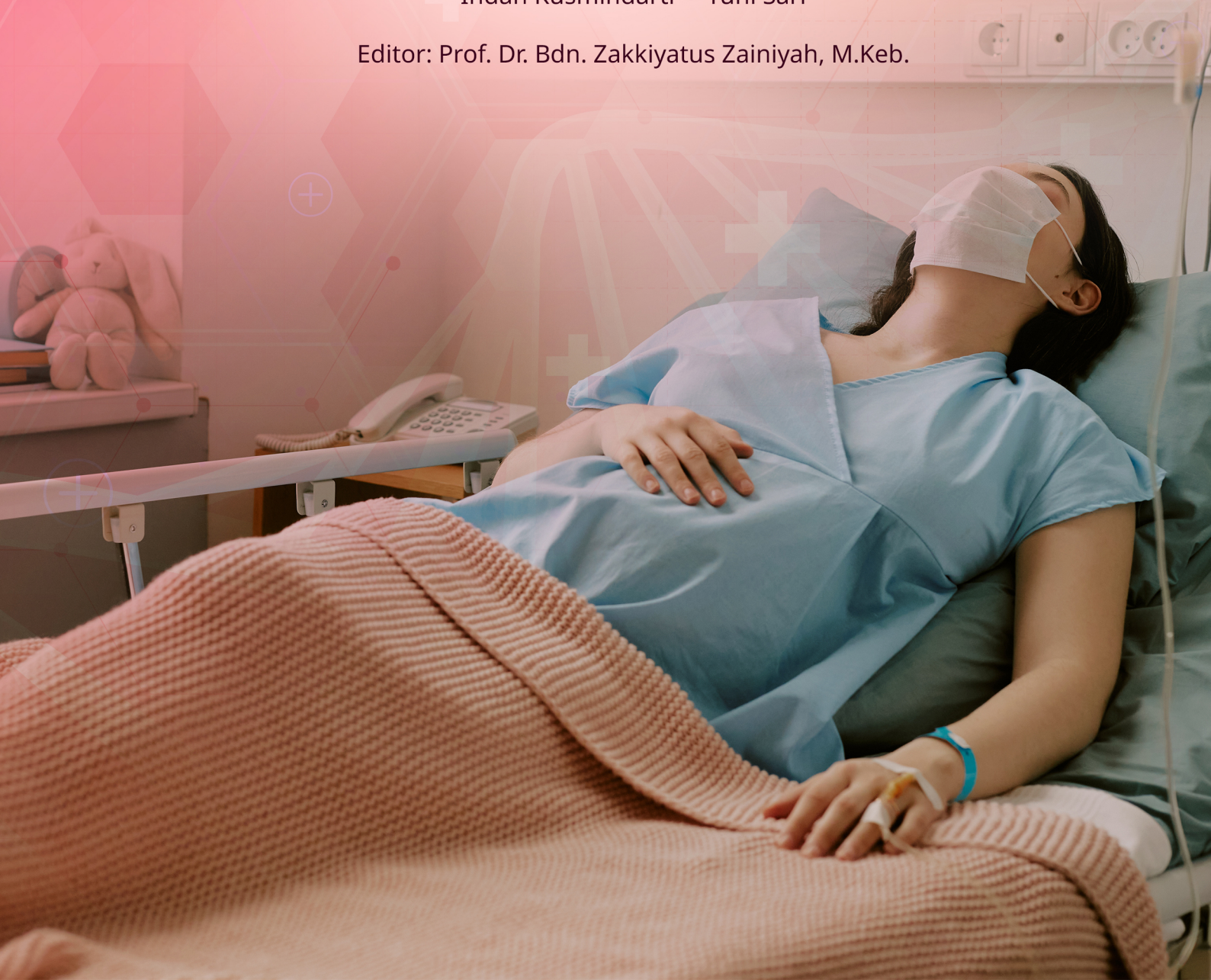
optimal

Buku Ajar

ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM

Zakkiyatus Zainiyah • Nana Usnawati • Susiani Endarwati
Indah Kusmindarti • Yuni Sari

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



BUKU AJAR
ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM

Penulis:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.
Bdn. Nana Usnawati, S.ST., M.Keb.
Susiani Endarwati, S.ST., M.Kes.
Indah Kusmindarti, SST., Bd., M.Kes.
Yuni Sari, SST., M.Keb.

Editor:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Optimal
Untuk
Negeri

BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM

Penulis:
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.
Bdn. Nana Usnawati, S.ST., M.Keb.
Susiani Endarwati, S.ST., M.Kes.
Indah Kusmindarti, SST., Bd., M.Kes.
Yuni Sari, SST., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7927-55-2

Cetakan Pertama : Oktober, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Copyright © 2026
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami dan mengembangkan keterampilan klinis yang diperlukan dalam memberikan asuhan kebidanan secara aman, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan.

Keterampilan klinis merupakan bagian penting dalam pendidikan kebidanan karena kemampuan seorang bidan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan, tetapi juga oleh kemampuan melakukan pemeriksaan, melaksanakan tindakan dasar, berkomunikasi secara efektif, serta memberikan informasi dan edukasi yang tepat kepada klien dan keluarga. Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan klinis perlu mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, komunikasi, etika, keselamatan pasien, dan profesionalisme.

Buku ajar ini membahas berbagai keterampilan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan tindakan dasar dalam pelayanan kebidanan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Materi disusun secara bertahap agar mahasiswa dapat memahami tujuan dan prinsip setiap tindakan, melakukan pengkajian dan pemeriksaan dengan benar, serta menghubungkan hasil pemeriksaan dengan kebutuhan asuhan kebidanan. Pembahasan juga menekankan pentingnya komunikasi terapeutik, pemberian informasi yang mudah dipahami, penghormatan terhadap hak dan pilihan klien, serta penerapan prinsip keselamatan dalam setiap pelayanan.

Dalam praktik kebidanan, keterampilan klinis tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengambil keputusan dan bekerja sesuai kewenangan profesi. Setiap tindakan perlu dilakukan berdasarkan kondisi klien, standar pelayanan, prinsip etika, serta pertimbangan keselamatan. Dengan demikian, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber untuk memahami prosedur, tetapi juga membantu mahasiswa membangun pola pikir klinis dan sikap profesional sejak proses pendidikan.

Penyusunan buku ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan isi buku pada masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, praktisi, dan pembaca lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan keterampilan klinis kebidanan.

Akhir kata, semoga buku ajar Keterampilan Klinis Kebidanan: Pemeriksaan, Tindakan Dasar, dan KIE dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam membentuk tenaga bidan yang kompeten, terampil, komunikatif, profesional, dan senantiasa mengutamakan keselamatan serta martabat klien.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 MANAJEMEN AKTIF, PENILAIAN PLASENTA, DAN PENCEGAHAN PERDARAHAN **1**
A. Fisiologi Kala III 3
B. Manajemen aktif kala III 4
C. Menilai kelengkapan plasenta/selaput 4
D. Asuhan Kebidanan Kala Tiga Persalinan 6
E. Latihan Soal 10
F. Ringkasan 32
G. Daftar Pustaka 36

BAB 2 ASUHAN PERSALINAN KALA IV PEMANTAUAN, DETEKSI DINI SYOK DAN STABILITAS IBU **39**
A. Konsep Asuhan Kala IV 41
B. Pemeriksaan kala IV 48
C. Parameter pemantauan kala IV 49
D. Penjahitan episiotomy dan Laserasi 50
E. Memperkirakan kehilangan darah 51
F. Tanda tanda awal syok obstetric 53
G. Tindakan menjaga stabilitas ibu 57
H. Dokumentasi hasil pemantauan 59
I. Latihan Soal 61
J. Ringkasan 64
K. Daftar Pustaka 67

BAB 3 KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM: PERDARAHAN, SYOK, DAN STABILISASI AWAL **87**
A. Mengenali Cepat Perdarahan Intrapartum/Postpartum Awal dan Tindakan Awal Sesuai Algoritme 89
B. Latihan Soal 93
C. Ringkasan 97

D. Daftar Pustaka 98

BAB 4 PREEKLAMPSIA/EKLAMPSIA SAAT INTRAPARTUM: PENANANGANAN AWAL, PENCEGAHAN KEJANG DAN RUJUKAN 101

A. Konsep Dasar Preeklampsia 103
B. Patofisiologi Preeklampsi 103
C. Faktor Resiko Preeklampsi 107
D. Klasifikasi dan Definisi 108
E. Penanganan Awal Preeklampsi, pencegahan kejang dan Rujukan 109
F. Komplikasi Preeklampsi 110
G. Latihan Soal 112
H. Ringkasan 133
I. Daftar Pustaka 136

BAB 5 RUJUKAN INTRAPARTUM DAN TRANSPORT AMAN: KOMUNIKASI, DOKUMENTASI, DAN PENDAMPINGAN KELUARGA 139

A. Teori: Rujukan Intrapartum Dan Transport Aman 141
B. Asesmen (Piramida Miller) 158
C. Latihan Soal 158
D. Ringkasan 198
E. Daftar Pustaka 206

PROFIL PENULIS 209

BAB 1

MANAJEMEN AKTIF, PENILAIAN PLASENTA, DAN PENCEGAHAN PERDARAHAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPL 1. Menguasai konsep teoritis dan fisiologis persalinan serta prinsip asuhan kebidanan pada setiap kala persalinan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.
- CPL 2. Mampu melakukan pengkajian subjektif dan objektif secara sistematis pada perempuan selama persalinan untuk menentukan kondisi ibu, janin, dan kemajuan persalinan.
- CPL 3. Mampu merumuskan diagnosis dan masalah kebidanan berdasarkan hasil pengkajian serta mengenali penyimpangan dari proses persalinan fisiologis.
- CPL 4. Mampu melaksanakan keterampilan klinis dan tindakan dasar dalam asuhan persalinan secara tepat, sistematis, aman, dan sesuai kewenangan profesi bidan.
- CPL 5. Mampu mengenali tanda bahaya dan kegawatdaruratan intrapartum, melakukan stabilisasi awal, menentukan prioritas tindakan, serta melakukan kolaborasi atau rujukan sesuai kebutuhan.
- CPL 6. Mampu menerapkan komunikasi terapeutik, KIE, penghormatan terhadap hak dan martabat perempuan, serta melibatkan keluarga secara tepat dalam proses asuhan.
- CPL 7. Mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, dokumentasi, etika, dan profesionalisme dalam seluruh rangkaian asuhan persalinan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- CPMK 1. Menjelaskan konsep, fisiologi, tahapan, dan mekanisme persalinan serta perubahan maternal dan fetal selama proses intrapartum.
- CPMK 2. Melakukan anamnesis terarah dan pemeriksaan fisik serta obstetri untuk menilai kondisi ibu, janin, kontraksi, dan kemajuan persalinan.
- CPMK 3. Menganalisis hasil pengkajian untuk menentukan diagnosis atau masalah kebidanan pada setiap kala persalinan.

- CPMK 4. Melaksanakan asuhan kebidanan pada persalinan fisiologis sesuai standar, prinsip berbasis bukti, dan kebutuhan individual perempuan.
- CPMK 5. Melaksanakan tindakan klinis pada kala persalinan secara sistematis, termasuk pengelolaan kala III, penilaian plasenta dan selaput ketuban, serta pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan.
- CPMK 6. Mengidentifikasi faktor risiko, penyimpangan, dan tanda bahaya selama persalinan yang dapat berkembang menjadi kegawatdaruratan intrapartum.
- CPMK 7. Melakukan penilaian cepat, stabilisasi awal, serta menentukan kebutuhan tindakan segera pada kondisi kegawatdaruratan sesuai kompetensi dan kewenangan bidan.
- CPMK 8. Menentukan kebutuhan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan secara cepat dan tepat berdasarkan kondisi klinis ibu dan janin serta kemampuan fasilitas pelayanan.
- CPMK 9. Menerapkan prinsip pencegahan perdarahan postpartum, keselamatan ibu dan bayi, serta deteksi dini komplikasi pada periode segera setelah persalinan.
- CPMK 10. Melaksanakan komunikasi terapeutik dan memberikan KIE kepada perempuan serta keluarga mengenai kondisi, tindakan, hasil pemantauan, tanda bahaya, dan rencana tindak lanjut.
- CPMK 11. Menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, informed consent, perlindungan privasi, serta perilaku profesional selama memberikan asuhan persalinan.
- CPMK 12. Mendokumentasikan hasil pengkajian, diagnosis, tindakan, respons terhadap tindakan, komplikasi, kolaborasi, dan rujukan secara lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian Materi

Kala III persalinan, atau kala uri, merupakan tahap setelah bayi lahir hingga keluarnya plasenta beserta selaput ketuban.

A. Fisiologi Kala III

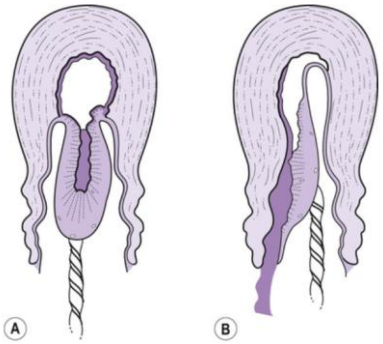
Proses pelepasan plasenta berlangsung secara fisiologis melalui dua fase:

1. Fase pelepasan

Setelah bayi lahir, otot uterus berkontraksi sehingga rongga rahim menyusut. Penyusutan ini membuat area perlekatan plasenta mengecil, sementara ukuran plasenta tetap. Akibatnya, plasenta menebal, terlipat, lalu terlepas dari dinding uterus. Plasenta yang sudah lepas akan turun ke bagian bawah rahim atau masuk ke vagina dengan bantuan gravitasi. Umumnya, pelepasan terjadi dalam 6–15 menit setelah kelahiran bayi, baik secara spontan maupun dengan tekanan pada fundus uteri.

Tanda klinis plasenta lepas:

a. Bentuk dan tinggi uterus berubah: sebelum kontraksi berbentuk bulat (fundus 3 jari di bawah pusat), setelah kontraksi berbentuk segitiga/oval (fundus setinggi pusat, sering bergeser ke kanan).
b. Tali pusat memanjang keluar (tanda Ahfeld).
c. Terjadi semburan darah singkat akibat akumulasi darah retroplasenta yang mendorong plasenta terlepas.



Gambar 1. Pelepasan plasenta
a. Pelepasan metode Schultze
b. Pelepasan metode Duncan
Sumber: https://www.nursingawareness.com/message.php?id=119

2. Fase pengeluaran

Darah yang terkumpul di ruang utero-plasenter mendorong plasenta keluar melalui vagina, biasanya disertai perdarahan. Selaput ketuban ikut keluar, meski kadang sebagian jaringan plasenta tertinggal. Sisa jaringan dapat dikeluarkan

dengan cara menarik perlahan, memutar seperti tali, menggunakan klem, atau secara manual/digital.

B. Manajemen aktif kala III

Manajemen Aktif Kala III (MAK III) adalah tindakan proaktif bidan/tenaga kesehatan segera setelah bayi lahir (maksimal 2 menit) untuk mempercepat pelepasan plasenta, meningkatkan kontraksi uterus, dan mencegah perdarahan postpartum. Tiga langkah utama manajemen aktif kala III adalah pemberian uterotonika (oksitosin), penegangan tali pusat terkendali, dan masase fundus uteri.

Tujuan MAK III:

1. Memperpendek durasi kala III: mengurangi waktu pengeluaran plasenta menjadi sekitar 5-15 menit.
2. Mencegah perdarahan: memastikan rahim berkontraksi dengan baik untuk mengurangi kehilangan darah sehingga menurunkan risiko perdarahan postpartum hingga 60-70%.
3. Mengurangi kejadian retensio plasenta

Langkah-langkah Manajemen Aktif Kala III:

1. Pemberian Suntikan Oksitosin: Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan oksitosin 10 I.U. IM di sepertiga paha atas bagian luar, pastikan tidak ada bayi kedua.
2. Penegangan Tali Pusat Terkendali (PTT): Setelah kontraksi, tegangkan tali pusat dengan satu tangan, tangan lain mendorong rahim ke belakang atas secara hati-hati (dorso-kranial) untuk melahirkan plasenta.
3. Masase Fundus Uteri: Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase (pemijatan) pada fundus uteri dengan gerakan melingkar selama 15 detik untuk merangsang kontraksi.

C. Menilai kelengkapan plasenta/selaput

Pemeriksaan Plasenta

Setelah plasenta dan ketuban lahir, keduanya harus diperiksa untuk memastikan lengkap dan utuh. Pemeriksaan meliputi:

1. Permukaan maternal yang melekat pada dinding uterus untuk memastikan nahwa semuanya lengkap dan utuh, tidak ada bagian yang hilang (normalnya memiliki 6–20 kotiledon),
2. Pasangkan bagian-bagian plasenta yang robek atau terpisah untuk memastikan tidak ada bagian yang hilang

3. Permukaan fetal yang menghadap ke bayi, untuk memastikan tidak ada kemungkinan lobus tambahan (plasenta suksenturiata)
4. Evaluasi selaput untuk memastikan kelengkapannya

Jika ditemukan bagian plasenta yang tidak lengkap, kondisi ini disebut sisa plasenta, yang berisiko menimbulkan perdarahan hebat dan infeksi.

Tanda bahaya

Dalam kala III persalinan, bidan dan tenaga kesehatan harus waspada terhadap tanda bahaya *(red flags)* yang dapat mengindikasikan komplikasi serius seperti retensio plasenta, avulsi tali pusat, perdarahan postpartum, atau syok maternal. Setiap *red flags* memiliki makna klinis yang spesifik dan memerlukan tindakan eskalasi yang cepat dan tepat.

1. Jika setelah 15 menit melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT) dan dorongan dorso kranial plasenta belum lahir, maka perlu evaluasi ulang terhadap tanda pelepasan plasenta. Tindakan eskalasi meliputi pemberian ulang oksitosin 10 IU secara intramuskular, menunggu kontraksi yang kuat, dan mengulangi PTT serta dorongan dorso kranial. Kandung kemih harus diperiksa dan dikosongkan bila penuh.
2. Jika terjadi tanda tali pusat putus dan plasenta belum lahir, maka kemungkinan terjadi avulsi tali pusat. Kontraksi uterus harus dinilai, ibu diminta meneran, dan plasenta dilahirkan dengan bantuan PTT dan tekanan dorso kranial. Setelah plasenta lahir, dilakukan masase fundus uteri.
3. Jika tepi lateral plasenta tidak dapat diraba, selaput ketuban tidak lengkap, dan terjadi perdarahan meski uterus berkontraksi, maka kemungkinan terdapat bagian plasenta yang tertahan. Tindakan meliputi pemeriksaan dalam, pengeluaran sisa selaput dan bekuan darah, serta masase uterus. Bila perdarahan hebat terjadi, periksa kemungkinan robekan jalan lahir.
4. Jika plasenta belum lahir setelah 30 menit sejak bayi dilahirkan, maka terjadi retensio plasenta. Lakukan konseling kepada suami/keluarga dan siapkan rujukan ke fasilitas yang lebih mampu.
5. Jika plasenta belum lahir dan terjadi perdarahan mendadak, maka tindakan segera adalah mengosongkan kandung kemih dan melakukan pelahiran plasenta secara manual sesuai prosedur.
6. Jika setelah pelahiran manual plasenta terjadi perdarahan dan uterus tidak berkontraksi, maka terjadi atonia uteri. Penatalaksanaan meliputi kompresi bimanual interna/eksterna, kompresi aorta, tampon kondom-kateter, pemberian oksitosin tambahan 10 IU dan misoprostol 600 mcg per rektal.
7. Jika ibu menunjukkan tanda syok seperti nadi cepat dan lemah (>100 kali/menit), napas cepat (>30 kali/menit), tekanan darah <90 mmHg, pucat, keringat dingin,

gelisah, dan produksi urin <20 ml/jam, maka terjadi syok maternal. Tindakan eskalasi meliputi stabilisasi awal, pemberian cairan sesuai kebutuhan, pemantauan ketat, dan kolaborasi atau rujukan.

8. Jika nadi cepat >100 kali/menit dan suhu >38°C disertai keringat dingin, maka kemungkinan terjadi infeksi. Ibu dibaringkan miring kiri, diberikan rehidrasi dan antibiotik, serta dilakukan kolaborasi atau rujukan.

D. Asuhan Kebidanan Kala Tiga Persalinan

Pengkajian Data Subjektif

Ibu merasakan kontraksi

Pengkajian Data Objektif

1. Sebelum miometrium berkontraksi, uterus berbentuk bulat (diskoid) dan tinggi fundus berada 3 jari di bawah pusat
2. Setelah uterus berkontraksi, dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga/seperti buah alpukat dan TFU setinggi pusat (mengarah ke sisi kanan)
3. Tali pusat memanjang, terlihat menjulur keluar melalui vulva (tanda Ahfeld)
4. Semburan darah mendadak dan singkat.

Analisa (Kala Tiga Persalinan)

P… A… inpartu kala III, keadaan umum ibu baik, prognosa baik.

Penatalaksanaan Kala Tiga Persalinan

1. Letakkan bayi baru lahir diatas handuk/kain bersih yang telah disiapkan di perut bawah ibu, selimuti bayi dan minta ibu atau pendamping untuk membantu memegang bayi tersebut.
2. Pastikan tidak ada bayi lain *(undiagnosed twin)* didalam uterus.
3. Beritahu ibu akan disuntik.
4. Segera suntikkan oksitosin 10 IU IM di perbatasan bawah dan tengah lateral paha (aspektus lateralis). Letakkan alat suntik pada tempatnya
5. Keringkan bayi, ganti dengan kain bersih dan kering, kemudian lakukan penjepitan dan potong tali pusat (2-3 menit setelah bayi lahir). Ikat erat tali pusat.
6. Lakukan inisiasi menyusu dini (IMD) kontak kulit ke kulit, selimuti ibu dan bayi.
7. Tutup kembali perut bawah ibu dengan kain bersih.
8. Melakukan penegangan tali pusat terkendali (PTT)
   a. Berdiri disamping ibu. Pindahkan klem sekitar 5-10 cm dari vulva
   b. Letakkan tangan yang lain pada abdomen ibu (beralaskan kain) tepat diatas simpisis pubis. Gunakan tangan ini untuk meraba kontraksi uterus dan menekan uterus pada saat melakukan PTT. Setelah terjadi kontraksi yang kuat, tegangkan tali pusat dengan satu tangan dan tangan lain (pada dinding abdomen) menekan uterus secara dorso cranial.

c. Bila plasenta belum lepas, tunggu hingga uterus berkontraksi kembali (sekitar dua atau tiga menit berselang) untuk mengulangi kembali PTT.
d. Saat mulai kontraksi (uterus menjadi bulat atau tali pusat menjulur) tegangkan tali pusat ke arah bawah, lakukan tekanan dorso kranial hingga tali pusat makin menjulur dan korpus uteri bergerak keatas yang menandakan plasenta telah lepas dan dapat dilahirkan.
e. Jika plasenta tidak turun setelah 30-40 detik sejak dimulainya PTT dan tidak ada tanda-tanda lepasnya plasenta, jangan teruskan PTT.
   1) Tunggu kontraksi berikutnya, pindahkan klem lebih dekat ke perineum
   2) Pada saat kontraksi berikutnya terjadi, ulangi PTT dan tekanan dorso kranial pada korpus secara serentak. Lakukan pada setiap kontraksi hingga terasa plasenta terlepas dari dinding uterus.
   3) Jika setelah 15 menit melakukan PTT dan dorongan dorso cranial, plasenta belum lahir, ulangi pemberian oksitosin 10 IU IM. Tunggu kontraksi yang kuat kemudian ulangi PTT dan dorso cranial hingga plasenta dapat dilahirkan.
   4) Setelah plasenta terlepas dari dinding uterus (uterus globuler, tali pusat menjulur keluar), anjurkan ibu meneran, bantu kelahiran plasenta dengan menegangkan dan mengarahkan tali pusat sejajar lantai (mengikuti poros jalan lahir). Jangan melakukan PTT tanpa diikuti tekanan dorso cranial secara serentak pada bagian bawah uterus (simfisis pubis).
f. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lahirkan plasenta. Pegang plasenta dengan kedua tangan, putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin jadi satu.
g. Lakukan penarikan lembut dan perlahan-lahan untuk melahirkan selaput ketuban.

9. Melakukan rangsangan taktil (masase) fundus uteri
   a. Letakkan telapak tangan pada fundus uteri.
   b. Dengan lembut tapi mantap gerakkan tangan dengan arah memutar pada fundus uteri supaya uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi dalam waktu 15 detik, lakukan penatalaksanaan atonia uteri.
   c. Periksa plasenta dan selaputnya untuk memastikan lengkap dan utuh.
10. Periksa kembali uterus setelah 1-2 menit. Jika uterus belum berkontraksi dengan baik, ulangi masase. Ajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus.
11. Periksa kontraksi uterus tiap 15 menit selama 1 jam pertama dan setiap 30 menit selama 1 jam kedua.
12. Catat semua pemeriksaan dan intervensi.

Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Identifikasi tanda persalinan kala III, risiko

Skenario klinik:

Seorang perempuan usia 22 tahun, P1A0, berada di PONED, melahirkan bayi laki-laki cukup bulan pada pukul 08.00. Bayi lahir dengan menangis kuat dan gerak aktif. Hasil pemeriksaan: keadaan umum baik, TD 120/80 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi pusat, uterus teraba bundar dan keras, tali pusat tampak di depan vulva.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa data fokus pada ibu yang tepat sesuai kasus di atas?
2. Apa diagnosis kasus di atas?
3. Apa tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus idi atas?
4. Apa tujuan utama tindakan bidan pada kasus di atas?
5. Apa risiko yang terjadi bila tindakan yang dilakukan bidan tidak tepat?

Rubrik Penilaian Diskusi Kala III Persalinan

Pertanyaan	Indikator Jawaban Baik (3)	Indikator Jawaban Cukup (2)	Indikator Jawaban Kurang (1)
Data fokus pada ibu	Menyebutkan lengkap: TFU, uterus, tali pusat, tanda vital	Menyebutkan sebagian data fokus	Tidak menyebutkan data focus
Diagnosis kasus	Kesesuaian diagnosis dengan kondisi ibu (P… A…, kala III, plasenta belum lahir, keadaan umum ibu…, prognosa…)	Menyebutkan sebagian diagnosis	Tidak menyebutkan diagnosis
Tindakan bidan	Menyebutkan lengkap: uterotonika, tarikan tali pusat terkendali, masase uterus	Menyebutkan sebagian tindakan	Tidak menyebutkan atau salah tindakan
Tujuan utama tindakan	Menyebutkan lengkap: **Memperpendek durasi kala III** menjadi sekitar **5-15 menit, mencegah perdarahan dengan** memastikan rahim berkontraksi	Menyebutkan sebagian tujuan	Tidak menyebutkan tujuan atau tidak relevan

	dengan baik untuk mengurangi kehilangan darah sehingga menurunkan risiko perdarahan postpartum hingga **60-70%, m**engurangi kejadian retensio plasenta		
Risiko bila tindakan tidak tepat	Menyebutkan perdarahan postpartum, retensio plasenta, syok, infeksi	Menyebutkan sebagian risiko	Tidak menyebutkan risiko

Skor Total

- **15 poin:** Sangat baik
- **11-14 poin:** Baik
- **6-10 poin:** Cukup
- **≤5poin:** Kurang

Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab persalinan kala III

Fokus urutan prosedur tindakan, komunikasi dan keselamatan pasien

E. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan: Kala III
3	Kasus	Manajemen aktif Kala III
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 22 tahun, P1A0, berada di PONED, melahirkan bayi laki-laki cukup bulan pada pukul 08.00. Bayi lahir dengan menangis kuat dan gerak aktif. Hasil pemeriksaan: keadaan umum baik, TD 120/80 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi pusat, uterus teraba bundar dan keras, tali pusat tampak di depan vulva. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan prosedur tindakan yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga sesuai kasus.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen, penguji memberikan data: TFU setinggi pusat, uterus teraba bundar dan keras 3. Prosedur tindakan yang diharapkan dari peserta meliputi: - Pemberian Suntikan Oksitosin: Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha atas bagian luar, pastikan tidak ada bayi kedua. - Penegangan Tali Pusat Terkendali (PTT): Setelah kontraksi, tegangkan tali pusat dengan satu tangan, tangan lain mendorong rahim ke belakang atas secara hati-hati (dorso-kranial) untuk melahirkan plasenta. - Masase Fundus Uteri: Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase (pemijatan) pada fundus uteri dengan gerakan melingkar selama 15 detik untuk merangsang kontraksi. - Menilai kelengkapan plasenta/selaput - Memberikan KIE singkat

No.	Komponen	Isi
		4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu inpartu kala III. 2. PS tampak cemas dan lelah. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.
9	Dialog PS	**Peserta:** "Selamat pagi Ibu" **PS:** "Pagi bu" **Peserta:** "Ibu, selamat ya, bayi Ibu telah lahir dengan sehat selamat, bagaimana perasaan Ibu saat ini?" **PS:** "Alhamdulillah, saya merasa lega. Tidak ada keluhan, hanya sedikit lelah." **Peserta:** "Baik, saya akan memeriksa kondisi Ibu. Tekanan darah, nadi, dan suhu Ibu normal. Uterus terasa keras, dan tali pusat sudah tampak di depan vulva. Apakah Ibu merasakan nyeri perut atau perdarahan yang banyak?" **PS:** "Tidak, Bu. Perut terasa kencang, tapi tidak terlalu sakit. Darah keluar sedikit saja."

No.	Komponen	Isi
		Peserta: "Bagus sekali. Saat ini Ibu berada pada tahap kala III, yaitu masa pengeluaran plasenta. Saya akan membantu agar plasenta keluar dengan aman. Saya akan memberikan suntikan oksitosin untuk membantu kontraksi rahim, kemudian melakukan pijatan lembut pada perut Ibu, dan menarik tali pusat dengan hati-hati. Apakah Ibu bersedia?" **PS:** "Iya, Bu. Saya siap." **Peserta:** "Terima kasih, Ibu. Mohon tetap rileks dan tarik napas perlahan. Setelah plasenta keluar, saya akan memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Hal ini penting untuk mencegah perdarahan. Setelah itu, Ibu bisa segera menyusui bayi agar ikatan lebih kuat dan membantu rahim berkontraksi." **PS:** "Baik, Bu. Saya mengerti." **Peserta:** "Jika nanti di rumah Ibu mengalami perdarahan banyak, demam, atau nyeri perut yang hebat, segera kembali ke fasilitas kesehatan. Untuk saat ini, mari kita lanjutkan dengan inisiasi menyusu dini." **PS:** "Baik, Bu. Saya mengerti." Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait tanda gejala persalinan kala III, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	Manikin panggul yang didalamnya terdapat boneka bayi yang terhubung dengan model plasenta, dialasi underpad dan diselimuti kain.
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan

No.	Komponen	Isi
		- Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom panggul/serviks — 1 3. Lembar partograf kasus — 1 set 4. Tensimeter — 1 5. Stetoskop — 1 6. Jam tangan/stopwatch — 1 7. Termometer — 1 8. Sarung tangan bersih — 1 pasang 9. Handrub — 1 botol 10. Kain penutup/selimut — 1 11. Infus set dummy — 1 set 12. Cairan RL/NaCl dummy — 1 13. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 14. Pena — 1
13	Penulis	Bdn. Nana Usnawati, S.S.T., M.Keb.
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan 2. World Health Organization, USAID. (2012). Active Management of the Third Stage of Labour New WHO Recommendations Help to Focus Implementation 3. Adriaansz, G. (2017). Asuhan Persalinan Normal. Asuhan Esensial bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir serta Penatalaksanaan Komplikasi Segera Pascapersalinan dan Nifas. Jakarta: JNPK-KR

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Persalinan Kala III

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan anamnesis		
3. Menyakan riwayat obstetric singkat (G… P… A...)		
4. Menanyakan riwayat persalinan sekarang (waktu persalinan, lama persalinan, kondisi bayi saat lahir)		
5. Menanyakan keluhan ibu setelah melahirkan (perdarahan, kontraksi rahim, lemah, pusing)		
6. Menanyakan riwayat kesehatan umum (riwayat penyakit, alergi obat/makanan)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–6 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Merumuskan diagnosa/masalah

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Merumuskan P… A…		
2. Merumuskan persalinan kala III		
3. Merumuskan keadaan umum ibu …		
4. Merumuskan prognosa		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **4 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3 dari 4 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 4 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 3. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah pemberian suntikan oksitosin		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menempatkan bayi diatas handuk bersih diatas perut ibu dan mengeringkan dengan cepat untuk menstimulasi bayi menangis		
d. Secara lembut melakukan palpasi abdomen dengan dialasi kain bersih untuk memastikan tidak ada janin lain/*undiagnosed twin* (jika kembar Jangan melakukan MAK III sampai bayi kedua lahir)		
e. Memberitahu ibu akan disuntik		
f. Menyuntikkan oksitosin 10 IUIM segera (1 menit setelah bayi lahir)		
g. Meletakkan alat suntik pada tempatnya, ganti kain alas dan penutup tubuh bayi dengan kain bersih dan kering yang baru kemudian lakukan penjepitan (2-3 menit setelah bayi lahir) dan pemotongan tali pusat		
h. Memberikan bayi yang telah terbungkus pada ibu, untuk IMD kontak kulit-kulit dengan ibu dan selimuti ibu-bayi dengan kain		
i. Tutup kembali perut bawah ibu dengan kain bersih		
3. Langkah-langkah penegangan tali pusat terkendali (PTT)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
a. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva		
b. Meletakkan tangan lain pada perut ibu (beralaskan kain) tepat diatas simfisis pubis untuk meraba kontraksi uterus dan menekan uterus saat PTT. Tangan yang lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat		
c. Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang-atas (dorso-kranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversio uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami atau anggota keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu.		
d. Bila pada penekanan bagian bawah dinding deoan uterus kea rah dorsal ternyata diikuti dengan pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. ▪ Ibu boleh meneran, tapi talipusat hanya ditegangkan sesuai sumbu jalan lahir ▪ Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta ▪ Jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat: 1) Beri dosis ulangan oksitosin 10 unit IM 2) Lakukan kateterisasi (aseptic) jika kandung kemih penuh 3) Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan 4) Ulangi tekanan dorso kranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya 5) Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit setelah bayi lahir atau		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
bila terjadi perdarahan, segera lakukan plasenta manual		
e. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempat plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal		
4. Langkah-langkah rangsangan taktil/masase uterus		
a. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakkan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras). Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masase		
b. Periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus		
c. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.		
5. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada partograf/catatan medis		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **17–26 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **8–16 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–7 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 4. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan yang sedang/akan dilakukan		
4. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **4 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3 dari 4 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 4 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 5. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama asuhan		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 5

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 + 5 / 5

(dicatat di rubrik penilaian)

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{135} \times 100 = \text{------}$$

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

(Kota), ...

.....

Penguji:.....

Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)* pada Persalinan Kala III

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
Metode penilaian	*DOPS* merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup *informed consent*, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian pada ibu inpartu kala III, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan pertolongan persalinan kala III/manajemen aktif kala III.
Tujuan penilaian	Tujuan *DOPS* pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan manajemen aktif kala III yang aman, tepat, dan sistematis pada persalinan normal, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan intrapartum yang evidence-based, woman-centred, dan pemantauan kemajuan persalinan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang manajemen aktif kala III, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu, mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pada pertolongan persalinan kala III/manajemen aktif kala III,	Seorang perempuan usia 22 tahun, P1A0, berada di PONED, melahirkan bayi laki-laki cukup bulan pada pukul 08.00. Bayi lahir dengan menangis kuat dan gerak aktif. Hasil pemeriksaan: keadaan umum baik, TD 120/80

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
	identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal.	mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi pusat, uterus teraba bundar dan keras, tali pusat tampak di depan vulva.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada *DOPS*, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu, mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE yang aman untuk dilakukan di fasilitas Kesehatan primer.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan. Pada persalinan kala III, WHO menekankan identifikasi	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa dengan tepat mengenali mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
	tanda, dan langkah manajemen aktif kala III.	kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE.
Umpan balik	Umpan balik dalam *DOPS* diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form *DOPS* juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, dan memberikan edukasi/KIE, tetapi masih perlu meningkatkan ketepatan dalam mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III.
Keputusan penilaian	Hasil *DOPS* dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali tanda gejala kala III, gagal merumuskan diagnose, gagal melakukan prosedur tindakan kala III, gagal mengenali risiko/tanda bahaya dan gagal memberikan edukasi/KIE dengan benar.

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
Makna dalam OBE	*DOPS* memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level *does* karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan *DOPS* sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus pertolongan persalinan kala III, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

1. *OSCE* + *DOPS*
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi *patient safety*
4. Feedback CI/dosen

Tabel. Portofolio pada Persalinan Kala III

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Persalinan Kala III, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu bersalin pada Kala III, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan *DOPS*	*OSCE* dan *DOPS* dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	*OSCE* dapat memuat hasil ujian keterampilan mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III dan memberikan edukasi/KIE. *DOPS* memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
		identifikasi tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III dan memberikan edukasi/KIE di ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus: Seorang perempuan usia 22 tahun, P1A0, berada di PONED, melahirkan bayi laki-laki cukup bulan pada pukul 08.00. Bayi lahir dengan menangis kuat dan gerak aktif. Hasil pemeriksaan: keadaan umum baik, TD 120/80 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi pusat, uterus teraba bundar dan keras, tali pusat tampak di depan vulva, tindakan yang dilakukan, dan *follow up*.
Refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya identifikasi tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III dan memberikan edukasi/KIE, yang tepat dengan keluarga.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari *Clinical Instructor (CI)* atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
	area yang masih perlu ditingkatkan.	kala III, dan memberikan edukasi/KIE, tetapi masih perlu meningkatkan ketepatan dalam mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus persalinan kala III, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III dan memberikan edukasi/KIE, secara tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil *OSCE, DOPS*, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III dan memberikan edukasi/KIE.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik persalinan kala III, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Persalinan Kala III

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
Hakikat *case report*	*Case report* merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, *case report* berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu bersalin primi kala III.
Tujuan	*Case report* bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III dan memberikan edukasi/KIE.
Isi laporan	Isi *case report* biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan: ibu P1A0, berada di PONED, melahirkan bayi laki-laki cukup bulan pada pukul 08.00. Bayi lahir dengan menangis kuat dan gerak aktif. Keadaan umum baik, TD 120/80 mmHg, nadi 88 x/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi pusat, uterus teraba bundar dan keras, tali pusat tampak di depan vulva. Analisis: P1A0 persalinan kala III, keadaan umum ibu baik, prognosa baik. Tindakan: manajemen aktif kala III.

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.
Nilai edukatif	*Case report* membantu mahasiswa mengembangkan *clinical reasoning*, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus persalinan kala III, mahasiswa belajar bahwa mengenali tanda gejala kala III, merumuskan diagnose, melakukan prosedur tindakan kala III, mengenali risiko/tanda bahaya dan memberikan edukasi/KIE secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik merupakan bagian inti keselamatan dalam asuhan persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, *case report* menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep persalinan kala III, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Persalinan Kala III

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
Hakikat refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menunjukkan	Pada kasus persalinan kala III, mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan prosedur manajemen

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
	kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	aktif kala III dapat membahayakan kondisi ibu.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah prosedur urutan manajemen aktif kala III, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah perdarahan postpartum, retensio plasenta, syok dan infeksi bila manajemen aktif kala III tidak dilaksanakan dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain perdarahan postpartum, retensio plasenta, syok, infeksi.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan identifikasi tanda gejala kala III, manajemen aktif kala III secara konsisten dan benar, mengenali risiko/tanda bahaya kala III, pemantauan tanda vital dan edukasi/KIE yang tepat kepada keluarga.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan	Mahasiswa menyadari bahwa pada persalinan kala III, identifikasi tanda gejala kala III, manajemen aktif kala III secara

Komponen	Deskripsi	Kasus Persalinan Kala III
	memengaruhi praktik berikutnya.	konsisten dan benar, mengenali risiko/tanda bahaya kala III, pemantauan tanda vital dan edukasi/KIE yang tepat adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi *patient safety* menunjukkan perkembangan sikap professional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengenali risiko/tanda bahaya dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

F. Ringkasan

Kala III persalinan atau kala uri adalah tahap setelah bayi lahir hingga keluarnya plasenta beserta selaput ketuban. Tahap ini berlangsung sekitar 5–15 menit dan menjadi fase penting karena berhubungan langsung dengan risiko perdarahan postpartum. Secara fisiologis, pelepasan plasenta terjadi melalui kontraksi uterus yang menyusutkan rongga rahim sehingga area perlekatan mengecil, plasenta menebal, terlipat, lalu terlepas. Tanda klinis pelepasan meliputi perubahan bentuk uterus, tali pusat memanjang (tanda Ahfeld), serta semburan darah singkat. Setelah lepas, darah retroplasenta mendorong plasenta keluar melalui vagina bersama selaput ketuban.

Untuk mencegah komplikasi, dilakukan **Manajemen Aktif Kala III (MAK III)** yang terdiri dari tiga langkah utama: pemberian oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali (PTT), dan masase fundus uteri. Tujuan MAK III adalah mempercepat keluarnya plasenta, memastikan kontraksi uterus yang adekuat, serta menurunkan risiko perdarahan postpartum hingga 60–70%. Setelah plasenta lahir, bidan wajib memeriksa kelengkapan plasenta dan selaput ketuban, karena sisa jaringan dapat menimbulkan perdarahan hebat maupun infeksi.

Dalam praktik kebidanan, kala III memerlukan pengkajian kontraksi, perubahan bentuk fundus, pemanjangan tali pusat, serta semburan darah singkat. Penatalaksanaan mencakup pemberian oksitosin, pemotongan tali pusat, inisiasi menyusu dini, PTT sesuai kontraksi, dan masase fundus uteri. Semua intervensi harus dicatat, dengan pemantauan kontraksi uterus secara berkala.

Kala III adalah tahap kritis persalinan yang menuntut manajemen aktif, pemeriksaan plasenta yang teliti, serta pemantauan uterus berkesinambungan untuk menjamin keselamatan ibu.

Alur asuhan singkat

Ibu inpartu kala III → **inisiasi menyusu dini (IMD)** dan meletakkan bayi di perut ibu → diberikan **oksitosin 10 IU intramuskular** untuk merangsang kontraksi → dilakukan **penegangan tali pusat terkendali (PTT)** → plasenta dan selaput ketuban lahir → **masase fundus uteri** untuk memastikan kontraksi uterus tetap kuat → plasenta dan selaput diperiksa kelengkapannya → **pemantauan kontraksi uterus** secara berkala.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Persalinan Kala III: Manajemen Aktif, Penilaian Plasenta dan Pencegahan Perdarahan

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Jika setelah 15 menit melakukan PTT dan dorongan dorso kranial, plasenta belum juga lahir.	Perlu evaluasi lebih lanjut terhadap tanda pelepasan plasenta	Ulangi pemberian oksitosin 10 I.U. secara IM, tunggu kontraksi yang kuat lalu ulangi PTT, dan dorongan dorso kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Cek kandung kemih, bila penuh lakukan pengosongan kandung kemih.
Jika terjadi tanda gejala tali pusat putus dan plasenta tidak lahir	Avulsi tali pusat (putus)	Nilai kontraksi uterus, minta ibu meneran jika ada kontraksi. Lahirkan plasenta dengan PTT dan tekanan dorso kranial, lakukan masase setelah plasenta lahir.
Jika tepi lateral plasenta tidak dapat diraba/dikenali, selaput ketuban tidak lengkap, terdapat kontraksi uterus dan terjadi perdarahan	Terdapat bagian plasenta yang tertahan	Lakukan periksa dalam, keluarkan selaput ketuban dan bekuan darah yang mungkin masih tertinggal, lakukan masase uterus. Jika ada perdarahan hebat dan uterus berkontraksi, periksa adanya robekan jalan lahir
Jika plasenta belum lahir setelah 30 menit sejak bayi dilahirkan	Terjadi retensio plasenta	Lakukan konseling pada suami/keluarga dan siapkan rujukan ke fasilitas yang lebih mampu
Jika plasenta belum lahir dan mendadak terjadi perdarahan	Terjadi retensio plasenta	Kosongkan kandung kemih dan lakukan manual plasenta sesuai prosedur
Jika setelah manual plasenta terjadi perdarahan, uterus tidak berkontraksi	Terjadi atonia uteri	Lakukan prosedur penatalaksanaan atonia uteri dengan benar. Lakukan kompresi bimanual interna/eksterna, kompresi aorta, pasang tampon kondom-kateter.

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		Beri oksitosin 10 I.U. dosis tambahan dan misoprostol tablet 600 mcg per rektal
Nadi cepat dan lemah >100 kali/menit, nafas cepat >30 kali/menit, tekanan darah sistolik <90 mmHg, pucat, keringat dingin, gelisah, produksim urine <20ml/jam	Syok maternal	Stabilisasi awal, cairan sesuai kebutuhan, pantau ketat, kolaborasi/rujukan
Nadi cepat > 100 kali/menit, suhu > 38°C, keringat dingin	Infeksi	Baringkan miring kiri, rehidrasi, berikan antibiotik, kolaborasi/rujukan

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Persalinan Kala III: Manajemen Aktif, Penilaian Plasenta dan Pencegahan Perdarahan

Awal

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi persalinan kala III	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengenali tanda gejala persalinan kala III	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu bersalin dengan persalinan kala III	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan langkah-langkah manajemen aktif kala III	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mellakukan langkah-langkah manajemen aktif kala III	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali risiko/tanda bahaya persalinan kala III	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
7	Saya sudah bisa mengambil keputusan klinik bila terjadi risiko/tanda bahaya persalinan kala III	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa melakukan edukasi/KIE setelah plasenta dilahirkan	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mendokumentasikan persalinan kala III secara ringkas dan tepat	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Daftar Pustaka

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002937822022049)

Adriaansz, G. (2017). Asuhan Persalinan Normal. Asuhan Esensial bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir serta Penatalaksanaan Komplikasi Segera Pascapersalinan dan Nifas. Jakarta: JNPK-KR

Hersh, A. R., Carroli, G., Hofmeyr, G. J., Garg, B., Gülmezoglu, M., Lumbiganon, P., De Mucio, B., Saleem, S., Festin, M. P. R., Mittal, S., Rubio-Romero, J. A., Chipato, T., Valencia, C., & Tolosa, J. E. (2024). Third stage of labor: Evidence-based practice for prevention of adverse maternal and neonatal outcomes. *American Journal of Obstetrics and Gynecology, 230*(3, Supplement), S1046–S1060.e1. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.11.1298

JNPK-KR (2014). Asuhan Persalinan Normal dan Inisiasi Menyusui Dini. JNPK-KR: Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2007). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Jakarta: Kemenkes R.I.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2013). Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kemenkes R.I.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020*. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2022). *Standar Kompetensi Kerja Bidang ebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022*. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Molla, W., Demissie, A., & Tessema, M. (2021). Active Management of Third Stage of Labor: Practice and Associated Factors among Obstetric Care Providers in North Wollo, Amhara Region, Ethiopia. *Obstetrics and gynecology international*, *2021*, 9207541. https://doi.org/10.1155/2021/9207541

National Institute for Health and Care Excellence. (2023). *Intrapartum care* (NICE Guideline NG235). Tersedia di:

https://www.nice.org.uk/guidance/ng235/chapter/Recommendations#third-stage-of-labour

Sulikah, Usnawati N, Surtinah N, Sumaningsih R. (2023). Modul Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Prodi D3 Kebidanan Magetan.

World Health Organization, USAID. (2012). Active Management of the Third Stage of Labour New WHO Recommendations Help to Focus Implementation

World Health Organization. (2021). *WHO labour care guide: User's manual*. Tersedia di: https://www.who.int/publications/i/item/9789240017566

World Health Organization. (2025). *WHO labour care guide: Implementation resource package*. Tersedia di: https://www.who.int/publications/i/item/9789240109346

BAB 2

ASUHAN PERSALINAN KALA IV PEMANTAUAN, DETEKSI DINI SYOK DAN STABILITAS IBU

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.	CPMK-7; CPMK-4; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan persalinan dan situasi kegawatdaruratan intrapartum.
CPMK-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed consent, dan kolaborasi interprofesional pada asuhan dan rujukan intrapartum.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan keselamatan ibu-bayi melalui PPI, K3, pemantauan terstruktur, dan manajemen risiko intrapartum.
CPMK-4	Melakukan pengkajian komprehensif ibu bersalin dan kesejahteraan janin serta menafsirkan temuan untuk penetapan masalah/prioritas.
CPMK-5	Merencanakan dan melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV berbasis bukti termasuk dukungan, kenyamanan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.
CPMK-6	Melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan intrapartum dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan kondisi klinis.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi klinis (termasuk partograf) dan dokumen rujukan secara akurat serta menggunakan data untuk evaluasi mutu.

Uraian Materi

A. Konsep Asuhan Kala IV

1. Pengertian

Kala pengawasan 1-2 jam setelah bayi dan plasenta lahir. Kala IV dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam postpartum. Pada kala IV pemantauan dan observasi harus dilakukan karena perdarahan postpartum sering terjadi pada 2 jam pertama setelah persalinan (Yulizawati dkk, 2019)

Kala IV adalah kala pemantauan atau observasi setelah melahirkan yang dilakukan setiap 15 menit pada satu jam pertama pasca persalinan, dan 30 menit pada satu jam berikutnya. Kontraksi uterus merupakan hal yang perlu diperhatikan sampai uterus Kembali dalam bentuk normal. Agar uterus berkontraksi dengan baik dan kuat maka dilakukan rangsangan taktil (masase). Plasenta telah lahir lengkap juga perlu dipastikan tidak ada bagian yang tertinggal atau tersisa sedikitpun dalam uterus sehingga perdarahan lanjut benar benar di pastikan tidak terjadi. (Kunang.S, 2023)

Kala IV dimulai dari lahirnya plasenta selama 1-2 jam atau kala/fase setelah plasenta dan selaput ketuban dilahirkan sampai dengan 2 jam post partum. Tujuan utama dari kala ini adalah untuk melakukan observasi sebab perdarahan postpartum yang paling sering terjadi dalam 2 jam pertama. Selama perdarahan darah yang keluar harus ditakar sebaik baiknya. Luka pada saat pelepasan plasenta dan robekan pada serviks dan perineum merupakan penyebab dari kehilangan darah pada persalinan. Jumlah darah yang dikatakan normal yaitu rata rata 250cc. Apabila perdarahan lebih dari 500cc maka dianggap hal yang tidak normal sehingga perlu dicari penyebabnya. (Wijayanti, Irfana Tri., 2022)

Kala observasi yang berlangsung dalam 2 jam pertama pasca persalinan merupakan masa krisis bagi ibu, karena merupakan periode kehilangan darah yang sangat beresiko terhadap kematian. Bidan harus memantau seluruh keadaan dan kebutuhan ibu sampai masa kritis telah terlewati. (Yolanda, 2025)

Pada kala IV ibu juga akan mengalami perubahan suasana hati hal ini terjadi karena pada masa ini hormon hormon ibu dilepaskan selama proses persalinan seperti oksitosin dan endorphin sehingga beberapa ibu akan mengalami kelelahan. Adapun pada pemeriksaan yang dilakukan pada kala IV ini meliputi pemeriksaan tekanan darah, detak jantung, perdarahan dan kemungkinan komplikasi pasca persalinan akan terus dipantau tenaga medis. Jika ibu mengalami robekan perineum atau episiotomy selam persalinan, perawatan lanjutan akan diberikan pada luka tersebut.

2. Tujuan

Kala IV persalinan disebut sebagai kala pengawasan atau masa pemulihan awal, karena tubuh ibu mulai Kembali pada kondisi sebelum hamil (homeostatis). Tujuan utama kala IV persalinan adalah untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi melalui pemantauan intensif. Secara rinci adapun tujuan kala IV persalinan adalah:

a. Mencegah perdarahan postpartum
   Memastikan uterus berkontraksi dengan baik agar perdarahan dapat diminimalisir. Perdarahan merupakan penyebab utama kematian ibu, terutama akibat atonia uteri (Rahim tidak berkontraksi dengan baik)
b. Memastikan kontraksi uterus adekuat
   Kontraksi uterus penting untuk menghentikan perdarahan dan mengembalikan ukuran Rahim (involusi uterus)
c. Memantau tanda tanda vital ibu
   Pemantauan tanda tanda vital merupakan salah satu deteksi dini kegawatdaruratan, tanda vital ini meliputi tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan.
d. Mengidentifikasi komplikasi dini
   Deteksi komplikasi adalah perdarahan postpartum, retensio plasenta, syok hipovolemik dan infeksi nifas.
e. Mendukung adaptasi ibu dan bayi
   Memastikanbahwa ibu dalam kondisi stabil dan aman sehingga mendukung proses adaptasi ibu dan bayi meliputi inisiasi menyusu dini, kontak kulit ibu dan bayi dan ikatan emosional awal.
f. Evaluasi jalan lahir
   Untuk mencegah infeksi dan memastikan penyembuhan luka perineum/episiotomy.(Odi L., Namangdjabar, 2023)

3. Durasi

Lama kala IV Adalah sekitar 1-2 jam setelah persalinan. Durasi ini dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ± 2 jam postpartum. Kala IV merupakan fase kritis karena 2 jam pertama adalah masa yang memiliki resiko tinggi terjadinya komplikasi, memerlukan observasi ketat (setiap 15-30 menit) apabila terjadi kesalahan dalam pemantauan dapat berakibat fatal. (JNPKR, 2017)

4. Perubahan Fisiologi kala IV

a. Tanda vital
   Dalam 2 jam pertama setelah persalinan. Tekanan darah, nadi dan pernafasan akan berangsur angsur kembali normal. Pemantauan tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu dan pernafasan), kontraksi uterus, kandung kemih,

pengeluaran darah pada kala IV dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Pemeriksaan suhu dilakukan 2 kali selama 2 jam masing masing setiap 1 jam.

1) Tekanan darah

Biasanya tidak berubah, akan tetapi tekanan darah berkemungkinan rendah setelah melahirkan karena adanya pendarahan. Jika tekanan darah tinggi menandakan terjadinya preeklampsia postpartum. Tekanan darah normal < 140/90 mmHg. Jika tekanan darah ibu < 90-60 mmHg dan nadi > 100 kali permenit, hal ini terjadi karena adanya demam atau pendarahan pada ibu.

2) Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali permenit. Setelah melahirkan biasanya denyut nadi akan lebih cepat, tetapi jika melebihi 100 kali permenit itu adalah hal abnormal dan ini disebabkab oleh infeksi atau pendarahan postpartum yang tertunda.

3) Suhu

Suhu sedikit meningkat, tetapi dalam batas normal (di bawah 38˚C). Jika dalam 24 jam post-partum suhu tubuh ibu pasca bersalin mencapai 38˚C atau lebih, hal ini terjadi karena dehidrasi atau infeksi sebelum persalinan.

4) Pernafasan

Jika suhu tubuh dan denyut nadi normal, maka pernapasan akan normal. Pernapasan normal, teratur, dengan frekuensi 16- 20 kali per menit, kecuali ada gangguan khusus pada sistem pernapasan.(Herlina, Nina., 2025)

b. Gemetar

Gemetar terjadi akibat hilangnya ketegangan dan sejumlah energi selama melahirkan dan merupakan respon fisiologis terhadap penurunan volume intraabdominal serta pergeseran hematologi.

c. Sistem gastrointestinal

Selama 2 jam pascapersalinan kadang pasien merasa mual dan muntah, atasi hal ini dengan posisi tubuh yang memungkinkan dapat mencegah terjadinya aspirasi *corpus aleanum* ke saluran pernafasan dengan setengah duduk atau duduk di tempat tidur. Berikan minum untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

d. Sistem renal

Selama 2-4 jam pascapersalinan kandung kemih masih dalam keadaan hipotonik akibat adanya alostaktis, sehingga sering dijumpai kandung kemih dalam keadaan penuh dan mengalami pembesaran. Hal ini disebabkan adanya tekanan pada kandung kemih dan uretra selama persalinan.

e. Sistem kadiovaskular

Selama kehamilan, volume darah normal digunakan untuk menampung aliran darah yang meningkat yang diperlukan oleh plasenta dan pembuluh darah uterus. Pada persalinan pervagina kehilangan darah sekitar 200-500ml, sedangkan pada persalinan SC pengeluaran dua kali lipat. Perubahan terdiri dari volume darah dan kadar hematokrit.

f. Serviks

Perubahan pada serviks terjadi setelah bayi lahir, bentuk serviks menganga seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uterus yang dapat berkontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah olah pada perbatasan antara korpus dan serviks terbentuk seperti cicin.

1) Selama persalinan, serviks melembut (proses ripening) dan mengalami penipisan atau pemendekan (effacement). Pada kala IV, serviks mulai kembali ke konsistensi yang lebih keras. Namun, tidak langsung kembali sepenuhnya pada fase ini. Smith et al. (2020) dalam jurnal Reproductive Biology menyatakan bahwa kontraksi yang terjadi akibat pengaruh hormon oksitosin membantu proses penutupan serviks pada tahap ini. Serviks secara bertahap akan kembali ke konsistensi yang lebih keras, namun tetap elastis hingga beberapa minggu setelah persalinan.
2) Segera setelah kelahiran, serviks bersifat patulkus, terkulai dan tebal.
3) Setelah persalinan ostium uteri eksterna (OUE) dapat dimasuki 2-3 jari tangan, serviks masih terbuka sekitar 2-3 cm dan akan menutup lebih lanjut dalam 1 minggu. Serviks baru benarbenar kembali ke bentuk semula setelah 6 minggu postpartum. (Cunningham et al, 2022)
4) Selama persalinan, serviks mungkin mengalami trauma mikro atau robekan kecil akibat dilatasi yang maksimal. Pada kala IV, proses penyembuhan dimulai dengan pembentukan jaringan parut mikro dan pemulihan struktur serviks.
5) (Afiyanti, Y., & Ratnawati, 2019)Khan et al. (2021) dalam Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine menyatakan bahwa pada kala IV, sel-sel epitel serviks mengalami regenerasi, yang didorong oleh peningkatan sirkulasi darah ke area tersebut. Jaringan parut mikro terbentuk untuk memperbaiki trauma selama persalinan.

g. Perineum

Setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Pada hari ke 5 pascapersalinan, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya sekalipun tetap lebih kendur dibandingkan keadaan sebelum hamil.

Perineum adalah area antara vagina dan anus yang sering kali mengalami robekan atau dilakukan episiotomi selama persalinan. Pada kala IV, perineum mengalami fase pemulihan setelah trauma. Jika ada robekan derajat ringan hingga berat atau episiotomi, perineum memerlukan perawatan dan waktu penyembuhan. (Afiyanti, Y., & Ratnawati, 2019)

h. Vulva dan vagina

Vulva vagina mengalami penekanan serta peregagan yang sangat besar selama proses melahirkan, dan dalam beberapa hari pertama sesuadah proses tersebut kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. Selama 3 minggu vulva dan vagina Kembali kepada keadaan tidak hamil.

Selama proses persalinan, vagina mengalami edema dan pembengkakan akibat trauma fisik dari kelahiran. Pada kala IV, pembengkakan mulai berkurang. Gibbs et al. (2022) dalam *Contemporary Obstetrics and Gynecology* menjelaskan bahwa kontraksi uterus yang berlanjut pada kala IV membantu mengurangi aliran darah yang berlebihan ke area vagina, yang berperan dalam pengurangan edema. Hormon estrogen yang berkurang setelah kelahiran menyebabkan penurunan produksi pelumas alami di vagina. Hal ini bisa membuat vagina lebih kering pada masa postpartum akan mempengaruhi libido.

i. Pengeluaran ASI

Dengan penurunnya hormon estrogen, progesterone dan Human Placenta Lactogen Hormon setelah plasenta lahir, prolactin dapat berfungsi membentuk air susu ibu (ASI) dan mengeluarkannya ke dalam alveoli bahkan sampai ductus kelenjar ASI.

j. Evaluasi Uterus

1) Konsistensi

Setelah plasenta lahir, dilakukan evaluasi konsistensi uterus sambil melakukan masase untuk mempertahankan kontraksinya. Kontraksi uterus pada periode ini dipicu oleh hormon oksitosin. Involusi adalah proses di mana uterus kembali ke ukuran dan posisi semula sebelum kehamilan. Pada Kala IV, uterus mulai mengalami proses involusi ini secara bertahap. Beberapa perubahan yang terjadi selama involusi meliputi:

a) Penurunan ukuran uterus: Setelah melahirkan, uterus memiliki berat sekitar 1.000 gram. Namun, dalam 6 minggu, berat uterus menurun menjadi sekitar 50-100 gram.

b) Penurunan tinggi fundus uteri: awal Kala IV, fundus uteri (puncak rahim) berada di sekitar pusar. Dalam beberapa jam hingga hari, fundus akan

turun sekitar 1 cm per hari, hingga akhirnya tidak teraba pada minggu kedua.

c) Degradasi jaringan: Selama involusi, jaringan otot uterus yang tidak lagi dibutuhkan mengalami autolisis, di mana protein yang membentuk serat otot uterus dipecah dan dikeluarkan melalui aliran darah dan limfatik

2) Atonia

Konsistensi uterus. Hal yang perlu diperhatikan adalah adanya riwayat atonia pada persalinan sebelumnya, status kehamilan sebagai grande atau multipara, adanya distensi yang berlebihan pada uterus misalnya adanya kehamilan kembar, polihidramnion atau makrosomia, induksi persalinan dan persalinan yang lama/memanjang.

3) Kelengkapan plasenta dan membrane

4) Status kandung kemih (Wijayanti, Irfana Tri., 2022)

Dalam studi oleh Cunningham et al. (2022), kontraksi ini disebut sebagai "*afterpains*" yang lebih kuat pada multipara (wanita yang sudah melahirkan lebih dari satu kali), karena respon uterus terhadap kontraksi menjadi lebih intens dengan setiap kelahiran.

e. Perubahan Hormonal kala IV

Beberapa hormon utama yang terlibat adalah :

1) Oksitosin: memicu kontraksi uterus yang kuat dan teratur untuk membantu menghentikan perdarahan dan mempercepat proses involusi.

2) Prostaglandin: berperan dalam memperkuat kontraksi uterus dan memastikan penyempitan pembuluh darah yang terbuka. Peningkatan kadar prostaglandin setelah persalinan membantu involusi lebih cepat.

3) Penurunan hormon progesteron dan estrogen secara dramatis setelah keluarnya plasenta juga memicu proses involusi rahim dan perubahan metabolik lainnya di tubuh ibu. Apabila bidan menetapkan bahwa tidak ada kontraksi merupakan indikasi atonia, maka segera lakukan pengkajian dan penatalaksanaan yang tepat

f. Perubahan Psikologis kala IV

Memahami proses perubahan psikologi pada kala IV persalinan penting untuk memberikan dukungan optimal kepada ibu. Berikut merupakan perubahan psikologi yang terjadi pada kala IV persalinan:

1) Perasaan Lega dan Penurunan Kecemasan

Setelah melewati proses persalinan yang intens, banyak ibu merasakan perasaan lega karena bayi telah lahir dengan selamat. Adrenalin yang meningkat selama persalinan mulai menurun, menyebabkan relaksasi dan

penurunan kecemasan. Penurunan hormon stres seperti kortisol juga berkontribusi pada stabilisasi mood.

2) Kelelahan Fisik dan Emosional

   Persalinan adalah aktivitas yang sangat melelahkan secara fisik dan emosional. Kelelahan ini dapat menyebabkan ibu merasa lemah, lesu, dan mudah tersinggung. Kurangnya tidur dan kebutuhan untuk segera merawat bayi dapat memperburuk kondisi ini, mempengaruhi kemampuan ibu untuk beradaptasi dengan peran barunya.

3) Peningkatan Ikatan Emosional dengan Bayi (Bonding)

   Proses bonding antara ibu dan bayi dipicu oleh pelepasan hormon oksitosin selama dan setelah persalinan. Kontak kulit ke kulit dan inisiasi menyusui dini memperkuat ikatan ini, meningkatkan perasaan kasih sayang dan tanggung jawab terhadap bayi. Bonding yang kuat penting untuk perkembangan emosional bayi dan kesejahteraan psikologis ibu.

4) Kecemasan Mengenai Kemampuan Mengasuh

   Ibu baru sering merasa cemas tentang kemampuan mereka dalam merawat bayi, terutama jika kurang pengalaman atau dukungan. Pendidikan dan dukungan dari tenaga kesehatan dapat membantu mengurangi kecemasan ini. Setelah melahirkan, terjadi penurunan drastis hormon estrogen dan progesteron, yang dapat menyebabkan fluktuasi suasana hati. Ibu mungkin mengalami perasaan sedih, cemas, atau mudah menangis tanpa alasan jelas, dikenal sebagai "baby blues." Kondisi ini biasanya sementara dan berlangsung beberapa hari hingga dua minggu. (Herlina, Nina., 2025)

Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan psikologis pada ibu bersalin kala IV meliputi:

1) Dukungan Sosial: Ibu yang mendapatkan dukungan emosional dan praktis dari keluarga, teman, atau petugas Kesehatan cenderung lebih mudah menyesuaikan diri secara psikologis.
2) Pengalaman Persalinan: Pengalaman persalinan yang traumatis atau tidak sesuai harapan dapat mempengaruhi kondisi mental ibu setelah melahirkan. Kondisi Fisik Pasca Persalinan: Pemulihan fisik, terutama jika terjadi komplikasi, dapat memperparah perasaan cemas atau tidak berdaya.
3) Kesejahteraan Ekonomi: Stres finansial dapat menambah beban emosional pada ibu baru

B. Pemeriksaan kala IV

1. Serviks

a. Aliran menetap atau sedikit aliran perdarahan pervaginam berwarna merah terang dari bagian atas tiap laserasi yang diamati, setelah kontraksi uterus dipastikan.
b. Persalinan cepat atau presipitatus
c. Manipulasi serviks selama persalinan
d. Dorongan maternal (meneran) sebelum dilatasi serviks lengkap
e. Kelahiran pervaginam dengan Tindakan
f. Persalinan traumatik

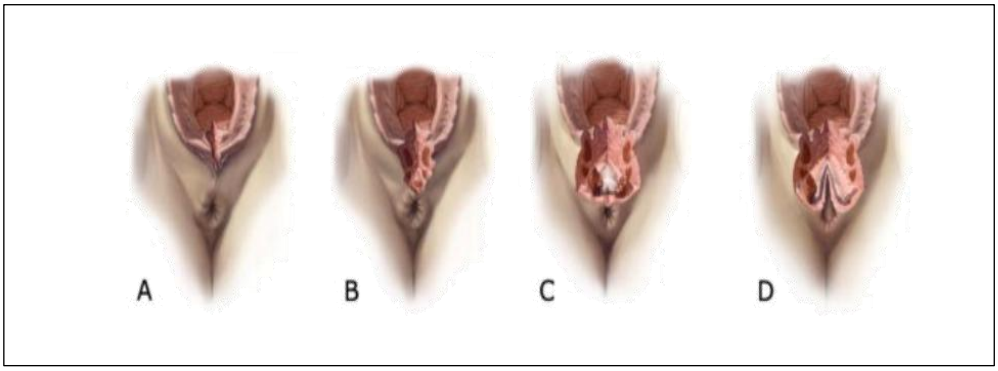
2. Vagina

Pengkajian kemungkinan robekan atau laserasi pada vagina dilakukan setelah pemeriksaan robekan serviks.

3. Perineum

Berat ringannya robekan perineum terbagi dalam empat derajat yaitu:

Derajat 1 : mukosa vagina, komisura posterior dan kulit perineum
Derajat 2 : derajat satu dan otot perineum
Derajat 3 : derajat dua dan otot sfingter ani
Derajat 4 : derajat tiga dan meluas hingga ke rectum (rujuk segera) (Afiyanti, Y., & Ratnawati, 2019)



Sumber : (JNPKR, 2017)

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Setyorini, Lilis., & Sugijati., 2024) Di Indonesia laserasi perineum dialami oleh 75% ibu melahirkan pervaginam. Pada tahun 2017 menemukan bahwa dari total 1951 kelahiran spontam pervagina, 57% ibu mendapat jahitan perineum, 28% karena episiotomi dan 29% karena robekan spontan.1 Diperkirakan 40% komplikasi terjadi pada masa post partum, dimana 25% karena infeksi jalan lahir.

Shah et al. (2020) dalam jurnal Journal of Obstetrics and Gynecology menyatakan bahwa robekan perineum atau episiotomi memerlukan waktu

penyembuhan sekitar 2-3 minggu untuk derajat ringan, robekan yang lebih dalam atau episiotomi memerlukan waktu hingga 6 minggu untuk pemulihan total.

C. Parameter pemantauan kala IV

1. Tanda vital

a. Tekanan darah dan nadi

Selama satu jam pertama pemantauan tekanan darah dan nadi setiap 15 menit dan pada pada satu jam kedua setiap 30 menit. Tekanan darah < 90/60 mmHg, jika denyut nadinya normal, tekanan darah seperti ini tidak akan terjadi masalah. Akan tetapi jika tekanan darah < 90/60 mmHg dan denyut nadinya 100 x/menit, ini mengidentifikasikan adanya suatu masalah. Mungkin ibu mengalami demam atau terlalu banyak mengeluarkan darah. Jika suhu tubuh > 38˚C, hal ini mungkin disebabkan oleh dehidrasi (persalinan yang lama dan tidak cukup minum) atau ada infeksi.

b. Respirasi dan suhu

Pemantauan respirasi dan suhu setiap jam selama dua jam pertama pascapersalinan.

2. TFU

Jika kontraksi uterus tidak baik maka uterus terasa lembek, lakukan masase uterus, bila perlu berikan injeksi oksitosin atau metargin. Pijat fundus setiap 15 menit selama satu jam pertama, setiap 30 menit selama jam berikutnya, dan kemudian, setiap jam sampai pasien siap untuk dipindahkan.

Tabel 1 Involusi, Tinggi Fundus Uteri dan Berat Uterus

Involusi	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus
Bayi Lahir	Setinggi pusat 2 jari dibawah pusat	1000gr
1 minggu	Pertengahan pusat-simfisis pubis	750gr
2 minggu	Tidak teraba diatas simfisis pubis	500gr
6 minggu	Normal	50gr
8 minggu	Normal	30gr

Sumber : (Yanti, Evi., 2025)

3. Perdarahan

Perdarahan yang normal setelah persalinan mungkin hanya akan sebanyak satu pembalut perempuan per jam, selama 6 jam pertama atau seperti darah haid yang banyak. Apakah ada laserasi pada vagina atau serviks, apakah uterus berkontraksi dengan baik, apakah kandung kemih kosong.

Pada pascapersalinan, sulit untuk menentukan terminologi berdasarkan Batasan kala persalinan dan jumlah perdarahan yang melebihi 500 ml. pada kenyataannya, sangat sulit untuk membuat determinasi batasan pascapersalinan dan akurasi jumlah perdarahan murni yang terjadi. Berdasarkan temuan diatas maka Batasan operasional untuk periode pasca persalinan adalah periode waktu setelah bayi dilahirkan. Sedangkan batasan jumlah perdarahan, hanya merupakan taksiran secara tidak langsung dimana disebutkan sebagai perdarahan abnormal yang menyebabkan perubahan tanda vital (pasien mengeluh lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil, hiperpnea, sistolik < 90 mmHg, nadi > 100 x/menit, kadar Hb < 8 g%) (Utami, Woro., & Ummah, 2024)

4. Lokia

a. Lochea rubra: berisi darah segar, sel-sel desidua dan chorion. Terjadi selama 2 hari pasca persalinan.
b. Lochea sanguinolenta: warna merah kekuningan berisi darah dan lendir. Terjadi pada hari ke 3-7 pasca persalinan.
c. Lochea serosa: berwarna kuning dan cairan ini tidak berdarah lagi. Terjadi pada hari ke 7-14 pasca persalinan.
d. Lochea alba: cairan putih, terjadi setelah 2 minggu pasca persalinan (Lestari, 2024)

5. Kandung kemih

Jika kandung kemih penuh, uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik. Jika uterus naik di dalam abdomen dan tergeser kesamping ini biasanya merupakan pertanda bahwa kandung kencingnya penuh.

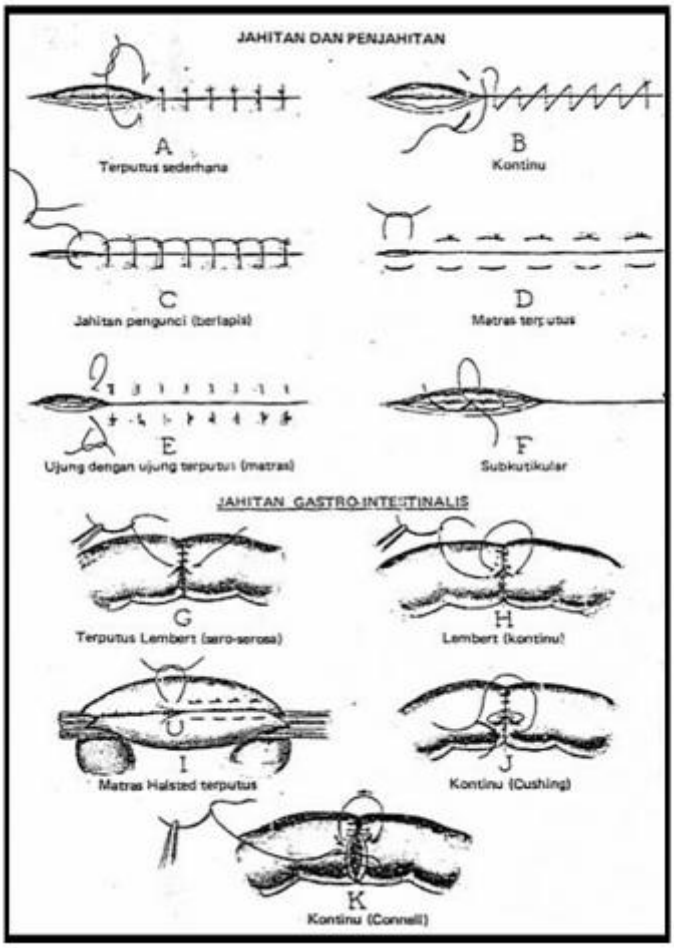
6. Keadaan Umum Ibu

a. Lakukan pemijatan uterus untuk merangsang uterus berkontaksi
b. Evaluasi tinggi fundus uterus dengan meletakkan jari tangan anda secara melintang antara pusat dan fundus uteri. Fundus uteri harus sejajar pusat atau lebih bawah.
c. Perkiraan kehilangan darah secara keseluruhan
d. Evaluasi kondisi ibu secara umum
e. Dokumentasi semua asuhan dan temuan selama kala IV persalinan di halaman belakang partograf segera setelah asuhan diberikan atau setelah penilaian dilakukan.

D. Penjahitan episiotomy dan Laserasi

Penjahitan episiotomi dan laserasi memerlukan pengetahuan anatomi perineum, tipe jahitan, hemostasis, pembedahan asepsis dan penyembuhan luka. Penjahitan perineum meiputi:

1. Ibu dalam posisi litotomi
2. Penggunaan acahaya yang terang
3. Anatomi dapat dilihat dengan jelas.
4. Tindakan cepat.
5. Teknik yang steril.
6. Bekerja hati-hati.
7. Jangan meninggalkan kasa atau kapas dalam
8. Vagina.
9. Penjelasan dan pendekatan yang peka terhadap perasaan ibuselama tindakan.
10. Tindak lanjut jangka panjang untuk menilai teknik danpemilihan bahan untuk penjahitan.



Sumber : (Yanti, Evi., 2025)

E. Memperkirakan kehilangan darah

Satu cara untuk menilai kehilangan darah adalah dengan melihat volume darah yang terkumpul dan memperkirakan berapa banyak botol 500 ml yang dapat menampung semua darah tersebut. Jika darah dapar mengisi dua botol, maka dikatakan ibu telah kehilangan 1 liter darah. Apabila perdarahan menyebabkan ibu

lemas, pusing, kesadaran menurun, serta tekanan darah sistolik turun lebih dari 10 mmHg dari kondisi sebelumnya, maka telah terjadi perdarahan lebih dari 500 ml.

Perdarahan postpartum ada kalanya merupakan perdarahan yang hebat dan menakutkan sehingga dalam waktu singkat wanita jatuh ke dalam syok, ataupun merupakan perdarahan yang menetes perlahan-lahan tetapi terus menerus dan ini juga berbahaya karena akhirnya jumlah perdarahan menjadi banyak yang mengakibatkan wanita menjadi lemas dan juga jatuh dalam syok. Perdarahan postpartum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perdarahan postpartum primer yaitu perdarahan postpartum yang terjadi dalam 24 jam pertama kelahiran. Penyebab utama perdarahan postpartum primer adalah atonia uteri, retensio plasenta, sisa plasenta, robekan jalan lahir, dan inversio uteri.
2. Perdarahan postpartum sekunder yaitu perdarahan postpartum yang terjadi setelah 24 jam pertama kelahiran. Perdarahan postpartum sekunder disebabkan oleh infeksi, penyusutan rahim yang tidak baik, atau sisa plasenta yang tertinggal (Fegita & Satria, 2018)

Tanda Gejala	Diagnosis	Penatalaksanaan
Uterus tidak berkontraksi dan lembek	Atonia uteri	- Kompresi bimanual internal selama 5 menit jika ada kontraksi lanjut 2 menit jika tidak ada kontraksi lanjutan kompresi bimanual eksternal kemudian injeksi ergometrin 0,2 ml dan pasang infus RL dan oksitosin 20 IU diguyur
Darah segar mengalir setelah bayi lahir Kontraksi uterus baik Terlihat robekan jalan lahir Plasenta lahir lengkap	Robekan jalan lahir	- Jahit robekan jalan lahir
Plasenta tidak lahir setelah 30 menit	Retensio plasenta	- Rujuk - Manual plasenta
Plasenta tidak lahir lengkap	Sisa plasenta	- Jika memungkinkan keluarkan sisa plasenta dengan cara manual - Segera rujuk apabila sisa plasenta tidak bisa dikeluarkan secara manual untuk dilakukan kuretase
Uterus tidak teraba Terlihat uterus pada vagina	Inversio	- reposisi

Sumber : (Utami, Woro., & Ummah, 2024)

F. Tanda tanda awal syok obstetric

1. Pengertian

Syok pada ibu pasca persalinan merupakan kondisi serius yang memerlukan penanganan segera. Syok dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perdarahan postpartum, infeksi, reaksi alergi, atau gangguan kardiovaskular. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat membahayakan nyawa ibu. Oleh karena itu, tenaga medis, khususnya bidan dan perawat, perlu memahami cara menangani syok secara cepat dan tepat untuk meningkatkan keselamatan pasien.

Syok obstetri adalah kondisi kegagalan sirkulasi darah yang akut pada ibu hamil, bersalin, atau nifas sehingga mengakibatkan gangguan perfusi jaringan dan oksigenasi sel. Syok yang paling sering terjadi pada persalinan adalah syok hipovolemik akibat perdarahan postpartum (PP).(Nusindo, 2025)

Tanda utamanya meliputi perdarahan hebat, detak jantung cepat, tekanan darah rendah, pucat, dan penurunan kesadaran, yang memerlukan penanganan resusitasi cairan segera.

2. Jenis Jenis Syok

a. Syok Hemoragik

Syok ini terjadi akibat perdarahan postpartum yang masif. Penyebab utama bisa berupa atonia uteri, retensio plasenta, trauma jalan lahir, atau gangguan koagulasi. Gejala yang sering muncul meliputi pucat, keringat dingin, hipotensi, dan takikardia.

b. Syok Septik

Syok ini disebabkan oleh infeksi yang tidak tertangani dengan baik, misalnya akibat endometritis atau sepsis puerperalis. Gejalanya meliputi demam tinggi, hipotensi, takikardia, pernapasan cepat, serta kesadaran menurun.

c. Syok Anafilaktik

Syok ini terjadi akibat reaksi alergi terhadap obat-obatan yang diberikan selama atau setelah persalinan. Gejalanya berupa sesak napas, pembengkakan wajah, ruam kulit, serta hipotensi yang muncul secara tiba-tiba.

d. Syok Kardiogenik

Syok ini disebabkan oleh gangguan pada jantung, seperti gagal jantung postpartum. Gejalanya meliputi nyeri dada, sesak napas, hipotensi, serta edema paru.(Ratnawati, 2018)

3. Penyebab Syok

a. Perdarahan postpartum massif, kehilangan darah Kehilangan darah > 1000 mL atau lebih.

b. Atonia Uteri, Uterus tidak berkontraksi dengan baik, menyebabkan perdarahan terus berlanjut.

c. Retensi Plasenta atau Fragmen Plasenta, plasenta atau bagian plasenta tertinggal di dalam rahim.
d. Inversio Uteri, Pembalikan dinding uterus ke luar (keadaan darurat
e. Ruptur Uteri, Robekan uterus akibat perdarahan massif
f. Emboli Cairan Ketuban, Masuknya cairan ketuban ke dalam sirkulasi darah ibu (jarang tapi fatal)
g. Infeksi/Sepsis, Komplikasi dari infeksi plasenta atau selaput amnion
h. Reaksi Alergi, Jarang terjadi, misalnya terhadap obat-obatan (Silalahi, V., & Widjayanti, 2022)

4. Tanda dan Gejaka Syok

a. Tahap Kompensasi

Pada tahap awal, tubuh masih mampu mempertahankan perfusi jaringan vital. Tanda-tanda yang mungkin belum jelas namun harus diwaspadai:

1) Nadi meningkat (tachycardia) > 100 kali per menit, namun masih kuat (*bounding pulse*).
2) Tekanan darah masih dalam batas normal atau sedikit rendah
3) Respirasi sedikit meningkat > 20 kali per menit
4) Kulit normal atau sedikit dingin
5) Kesadaran biasanya masih baik
6) Urin masih normal

b. Tahap *Decompensated Shock* (Syok yang Jelas)

Pada tahap ini, mekanisme kompensasi mulai gagal dan gejala menjadi lebih jelas:

1) Nadi: Cepat dan lemah (thready pulse) > 110-120 kali per menit
2) Tekanan Darah: Menurun signifikan - sistole < 90 mmHg atau penurunan > 30% dari tekanan darah awal
3) Respirasi: Cepat 30 kali per menit atau lebih
4) Kulit: Pucat, dingin, berkeringat banyak (*cold and clammy skin*)
5) Kesadaran: Gelisah, bingung, atau delirium
6) Urin: Oliguria (produksi urin < 30 mL/jam) atau anuria
7) Ekstremitas: Sianosis pada jari-jari tangan dan kaki

3) Tahap Syok Berat/*Irreversible Shock* (Syok yang Tidak *Reversibel*)

Pada tahap ini telah terjadi kerusakan organ dan kematian dapat terjadi :

1) Nadi sangat cepat dan sangat lemah (barely palpable pulse)
2) Tekanan darah sangat rendah atau tidak terukur
3) Respirasi sangat cepat atau respirasi *Cheyne-Stokes* (pola napas tidak teratur).
4) Kesadaran menurun, koma

5) Kulit cyanotic dan marbled (berupa bercak-bercak)
6) Anuria (tidak ada produksi urin)

5. Langkah Langkah penanganan Syok pascapersalinan

Penanganan syok pada ibu pasca persalinan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan yaitu:

a. Identifikasi Gejala Dini

Deteksi awal syok sangat penting untuk mencegah kondisi semakin memburuk. Perhatikan tanda-tanda seperti tekanan darah rendah, denyut nadi cepat, keringat dingin, penurunan kesadaran, serta perubahan warna kulit.

b. Pemberian Cairan dan Stabilisasi Hemodinamik

Jika ibu mengalami syok hemoragik, segera lakukan resusitasi cairan dengan memberikan cairan kristaloid atau koloid secara cepat melalui akses intravena besar. Jika perlu, lakukan transfusi darah untuk menggantikan volume darah yang hilang.

c. Mengontrol Sumber Masalah

Untuk syok hemoragik, lakukan kompresi uterus, pemberian uterotonika seperti oksitosin, dan jika perlu, tindakan bedah seperti ligasi arteri atau histerektomi. Jika syok disebabkan oleh infeksi, segera berikan antibiotik spektrum luas.

d. Optimalisasi Oksigenasi

Pastikan ibu mendapatkan oksigen dengan menggunakan masker oksigen beraliran tinggi. Jika terjadi gangguan pernapasan yang parah, pertimbangkan tindakan intubasi dan ventilasi mekanik.

e. Pemberian Obat-Obatan Sesuai Indikasi

1) Untuk syok septik, berikan antibiotik spektrum luas segera setelah kultur darah diambil.
2) Untuk syok anafilaktik, berikan epinefrin, antihistamin, dan kortikosteroid sesuai indikasi.
3) Untuk syok kardiogenik, berikan obat inotropik guna meningkatkan kontraktilitas jantung.

f. Monitoring Ketat dan Evaluasi Berkala

Pantau tanda-tanda vital secara berkala, termasuk tekanan darah, nadi, saturasi oksigen, dan keluaran urin. Evaluasi respons terhadap terapi dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Untuk dapat mendeteksi dini syok obstetri, tenaga kesehatan harus:

1) Pemantauan Ketat Tanda Vital

Ukur tanda vital setiap 15 menit pada jam pertama, setiap 30 menit pada jam kedua.

Perhatikan perubahan signifikan atau tren yang menurun
Bandingkan dengan nilai baseline sebelum persalinan

2) Observasi Klinis yang Teliti
Amati perubahan warna kulit (pucat, kemerahan)
Perhatikan perubahan tingkat kesadaran ibu
Amati intensitas berkeringat
Perhatikan kecepatan dan kualitas pernapasan

3) Pengukuran Output Urin
Pasang kateter urin untuk mengukur output urin setiap jam
Output urin normal: > 30 mL/jam
Output urin < 30 mL/jam mengindikasikan gangguan perfusi ginjal

4) Penilaian Pengisian Kapiler (Capillary Refill)
Tekan ujung jari kuku pasien selama 2 detik, lalu lepas
Waktu kembali warna normal: < 2 detik adalah normal
Capillary refill > 2 detik mengindikasikan syok

5) Pengukuran Perdarahan yang Akurat
Timbang semua pembalut yang digunakan (1 g = 1 mL darah)
Catat pada formulir pemantauan
Hitung jumlah perdarahan total dari awal persalinan

6) Akses Intravena
Segera pasang minimal 2 jalur intravena dengan IV besar (gauge 18 atau 20)
Siapkan untuk transfusi darah jika diperlukan (Lisnawati., Jubaedah, 2023)

6. Pencegahan Syok pascapersalinan

Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Berikut beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan:

a. Identifikasi faktor risiko sejak antenatal untuk mengetahui ibu dengan potensi perdarahan atau komplikasi lainnya.
b. Lakukan manajemen aktif kala tiga untuk mengurangi risiko perdarahan postpartum.
c. Gunakan teknik aseptik dalam semua prosedur persalinan guna mencegah infeksi.
d. Pantau kondisi ibu secara intensif setelah persalinan, terutama pada 24 jam pertama.
e. Berikan edukasi kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pasca persalinan agar segera mencari pertolongan medis jika terjadi keluhan

Syok pada ibu pasca persalinan merupakan kondisi gawat darurat yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Jenis syok yang umum meliputi syok hemoragik, septik, anafilaktik, dan kardiogenik. Tenaga medis perlu memahami

tanda-tanda awal syok dan menerapkan langkah-langkah penanganan yang sesuai untuk menyelamatkan nyawa ibu. Selain itu, tindakan pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko terjadinya syok dan meningkatkan keselamatan ibu setelah persalinan.(Febrida, 2025)

G. Tindakan menjaga stabilitas ibu

Stabilisasi klien/ibu, dengan oksigen, terapi cairan dan medikamentosa, dengan:

1. Menjamin kelancaran jalan nafas, memperbaiki
2. fungsi sistem respirasi dan sirkulasi.
3. Menghentikan perdarahan.
4. Mengganti cairan tubuh yang hilang.
5. Mengatasi nyeri dan kegelisahan

Ada beberapa Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas ibu yaitu:

1. Tindakan preventif untuk mencegah perdarahan

a. Manajemen Aktif Kala III

Pemberian oksitosin 10 IU intramuskular pada 1/3 lateral paha ibu secara langsung setelah bayi lahir

Penegangan tali pusat terkendali (controlled cord traction)

Pemijatan uterus setelah lahirnya plasenta

Tujuan: Merangsang kontraksi uterus yang efektif untuk hemostasis

b. Pemberian Uterotonika pada Kala IV

Jika kontraksi uterus lemah atau atonia: Berikan oksitosin 5-10 IU intramuskular atau intravena lambat

Dapat juga diberikan ergot alkaloid (ergotamin) jika tidak ada kontraindikasi

Lakukan pemijatan fundus uteri untuk merangsang kontraksi

Pemijatan Fundus Uteri (Uterine Massage)

c. Teknik: Letakkan satu tangan di atas pubis untuk menopang uterus bawah, gunakan tangan lain untuk memijat fundus dengan gerakan memutar

Frekuensi: Lakukan pemijatan jika kontraksi lemah, setiap 5-10 menit

Tujuan: Merangsang kontraksi dan mencegah atonia

d. Perawatan Perineum

Jika ada laserasi: Jahit dengan cara yang benar untuk menghentikan perdarahan

Berikan es/es batu untuk mengurangi edema dan perdarahan

Gunakan antibiotik lokal jika diperlukan

2. Manajemen cairan dan oksigenasi

a. Pemasangan dan Pemeliharaan IV Line

Pasang minimal 2 jalur IV dengan kateter besar (G18-G20)

Gunakan cairan kristaloid (normal saline atau ringer laktat) untuk resusitasi awal

Kecepatan aliran disesuaikan dengan kondisi ibu:

Kondisi stabil: Drip maintenance 500 mL / 8 jam

Ada perdarahan: Infus cepat sesuai protokol syok

b. Pemberian Oksigen

Berikan oksigen jika ada tanda hipoksemia atau syok

Gunakan nasal canula 2-3 L/menit atau face mask 5-8 L/menit

Target SpO_2 > 95%

c. Persiapan untuk Transfusi Darah

Crossmatch darah jika perdarahan mencapai 500 mL atau lebih

Siapkan fresh frozen plasma atau packed red cells

Siapkan peralatan transfusi dan monitor respon ibu

3. Kenyamanan dan dukungan emosional

a. Manajemen Nyeri

Berikan analgesik sesuai protokol (misalnya paracetamol 500-1000 mg atau NSAID)

Untuk syok: Analgesik parenteral mungkin lebih diindikasikan

Gunakan teknik distraksi atau relaksasi

b. Dukungan Psikologis

Jelaskan kepada ibu tentang kondisinya dengan bahasa yang mudah dipahami

Berikan kepastian bahwa ibu dan bayi dalam kondisi aman

Ijinkan keluarga menemani untuk memberikan dukungan moral

Edukasi tentang tanda-tanda bahaya yang perlu dilaporkan segera

c. Posisi Ibu

Posisi berbaring datar atau kepala lebih rendah sedikit (untuk membantu perfusi serebral jika ada syok)

Ganti posisi setiap 2 jam untuk mencegah decubitus

4. Koordinasi dan kolaborasi

a. Komunikasi dengan Tim Multidisiplin

Informasikan dokter / dokter spesialis obstetri jika ada tanda-tanda abnormal

Berkoordinasi dengan perawat anestesi jika diperlukan persiapan operasi

Libatkan tim laboratorium untuk pemeriksaan golongan darah dan pencocokan silang

b. Dokumentasi yang Lengkap dan Akurat

Catat semua parameter pemantauan sesuai waktu yang ditentukan

Catat tindakan-tindakan yang dilakukan dan respons ibu

Catat jumlah perdarahan dengan akurat

Catat waktu pemberian obat dan respons ibu terhadap obat

c. Persiapan untuk Rujukan

Jika terjadi perdarahan yang tidak terkontrol atau syok, siapkan ibu untuk dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi

Lakukan stabilisasi awal sebelum rujukan (pasang IV, berikan cairan, siapkan transfusi)

Antar ibu dengan pendamping yang terlatih(Odi L., Namangdjabar, 2023)

H. Dokumentasi hasil pemantauan

Dokumentasi dalam pelayanan kesehatan merupakan salah satu hal yang penting bagi tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan. Dokumentasi asuhan kebidanan digunakan sebagai bukti pencatatan, pelaporan dan tanggung jawab dan tanggung gugat di hadapan hukum dan etika profesi. Dokumentasi kebidanan digunakan sebagai bukti tertulis ataupun terekam dalam sistem terkait dengan data yang didapatkan dari anamnesa pasien (subyektif) dan hasil pemeriksaan fisik, laboratorium dan penunjang lainnya (data obyektif), analisa atau diagnosa kebidanan, rencana/penatalaksanaan dan tindakan yang telah dilakukan serta evaluasi (Ratnawati, 2018)

Dokumentasi adalah suatu dokumen atau catatan yang berisi data tentang keadaan pasien dan merupakan catatan otentik dalam penerapan manajemen asuhan profesional, atau komunikasi antara perawat dengan pasien. Dokumentasi dapat ditulis tangan atau dicetak atau disimpan dalam sistem audiovisual dan merupakan bagian permanen dari catatan medis pasien. Menurut Potter, (2010), dokumentasi yang baik memiliki 6 (enam) karakteristik, yaitu nyata, tepat, menyelesaikan, tepat waktu (saat ini), terorganisir, dan sesuai dengan standar dalam asuhan. Menurut (Borsato et al., 2011) Kualitas dokumentasi sebagai berikut:

1. Memberikan bukti asuhan dan pasien memberikan respons pada asuhan yang diberikan
2. Menjadi sumber referensi penting antara perawat dan anggota tim kesehatan lainnya
3. Memberikan fasilitas yang berkualitas dan berkesinambungan dalam asuhan dan memberikan informasi kepada semua anggota tim kesehatan yang terlibat dalam proses pelayanan tersebut
4. Meningkatkan informasi yang dibutuhkan oleh keluarga pasien
5. Melindungi tenaga kesehatan dari tanggung gugat terhadap asuhan yang diberikan kepada pasien.(Wijayanti, Irfana Tri., 2022)

Menurut Chelagat D , Sum T , Obel M , Chebor A, (2015) dalam (Utami, Woro., & Ummah, 2024) alasan perlu melakukan dokumentasi adalah :

1. Dokumentasi menyediakan sarana komunikasi antara anggota tim perawatan kesehatan dan memfasilitasi perencanaan yang terkoordinasi dan kesinambungan dalam pelayanan asuhan.
2. Dokumentasi yang jelas, lengkap, akurat dan faktual memberikan catatan perawatan pasien yang sesuai dengan kondisi dan keadaan pasien;
3. Dokumentasi sebagai sarana tanggung jawab dan akuntabilitas profesional, karena dokumentasi merupakan bagian dari tanggungjawab keseluruhan perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien dan dapat membantu dalam berkoordinasi dengan tim kesehatan lain serta sebagai bahan evaluasi asuhan yang telah diberikan
4. Dokumentasi dapat memberikan bukti tentang kondisi pasien saat ini
5. Dokumentasi sebagai dasar hukum dan memberikan perlindungan kepada perawat yang menjalankan asuhan kepada pasien
6. Dokumentasi sebagai dasar untuk mengevaluasi mutu dan kelayakan pelayanan asuhan yang diberikan karena sumber utama dari catatan pasien adalah data pasien
7. Dokumentasi memberikan data yang berguna dalam dunia pendidikan termasuk riset penelitian
8. Dokumentasi membantu dalam perencanaan dan penganggaran biaya. Perencanaan dan penganggaran yang tepat pada dasarnya akan membantu menetapkan jumlah staf yang dibutuhkan dan jumlah bahan serta peralatan yang dibutuhkan. Sebuah rumah sakit harus memberikan perawatan yang berkualitas untuk pasiennya
9. Dokumentasi membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendapatkan pembayaran kembali atas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Sebagian besar fasilitas pelayanan kesehatan memiliki lembar biaya untuk mendokumentasikan peralatan yang digunakan untuk setiap prosedur yang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, data yang cukup akan mengungkapkan semua perawatan yang diberikan kepada pasien dan hal ini akan membantu dalam penagihan yang tepat untuk layanan tersebut.

I. Latihan Soal

Petunjuk Pengerjakan: Pilih satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada opsi A, B, C, D, atau E.

1. Kala IV adalah periode…
   A. Dari lahirnya kepala bayi hingga lahirnya seluruh tubuh bayi
   B. Dari lahirnya plasenta hingga 2 jam setelahnya
   C. Dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi
   D. Dari kontraksi pertama hingga pembukaan lengkap
   E. Dari 2 jam sampai 24 jam setelah persalinan

2. Tujuan utama pemantauan kala IV adalah untuk…
   A. Memberikan minum kepada ibu yang haus
   B. Mendeteksi dini komplikasi dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan
   C. Memastikan bayi mendapat kolostrum dari ibu
   D. Mengajari ibu cara merawat bayi baru lahir
   E. Mencegah ibu merasa kecewa setelah persalinan

3. Frekuensi pengukuran tekanan darah pada jam pertama kala IV adalah…
   A. Setiap 5 menit
   B. Setiap 10 menit
   C. Setiap 15 menit
   D. Setiap 30 menit
   E. Setiap 1 jam

4. Nilai nadi normal pada ibu pasca persalinan adalah…
   A. 40-60 kali per menit
   B. 60-100 kali per menit
   C. 100-120 kali per menit
   D. 120-140 kali per menit
   E. Lebih dari 140 kali per menit

5. Nadi cepat dan lemah (> 110 kali per menit) merupakan tanda khas dari:
   A. Hipertermia
   B. Hipotermia
   C. Syok
   D. Infeksi ringan
   E. Kecemasan biasa

6. Tinggi fundus uteri normal pada akhir jam pertama kala IV adalah:
   A. Setinggi pusat
   B. 1 jari di atas pusat
   C. Setinggi pusat sampai 1 jari di bawah pusat
   D. 2 jari di bawah pusat
   E. 3 jari di bawah pusat

7. Perdarahan postpartum dikatakan abnormal jika jumlahnya pada jam pertama melebihi…
   A. 100 mL
   B. 200 mL
   C. 300 mL
   D. 500 mL
   E. 700 mL

8. Tindakan pertama yang harus dilakukan jika terdeteksi atonia uteri pada kala IV adalah ….
   A. Hubungi dokter spesialis obstetric
   B. Lakukan pemijatan fundus uteri dan berikan uterotonika
   C. Berikan transfusi darah
   D. Lakukan kateterisasi kandung kemih
   E. Posisikan ibu dengan kepala lebih tinggi

9. Gejala syok obstetri yang paling awal dan sensitif adalah…
   A. Tekanan darah rendah
   B. Tachycardia (nadi cepat)
   C. Respirasi cepat
   D. Kulit pucat dan dingin
   E. Kesadaran menurun

10. Produksi urin yang normal pada ibu pasca persalinan adalah…
   A. 10 mL/jam
   B. > 20 mL/jam
   C. > 30 mL/jam
   D. > 50 mL/jam
   E. > 100 mL/jam

11. Waktu capillary refill yang normal adalah…
    A. < 1 detik
    B. < 2 detik
    C. < 3 detik
    D. < 4 detik
    E. < 5 detik

12. Kandung kemih yang penuh pada kala IV dapat menyebabkan…
    A. Peningkatan kontraksi uterus
    B. Gangguan kontraksi uterus dan peningkatan perdarahan
    C. Penurunan tekanan darah
    D. Peningkatan suhu tubuh
    E. Penurunan frekuensi nadi

13. Parameter yang paling penting untuk mendeteksi syok hipovolemik adalah…
    A. Peningkatan suhu tubuh
    B. Peningkatan frekuensi nadi dan penurunan tekanan darah
    C. Penurunan respirasi
    D. Peningkatan produksi urin
    E. Peningkatan tingkat kesadaran

14. Manajemen aktif kala III bertujuan untuk…
    A. Mempercepat lahirnya bayi
    B. Memberikan rasa nyaman pada ibu
    C. Merangsang kontraksi uterus yang efektif untuk mencegah perdarahan
    D. Mencegah tali pusat membungkus leher bayi
    E. Memudahkan penjahitan robekan perineum

15. Pemberian oksitosin pada ibu pasca persalinan dapat membantu…
    A. Menurunkan tekanan darah
    B. Meningkatkan rasa nyeri ibu
    C. Merangsang kontraksi uterus untuk menghentikan perdarahan
    D. Meningkatkan produksi urin
    E. Menurunkan kesadaran ibu

Kunci Jawaban

1. B
2. B

3. C
4. B
5. C
6. C
7. D
8. B
9. B
10. C
11. B
12. B
13. B
14. C
15. C

J. Ringkasan

Kala IV persalinan adalah periode dua jam pertama setelah lahirnya plasenta, merupakan waktu kritis yang memerlukan pemantauan ketat untuk mendeteksi komplikasi. Pemantauan Tanda Vital meliputi Tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu harus dipantau secara berkala - setiap 15 menit pada jam pertama, setiap 30 menit pada jam kedua.

Kontraksi uterus yang baik adalah keras, konsisten, dan dapat teraba jelas. Atonia uteri (uterus lembek) memerlukan tindakan segera karena risiko perdarahan masif. Perdarahan Normal pada persalinan Adalah maksimal 500 mL pada jam pertama, 100-200 mL pada jam kedua. Perdarahan > 500 mL pada jam pertama adalah perdarahan postpartum abnormal.

Deteksi Dini Syok Adalah tanda awal yang penting adalah peningkatan nadi (tachycardia) dan penurunan tekanan darah. Syok obstetri paling sering disebabkan perdarahan postpartum. Adapun tanda-Tanda Syok Adalah Nadi cepat dan lemah (> 110 kali per menit), tekanan darah rendah (< 90 mmHg sistole), respirasi cepat (> 30 kali per menit), kulit pucat dingin, kesadaran menurun, oliguria.

Berikut adalah protokol pemantauan kala IV yang direkomendasikan adalah:

Jam Pertama Pasca Persalinan

Setiap 15 menit, ukur dan catat:

- Tekanan darah
- Nadi (denyut jantung)
- Respirasi (frekuensi napas)
- Kontraksi uterus (keras atau lembek)
- Tinggi fundus uteri

- Jumlah perdarahan
- Kandung kemih (kosong atau penuh)

Setiap 1 jam, ukur dan catat:

- Suhu tubuh
- Output urin (jika terpasang kateter)
- Kondisi umum dan tingkat kesadaran

Jam Kedua Pasca Persalinan

Setiap 30 menit, ukur dan catat:

- Tekanan darah
- Nadi
- Respirasi
- Kontraksi uterus
- Jumlah perdarahan

Setiap 1 jam, ukur dan catat:

- Suhu tubuh
- Output urin

Glosarium

Atonia Uteri: Hilangnya kemampuan kontraksi otot uterus, menyebabkan uterus menjadi lembek dan tidak berkontraksi dengan baik.

Capillary Refill: Waktu yang diperlukan untuk kembalinya warna kulit normal setelah pemberian tekanan pada kapiler kulit.

Decompensated Shock: Tahap syok di mana mekanisme kompensasi tubuh mulai gagal dan tanda-tanda syok menjadi jelas.

Emboli Cairan Ketuban: Masuknya cairan ketuban ke dalam sirkulasi darah ibu, kondisi darurat yang jarang tapi fatal.

Ergot Alkaloid: Kelompok obat uterotonika yang digunakan untuk merangsang kontraksi uterus.

Fundus Uteri: Bagian atas rahim yang teraba pada palpasi abdomen.

Hemostasis: Proses menghentikan perdarahan melalui kontraksi pembuluh darah dan koagulasi darah.

Hematom: Penimbunan darah di bawah kulit yang menyebabkan pembengkakan dan memar.

Hipertermia: Peningkatan suhu tubuh di atas nilai normal.

Hipotermia: Penurunan suhu tubuh di bawah nilai normal.

Hipoksemia: Kadar oksigen dalam darah yang rendah dari normal.

Inversio Uteri: Pembalikan dinding uterus ke luar, merupakan keadaan darurat dalam persalinan.

Intravena: Pemberian cairan atau obat langsung ke dalam pembuluh vena.
Kala IV: Periode dua jam pertama setelah lahirnya plasenta dalam proses persalinan.
Kateter: Selang kecil yang digunakan untuk memasukkan cairan atau obat atau mengambil sampel tubuh.
Kesadaran: Tingkat responsivitas dan orientasi seseorang terhadap lingkungan sekitarnya.
Kolostrum: Cairan pertama yang dikeluarkan dari payudara ibu setelah melahirkan, kaya akan antibodi.
Laserasi: Luka robek pada jaringan tubuh.
Lochia: Perdarahan normal yang keluar dari uterus setelah persalinan.
Manajemen Aktif: Pendekatan penatalaksanaan yang proaktif untuk mencegah komplikasi.
Marbled Skin: Kulit yang menunjukkan bercak-bercak warna tidak merata, tanda syok berat.
Morbiditas: Angka atau frekuensi penyakit dalam populasi.
Mortalitas: Angka atau frekuensi kematian dalam populasi.
Nasal Canula: Alat untuk pemberian oksigen melalui hidung dengan dua ujung kecil.
Nifas: Periode pemulihan setelah persalinan, berlangsung sekitar 6 minggu.
Oksitosin: Hormon atau obat uterotonika yang merangsang kontraksi uterus.
Oliguria: Produksi urin yang sangat sedikit, kurang dari 30 mL/jam.
Oxytocin: Sinonim dari oksitosin.
Perdarahan Postpartum (PPP): Perdarahan berlebihan setelah persalinan, lebih dari 500 mL pada jam pertama atau 1000 mL total.
Perfusi: Aliran darah yang melewati jaringan tubuh untuk memberikan oksigen dan nutrisi.
Perineum: Area antara anus dan alat kelamin luar.
Plasenta: Organ yang terbentuk selama kehamilan untuk memberikan oksigen dan nutrisi pada janin.
Pulsus Paradoxus: Penurunan tekanan darah sistole lebih dari 10 mmHg saat inspirasi.
Pusat (Umbilicus): Bekas tali pusat pada abdomen, digunakan sebagai landmark dalam pemeriksaan fisik.
Resusitasi: Tindakan untuk mengembalikan sirkulasi dan pernapasan.
Ringer Laktat: Cairan kristaloid yang sering digunakan untuk resusitasi cairan pada syok.
Saline Normal: Larutan garam fisiologis (NaCl 0,9%) yang digunakan sebagai cairan resusitasi.

Sepsis: Infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme lain di dalam tubuh.
Sianosis: Warna biru atau kebiruan pada kulit akibat rendahnya kadar oksigen dalam darah.
Simfisis Pubis: Persambungan tulang kemaluan di depan.
Spillane: Alat untuk mengumpulkan darah yang keluar saat persalinan.
Syok: Kegagalan sirkulasi akut yang mengakibatkan gangguan perfusi jaringan dan oksigenasi sel.
Syok Hipovolemik: Syok yang disebabkan oleh berkurangnya volume darah dalam sirkulasi tubuh.
Syok Kardiogenik: Syok yang disebabkan oleh kegagalan jantung memompa darah.
Syok Neurogenik: Syok yang disebabkan oleh gangguan fungsi sistem saraf pusat.
Syok Septik: Syok yang disebabkan oleh infeksi sistemik.
Tachycardia: Peningkatan frekuensi nadi di atas 100 kali per menit.
Tachypnea: Peningkatan frekuensi respirasi di atas 20 kali per menit.
Tinggi Fundus Uteri (TFU): Jarak dari simfisis pubis ke puncak fundus uteri, diukur dalam cm atau dalam satuan lebar jari.
Timpani: Bunyi yang dihasilkan dari perkusi atas area yang berisi udara.
Transfusi Darah: Pemberian darah dari donor ke pasien melalui jalur intravena.
Uterotoni/Uterotonika: Obat-obatan yang merangsang kontraksi otot uterus.
Uterus: Organ reproduksi wanita berbentuk seperti buah pir tempat berkembangnya janin.
Vital Sign: Tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh.
Vulva: Bagian eksternal alat kelamin wanita.
Vulvitis: Peradangan pada vulva

K. Daftar Pustaka

Afiyanti, Y., & Ratnawati, D. (2019). *Asuhan Keperawatan maternitas dengan pendekatan teori defisit perawatan diri orem* (1st ed.). Salemba Medika.

Febrida, M. (2025, November). Mengenal kala IV dalam tahapan proses persalinan. *Hai Bunda*. https://www.haibunda.com/kehamilan/20251027214124-49-378609/mengenal-kala-4-dalam-tahapan-proses-persalinan?utm_source=chatgpt.com

Fegita, P., & Satria, P. H. (2018). HEMORRHAGIC POST PARTUM : SYOK HEMORRHAGIC ec LATE HEMORRHAGIC POST PARTUM. *Jurnal Kesehatan Andalas*, *7*(Supplement 4), 71–75. https://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/947/808

Herlina, Nina., et al. (2025). *Asuhan Kebidanan Persalinan (teori dan Implemantasi)* (Sepriano (ed.); 1st ed.). Sonpedia Publishing Indonesia.

JNPKR. (2017). *Asuhan Persalinan Normal* (G. Andriaansz (ed.); 5th ed.). Jaringan Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi.

Kunang.S, S. A. (2023). *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan evidance based Midwifery* (1st ed.). Eureka Media Aksara.

Lestari, R. dkk. (2024). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan dan Persalinan* (A. Faisal (ed.); 1st ed.). Nuansa Fajar Cemerlang.

Lisnawati., Jubaedah, E. (2023). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Gawat Darurat Maternal dan Neonatal* (1st ed.). Nasya Expanding Management. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Asuhan_Kebidanan_Gawat_Darurat/x83hEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:+F.+Gary+Cunningham&pg=PA79&printsec=frontcover

Nusindo. (2025). *Bagaimana Menangani Syok pada Ibu Pasca Persalinan ?* 1–6. https://nusindo.id/bagaimana-menangani-syok-pada-ibu-pasca-persalinan/

Odi L., Namangdjabar, et al. (2023). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi baru Lahir* (E. Widyawaty (ed.); 1st ed.). Rena Cipta Mandiri. https://books.google.co.id/books?id=uMLDEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ratnawati, A. (2018). *Asuhan Keperawatan Maternitas*. https://doi.org/978-602-6237-35-4

Setyorini, Lilis., & Sugijati., dkk. (2024). Hubungan Edukasi Bidan pada Kala IV Persalinan dengan ambulasi dini di Puskesms Tanggul. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, *5*(3), 54–60. https://arteri.sinergis.org/arteri/article/view/279/165

Silalahi, V., & Widjayanti, Y. (2022). *Asuhan Keperawatan maternitas* (Sulistiyawati (ed.); 1st ed.). Syiah Kuala University Press.

Utami, Woro., & Ummah, W. (2024). *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal* (1st ed.). Forind.

Wijayanti, Irfana Tri., et al. (2022). *BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN PADA PERSALINAN* (1st ed.). K-Media.

Yanti, Evi., D. (2025). *Buku Asuhan Kebidanan pada persalinan Kala IV* (1st ed.). Mahakarya Citra Utama.

Yolanda, D. et al. (2025). *Buku Ajar Persalinan* (Z. Zainiyah (ed.); 1st ed.). Optimal untuk Negeri. https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_AJAR_PERSALINAN/PM6cEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=asuhan+persalinan+kala+IV&pg=PA43&printsec=frontcover

Yulizawati dkk. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. *1*, 157. https://www.scribd.com/document/429561465/Buku-Ajar-Asuhan-Kebidanan-Pada-Persalinan-compressed

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 26 tahun, G2P1A0, melahirkan spontan pervaginam bayi laki-laki hidup, BB 3200gr, menangis kuat, pukul 10.00 di Puskesmas PONED. Plasenta lahir lengkap 10 menit kemudian, perdarahan diperkirakan 250 mL. Pada pukul 10.30, bidan jaga akan melakukan pemantauan kala IV. Data saat pemantauan : KU ibu composmentis tampak lelah, TD 118/76mmHg, N 92x/menit, P 20x/menit, S 37,1°C. TFU 1 jari di atas pusat, konsistensi keras, Perdarahan pada pembalut sekitar 30–40mL selama 15 menit terakhir, warna merah segar, tidak berbau. Luka episiotomi derajat II telah dijahit, tampak kering, tidak ada perdarahan aktif, tidak ada hematom. Ibu mengatakan sudah BAK 1 kali (±200 mL, kuning jernih) 20 menit lalu.

Pertanyaan Diskusi

1. Data apa saja yang perlu dipantau secara berkala pada kala IV berdasarkan kasus di atas?
2. Data mana yang menunjukkan kondisi dalam batas normal pada kala IV? Jelaskan alasannya.
3. Data apa yang perlu tetap diwaspadai sebagai potensi masalah ke depan meskipun saat ini masih dalam batas aman?
4. Bagaimana jadwal pemantauan kala IV yang benar pada kasus ini (jam I dan jam II), dan apa saja yang dicatat setiap kali pemantauan?
5. Buatlah contoh pencatatan hasil pemantauan kala IV pertama (pukul 10.30–10.45) pada lembar pemantauan/partograf kala IV.
6. Jelaskan edukasi (KIE) yang perlu disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga terkait

Soal OSCE

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan : Gadar
3	Kasus	Perdarahan postpartum
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam :
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal : Skenario dan tugas peserta ujian	**SKENARIO KLINIK** Seorang ibu berusia 25 tahun melahirkan anak kedua 1 jam yang lalu di klinik bidan. Sebelumnya ibu menyatakan anak pertama usia 4 tahun dan belum pernah keguguran. Saat ini ibu mengeluh mengeluarkan darah banyak dari kemaluannya, merasa lemah, dan pandangan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan : K/U lemah, konjungtiva pucat, TD 90/60 mmHg, N 100 x/menit, S 37,2 °C, RR 24 x/menit, uterus teraba lembek, perdarahan 600 cc. **TUGAS** 1. Tuliskan diagnosa dari kasus tersebut ! 2. Lakukan tata laksana dari kasus tersebut dari awal hingga KBI saja!
7	Instruksi penguji	**INSTRUKSI UMUM** 1. Pastikan identitas peserta sesuai dengan kartu ujian 2. Tulislah 4 digit terakhir dari nomor peserta ujian pada lembar nilai tulis. 3. Amati peserta, actual mark (0/1/2/3), tentukan global rating dan berilah skor (1/2/3/4) pada lembar nilai terhadap tugas yang dikerjakan sesuai rubrik. 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.

No.	Komponen	Isi
		5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE **INSTRUKSI KHUSUS** 1. Penguji mengamati peserta ujian ketika melakukan tugas yang sesuai dengan yang tertulis pada skenario 2. Penguji memberi penilaian sesuai dengan rubrik penilaian di lembar form penilaian 3. Penguji memberi informasi bahwa uterus lembek pada saat pemeriksaan uteri **INSTRUKSI TAMBAHAN** Membantu laboran untuk merapikan peralatan yang telah digunakan peserta sebelumnya agar kondisi alat siap untuk digunakan oleh peserta berikutnya
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Tidak ada PS
9	Tipe Ruangan	Ruangan Tindakan
10	Kebutuhan manikin	Phantom panggul/uterus lengkap serviks untuk simulasi KBI/KBE
11	Kebutuhan laboran	**Peran laboran:** 1. Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin 2. Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan 3. Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	**Jenis alat** — **Jumlah** APD — 1 Handscoon Panjang — 2 pasang Hansdcoon DTT / steril — 2 pasang Bengkok — 1 Kapas swab — 1 Underpad berdarah — 1 Set Infus + Venflon + Cairan Infus (RL) — 1

No.	Komponen	Isi
		Standar Infus 1 Uterotonika : Oksitosin dan Ergometrin atau misoprostol 5 Spuit 3 ml 10 Spuit 5 ml 10 Tempat sampah medis/non-medis 1/1 Waskom larutan Klorin 1 Kertas dan ballpoint 2
13	Penulis	Susiani Endarwati, S.ST.,M.Kes
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. Standar Asuhan Persalinan Normal, 2012 Utami, I. (2020) *Buku ajar asuhan persalinan & manajemen nyeri persalinan*. Jakarta: Penerbit Poltekkes Kemenkes 4. American College of Obstetricians and Gynecologists (2020) 'Shoulder dystocia', *ACOG Practice Bulletin No. 229*. Obstetrics & Gynecology, 136(4), pp. e103-e110

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Persalinan Gawat darurat

KOMPETENSI 1. Perumusan diagnosis/masalah

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Perempuan, umur 25 tahun		
G2P1A0		
Atonia Uteri		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta menulis semua diagnose.
- **2** = Jika peserta menulis 2 dari 3 diagnosa.
- **1** = Jika peserta menulis 1 dari 3 diagnosa.
- **0** = Jika peserta ujian tidak dapat merumuskan diagnosis atau merumuskan tapi tidak benar.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menggunakan sarung tangan DTT		
2. Melakukan vulva hygiene		
3. Mengosongkan kandung kemih		
4. melepas sarung tangan sebelah kanan dan mengganti dengan sarung tangan panjang steril		
5. Memasukkan tangan kanan secara obstetrik hand		
6. Memastikan vagina dan serviks tidak ada bekuan darah/stolsel, dan melakukan eksplorasi cavum uteri dan mengeluarkannya		
7. Mengepalkan tangan dalam (posisi ibu jari di dalam) dan tempatkan pada forniks anterior		
8. Tangan kiri mencari fundus untuk mendapatkan kosrpus posterior		
9. Melakukan kompresi uterus, tangan dalam mendorong dinding segmen bawah uterus ke arah kranio anterior dan tangan luar menekan dan mendorong dinding posterior uterus ke arah anterior		
10. Melakukan evaluasi setelah kompresi setelah 5 menit		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = peserta ujian dapat melakukan prosedur Tindakan dengan benar dan lengkap.
- **2** = peserta ujian dapat melakukan 6-9 dari 10 prosedur Tindakan dengan benar.
- **1** = peserta ujian dapat melakukan prosedur Tindakan 2-5 dari 10 dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Melakukan dengan hati-hati		
Humanistik		
Memperhatikan keselamatan pasien dan PI		
Menjaga privasi		
Tulisan jelas, mudah dibaca		
Tidak ada coretan		
Bila tulisan salah, coret dengan satu garis dan ditandatangani yang dilanjutkan dengan tulisan yang benar		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian menunjukkan semua sikap professional sesuai item.
- **2** = Jika peserta menunjukkan 4-6 dari 7 sikap professional sesuai item.
- **1** = Jika peserta menunjukkan 1-3 dari 7 sikap professional sesuai item.
- **0** = Jika peserta ujian tidak menunjukkan sikap professional sesuai item item tersebut.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 / 3 ***(dicatat di rubrik penilaian)***

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota),.....

Penguji :.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada persalinan kala IV

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala IV
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural pada periode kala IV. Penilai mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan pemantauan kala IV, identifikasi tanda-tanda syok maternal, dan melakukan stabilisasi awal pada ibu pasca salin	Domain yang dinilai meliputi: a. Pengkajian dan pengumpulan data, b. ABC assessment dan identifikasi syok, c. Tindakan stabilisasi awal, d. Komunikasi dan emotional support, e. Keselamatan dan profesionalisme
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan pemantauan kala IV yang sistematis dan akurat, mengidentifikasi tanda-tanda awal syok maternal dengan cepat, serta melakukan stabilisasi awal yang aman dan efektif sesuai kewenangan bidan	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan, tetapi dari kemampuannya menilai tanda vital, tonus uterus, perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, melakukan penilaian ABC, memberikan oksigen, memasang akses IV, memulai resusitasi cairan, memberikan uterotonika, dan berkomunikasi efektif dengan pasien, keluarga, dan tim medis
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi	Contoh kasus: Ibu 28

	nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan pada periode kala IV. Kasus mencakup: (1) Ibu dengan kala IV normal untuk menilai kemampuan pemantauan sistematis, (2) Ibu dengan perdarahan postpartum yang memerlukan early recognition syok, atau (3) Ibu dengan tanda-tanda awal syok untuk menilai stabilisasi awal.	tahun, persalinan normal spontan selesai 1 jam yang lalu. Saat pemantauan kala IV jam pertama, didapatkan TD 95/60, HR 110, RR 22, suhu 36.8°C, TFU 2 jari di atas simfisis, tonus uterus lembek, perdarahan ±150 mL dalam 15 menit terakhir, kulit pucat, keringat dingin, lemas. Ibu dan keluarga tampak cemas.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan rangkaian tindakan klinik secara nyata. Keterampilan yang diamati meliputi: a. Pengkajian awal dan anamnesis terarah pada ibu pasca salin b. Penilaian tanda vital (TD, HR, RR, suhu, SpO_2) c. Palpasi abdomen, penilaian TFU, tonus, dan kontraksi uterus d. Inspeksi perineum dan estimasi perdarahan e. ABC assessment untuk identifikasi tanda syok f. Positioning dan	

	pemberian oksigen jika diperlukan g. Pemasangan akses IV dan persiapan resusitasi cairan h. Pemberian uterotonika sesuai indikasi i. Komunikasi dengan pasien/keluarga dan tim medis j. Dokumentasi dan menyiapkan rujukan jika diperlukan	
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi: a. Kemampuan melakukan pengkajian sistematis b. Persiapan dan teknik tindakan yang aman c. Kemampuan mengidentifikasi tanda-tanda bahaya secara cepat d. Pengambilan keputusan klinis yang tepat e. Komunikasi yang efektif dan empati f. Kecepatan dalam memberikan respon terhadap kondisi gawat g. Keselamatan pasien dan kebersihan tangan (hand hygiene)	

	h. Profesionalisme dan sikap percaya diri	
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah: a. Ketepatan pengukuran tanda vital dan interpretasi data b. Kecepatan dalam mengenali tanda-tanda syok (early warning signs) c. Kualitas komunikasi dalam menyampaikan kondisi pasien d. Urutan prioritas tindakan yang benar e. Teknik aseptic pada pemasangan akses IV f. Kemampuan reassessment setelah intervensi g. Pencatatan yang lengkap dan akurat pada partograph h. Keputusan yang tepat untuk eskalasi atau rujukan	

Tabel. Portofolio pada persalinan kala IV

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala IV
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu	Portofolio memuat bukti pemantauan ibu kala IV setiap 15 menit, deteksi tanda syok awal (takikardi, akral dingin), stabilisasi perdarahan, dan eskalasi tepat waktu
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan mengenali perubahan status ibu postpartum dan mengambil keputusan stabilisasi/eskalasi berdasarkan umpan balik CI
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik	OSCE: interpretasi tanda syok kala IV. DOPS: observasi pemantauan ibu postpartum, massase fundus, persiapan rujukan syok
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, hasil dicapai	Ibu G2P1, post partum spontan, menit 10: TB 90/60, nadi 110, perdarahan 400mL, massase fundus efektif,

		stabil dalam 30 menit
Refleksi patient safety	Mengenali risiko keselamatan, analisis kesalahan, langkah pencegahan asuhan kebidanan	Pentingnya pemantauan serial kala IV, deteksi syok dini, pencegahan keterlambatan rujukan, komunikasi keluarga saat perdarahan berlanjut
Feedback CI/dosen	Bukti pembinaan menunjukkan area kekuatan dan perbaikan dari CI/dosen	Baik dalam pemantauan rutin dan massase fundus, perlu tingkatkan ketegasan identifikasi syok dan dokumentasi perdarahan
Karakteristik penilaian	Kumpulan bukti berulang, penekanan konsistensi performa mahasiswa	Dinilai dari beberapa kasus kala IV menunjukkan konsistensi pemantauan dan stabilisasi ibu postpartum
Bukti konsistensi kompetensi	Mempertahankan mutu performa berbagai kesempatan praktik	Dari OSCE, DOPS, case, refleksi: konsisten deteksi syok, stabilisasi, eskalasi tepat di berbagai kasus kala IV.
Makna dalam OBE	Bukti autentik capaian pembelajaran performa berulang dan berkembang	Mahasiswa konsisten terapkan pemantauan kala IV dan deteksi syok dalam praktik kebidanan nyata

Tabel. Case Report pada persalinan kala IV

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala IV
Hakikat case report	Laporan singkat sistematis kasus klinik untuk bukti kemampuan analisis ilmiah	Ibu post partum menit 15: takikardi 110x/menit, TB 90/60, akral dingin, perdarahan aktif
Tujuan	Integrasi pengkajian, masalah, tindakan, implementasi, evaluasi asuhan	Masalah syok hipovolemik, tindakan massase fundus+cairan RL 1000cc, stabilisasi berhasil
Isi laporan	Identitas, data S/O, analisis, diagnosis, tindakan, evaluasi, pembelajaran	TB awal 120/80→90/60, nadi 80→110, perdarahan 450mL, massase efektif, TB stabil 110/70
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, logika klinik, evaluasi hasil asuhan	Hubungkan takikardi+hipotensi+akral dingin=syok, tindakan tepat waktu menyelamatkan
Nilai edukatif	Kembangkan clinical reasoning, dokumentasi, refleksi ilmiah	Pemantauan 15 menit kala IV dan deteksi dini syok adalah kunci keselamatan postpartum
Makna dalam OBE	Terapkan teori analisis kasus nyata sistematis bertanggung jawab	Asuhan kala IV lengkap dari pengkajian hingga stabilisasi profesional

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Persalinan Kala IV

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan Kala IV
Hakikat refleksi	Tulisan mengenali risiko, analisis masalah, rencana pencegahan	Keterlambatan deteksi syok kala IV dapat fatal dalam menit-menit krusial postpartum
Tujuan	Kesadaran keselamatan pasien prioritas utama	Kesalahan monitor vital atau remehkan

	asuhan kebidanan	perdarahan = risiko tinggi kematian maternal
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, pembelajaran	Risiko: PPH masif, atoni uterus, syok hipovolemik, emboli, infeksi postpartum
Risiko diidentifikasi	Situasi berpotensi bahayakan keselamatan pasien	Tidak monitor 15 menit, tidak palpasi fundus, tidak hitung perdarahan, keterlambatan rujukan
Tindakan pencegahan	Langkah konkret kurangi risiko keselamatan	Monitor vital 15 menit, palpasi fundus rutin, akses vena siap, komunikasi tim cepat
Pembelajaran	Pengaruh pengalaman pada praktik berikutnya	Kala IV butuh pengamatan cermat + keputusan tegas untuk selamatkan nyawa ibu
Makna dalam OBE	Perkembangan sikap profesional & berpikir kritis safety	Tingkatkan kualitas asuhan kala IV fokus keselamatan pasien berkelanjutan

Tabel Red Flags & Eskalasi Kala IV

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
TB ↓ ≥20 mmHg sistolik	Hipotensi syok	Reposisi+akses vena besar+cairan+RUJUK
Nadi >100 terus ↑	Tachycardia hypovolemia	Monitor TB 5 menit+RUJUK
Akral dingin/pucat	Syok hipovolemik	Oksigen+2 akses vena+RUJUK
Kesadaran ↓/gelisah	Hipoperfusi serebral	PANGGIL BANTUAN+RS ICU
Perdarahan >500 mL/15'	PPH masif	Massase fundus+uterotonic+RUJUK

Fundus tidak keras	Atoni uterus	Massase+kosong KKA+RUJUK operatif
Perut tegang/rebound	Perdarahan intra-abdomen	RUJUK OPERATIF SEKARANG
Urin ↓/tidak ada	Hipoperfusi ginjal	Kateter+cairan cepat+RUJUK
Suhu >38°C/<36°C	Infeksi/syok berat	Kehangatan+resusitasi+RUJUK
RR >24/dispnea	Asidosis/syok	Oksigen+monitor+RUJUK
Monitor tidak teratur	Delay deteksi	MULAI MONITOR 15 MENIT SEKARANG

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Bab Asuhan Persalianan Kala IV

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menyapa pasien dengan sopan dan menjelaskan tujuan pemantauan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mencuci tangan dengan benar	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengukur dan mencatat tanda vital dengan teknik benar (TD, HR, RR, suhu)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan palpasi uterus untuk menilai tonus, TFU, dan kontraksi dalam 10 menit	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menginspeksi perineum dan mengestimasi perdarahan	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan palpasi kandung kemih dan menanyakan riwayat BAK	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai kondisi bayi baru lahir secara singkat	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mencatat hasil pemantauan pada partograf dengan lengkap	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
9	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda-tanda abnormal dengan cepat	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengenali tanda-tanda early warning syok (takikardi, TD turun, kulit dingin)	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan ABC assessment dengan sistematis (Airway, Breathing, Circulation)	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memberikan oksigen dengan device yang tepat jika SpO_2 <94%	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa memanggil bantuan/dokter dengan komunikasi jelas dan cepat	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menempatkan ibu pada posisi yang tepat (Trendelenburg untuk syok hipovolemik)	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa memasang akses IV dengan gauge besar (18 G) dengan teknik aseptic	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa memberikan uterotonika (oksitosin) sesuai indikasi	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa melakukan masase fundus uteri untuk meningkatkan kontraksi	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa melakukan reassessment vital signs setelah intervensi	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi kepada pasien/keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa melakukan komunikasi dengan dokter/senior menggunakan SBAR	☐	☐	_____
22	Saya sudah bisa mempersiapkan rujukan dan transport yang aman jika diperlukan	☐	☐	_____
23	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi lengkap (tanda vital, tindakan, respons,	☐	☐	_____
24	Saya sudah bisa menjaga privasi pasien selama pemantauan	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
25	Saya sudah bisa menunjukkan sikap percaya diri dan tenang dalam situasi tension	☐	☐	_____

BAB 3

KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM: PERDARAHAN, SYOK, DAN STABILISASI AWAL

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.	CPMK-7; CPMK-4; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan intrapartum dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan kondisi klinis.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 10. Kegawatdaruratan Intrapartum: Perdarahan, Syok, dan Stabilisasi Awal	10.1 Mengenali cepat perdarahan intrapartum/postpartum awal dan melakukan tindakan awal sesuai algoritme.	10.2 Melakukan stabilisasi awal pada syok dan menyiapkan kolaborasi/rujukan dengan komunikasi efektif.	CPMK-6	CPMK-2; CPMK-3

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

CPMK-6	Simulasi skenario kegawatdaruratan; uji keputusan klinis	Melakukan penilaian cepat dan stabilisasi awal sesuai prioritas; menetapkan indikasi rujukan/kolaborasi tepat waktu berdasarkan kondisi klinis	20	Checklist simulasi; catatan keputusan klinis

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4) — CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Pengenalan dan stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda gawat terlewat; stabilisasi tidak sesuai prioritas	Tanda gawat dikenali namun respon lambat/kurang tepat	Tanda gawat dikenali cepat; stabilisasi sesuai prioritas	Sangat cepat dan sistematis; stabilisasi tepat + antisipasi perburukan
6.2 Keputusan rujukan/kolaborasi dan persiapan aman	Indikasi rujukan tidak tepat; persiapan tidak aman	Indikasi rujukan cukup tepat namun persiapan belum lengkap	Indikasi tepat; persiapan dan komunikasi memadai	Indikasi sangat tepat; persiapan komprehensif; komunikasi jelas; monitoring selama proses terjaga

Uraian Materi

Materi ini membahas konsep dan keterampilan dalam mengenali secara cepat tanda dan gejala perdarahan intrapartum maupun postpartum awal sebagai salah satu kegawatdaruratan obstetri. Pembelajaran mencakup identifikasi penyebab perdarahan berdasarkan prinsip 4T (Tone, Tissue, Trauma, Thrombin)**,** penilaian kondisi ibu secara cepat menggunakan pendekatan ABCDE, serta interpretasi tanda-tanda klinis yang mengarah pada syok.

Selain itu, mahasiswa dilatih untuk melakukan tindakan awal secara tepat dan sistematis sesuai algoritme penanganan perdarahan obstetri, meliputi stabilisasi kondisi ibu, pemberian uterotonika, pengendalian sumber perdarahan, serta pemantauan kondisi pasien. Materi ini juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan klinis yang cepat, akurat, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

A. Mengenali Cepat Perdarahan Intrapartum/Postpartum Awal dan Tindakan Awal Sesuai Algoritme

1. Pengertian Perdarahan Intrapartum dan Postpartum

Perdarahan intrapartum adalah perdarahan yang terjadi selama proses persalinan sebelum bayi lahir atau saat proses persalinan berlangsung.

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi setelah bayi baru lahir hingga 24 jam pertama (postpartum primer).

Batasan Perdarahan Postpartum:

a. Persalinan normal: ≥ 500 ml
b. Persalinan sectio caesarea: ≥ 1000 ml
c. Atau perdarahan disertai tanda syok hemodinamik

Perdarahan postpartum merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu sehingga memerlukan deteksi dan penanganan cepat.

2. Penyebab Perdarahan Intrapartum/Postpartum (4T)

a. Tone
   1) Penyebab paling sering (±70-80 %)
   2) Uterus tidak berkontraksi selama persalinan
b. Tissue
   1) Retensio plasenta
   2) Sisa placenta atau selaput ketuban
c. Trauma
   1) Laserasi serviks
   2) Laserasi vagina
   3) Rupture uteri

4) Episiotomy

d. Trauma

1) Gangguan pembekuan darah

2) Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

3. Tanda Dan Gejala Perdarahan Yang Harus Dikenali Cepat

Tanda Klinis:

a. Perdarahan banyak dari jalan lahir
b. Pembalut cepat penuh darah
c. Uterus lembek / tidak berkontraksi
d. Plasenta belum lahir
e. Laserasi jalan lahir

Tanda Syok:

a. Tekanan darah menurun
b. Nadi cepat (>100 x/menit)
c. Kulit pucat dan dingin
d. Gelisah
e. Penurunan kesadaran
f. Produksi urin menurun

4. Penilaian cepat

Penilaian dilakukan secara **ABCDE**

A- Airway

Pastikan jalan napas terbuka.

B- Breathing

Nilai pernapasan ibu.

C- Circulation

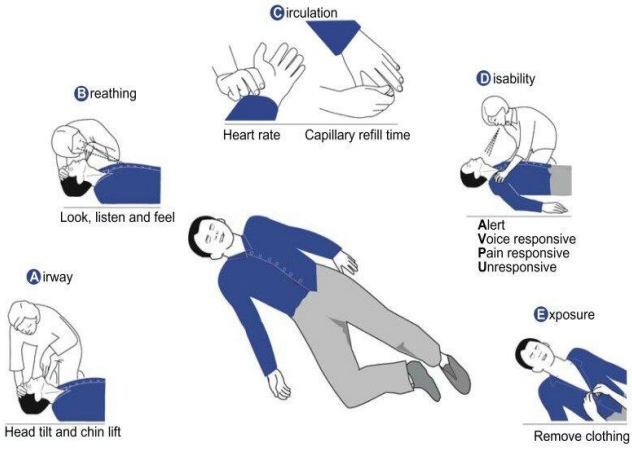
- Periksa tekanan darah
- Nadi
- Perkiraan jumlah perdarahan

D- Disability

Nilai kesadaran ibu.

E- Exposure

Evaluasi uterus, plasenta, dan jalan lahir.



5. Algoritme Tindakan Awal Perdarahan Obstetri

a. Kenali Perdarahan Segera
   1) Observasi jumlah darah
   2) Evaluasi kontraksi uterus

b. Panggil Bantuan
   1) Tim medis
   2) Persiapkan rujukan bila perlu

c. Lakukan Tindakan awal
   1) Pijat uterus (uterine massage)
   2) Pastikan kandung kemih kosong
   3) Pasang infus besar (RL/NaCl)
   4) Berikan oksigen
   5) Monitor tanda vital

d. Pemberian Uterotonika
   1) Oksitoksin sebagai terapi pertama

e. Identifikasi penyebab
   1) Tone
   2) Tissue
   3) Trauma
   4) Thrombin

f. Tindakan sesuai penyebab

   Atonia → uterotonika + kompresi uterus

   Retensio plasenta → manajemen plasenta

   Laserasi → penjahitan

   Gangguan koagulasi → rujukan segera

6. Peran Bidan Dalam Penanganan Awal

Bidan memiliki peran penting dalam:

a. Deteksi dini perdarahan

b. Stabilisasi awal pasien
c. Pemberian uterotonika
d. Pemantauan tanda vital
e. Koordinasi rujukan kegawatdaruratan

7. Prinsip Patient Safety

a. Respon cepat (<5 menit)
b. Penilaian sistematis
c. Dokumentasi tindakan
d. Komunikasi efektif (SBAR)
e. Persiapan rujukan cepat

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini Case

Skenario Kasus

Seorang ibu berusia 30 tahun**,** G2P1A0, melahirkan secara normal di ruang bersalin 20 menit yang lalu. Bayi lahir spontan dengan berat badan 3200 gram dan menangis kuat.

Setelah plasenta lahir, bidan memperhatikan bahwa darah keluar cukup banyak dari jalan lahir**.** Ibu tampak pucat dan gelisah.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan: Tekanan darah: 95/60 mmHg, Nadi: 108 x/menit, Pernapasan: 24 x/menit, Uterus teraba lembek**,** Kandung kemih penuh, Perdarahan diperkirakan sekitar 600 ml

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama yang terjadi pada pasien tersebut?
2. Apa kemungkinan penyebab perdarahan pada kasus ini?
3. Apa saja tanda bahaya yang menunjukkan kondisi pasien mengarah pada syok?
4. Sebutkan tindakan awal yang harus segera dilakukan oleh bidan sesuai algoritme penanganan perdarahan postpartum.
5. Jika kondisi pasien tidak membaik, langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya?

B. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	3
2	Judul	Stabilisasi Awal Syok Obstetri dan Persiapan Rujukan
3	Kasus	Penatalaksanaan awal syok obstetri pada ibu dengan perdarahan postpartum.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	Mengidentifikasi tanda syok pada ibu postpartum Melakukan stabilisasi awal syok Menyiapkan kolaborasi dan rujukan Melakukan komunikasi efektif menggunakan metode SBAR
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang ibu berusia 28 tahun, G2P1A0, baru saja melahirkan bayi secara normal 15 menit yang lalu. Setelah persalinan, ibu mengalami perdarahan banyak dari jalan lahir. Saat Anda melakukan pemeriksaan didapatkan kondisi berikut: Ibu tampak pucat dan gelisah, tekanan darah: 90/60 mmHg,

No.	Komponen	Isi
		nadi: 110 x/menit, pernapasan: 24 x/menit, uterus terasa lembek, perdarahan masih berlangsung. TUGAS Lakukan pengkajian cepat kondisi pasien. Lakukan stabilisasi awal pada kondisi syok. Jelaskan tindakan yang Anda lakukan kepada pasien. Siapkan rujukan dan komunikasi dengan tenaga kesehatan lain menggunakan metode SBAR.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, Penguji menjawab sesuai dialog 2. Mahasiswa diharapkan melakukan langkah berikut: a. Pengkajian cepat (ABCDE): memeriksa kesadaran, memeriksa jalan nafas, menilai pernafasan, memeriksa sirkulasi dan tanda vital, menilai jumlah perdarahan b. Stabilisasi awal; memanggil bantuan, memposisikan pasien dengan tepat, memberikan oksigen, memasang infus dan memberikan cairan, melakukan massage uterus, memantau tanda vital.

No.	Komponen	Isi
		c. Persiapan rujukan; menyampaikan kondisi pasien, menyiapkan transportasi rujukan, melengkapi dokumentasi. d. Komunikasi SBAR Mahasiswa harus mampu menyampaikan: Situation "Ibu postpartum dengan perdarahan dan tanda syok." Background "Ibu melahirkan normal 15 menit lalu." Assessment "Tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110, uterus lembek." Recommendation "Memerlukan penanganan lanjutan dan kemungkinan transfusi darah." 3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 4. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. Tujuan; Menilai kemampuan mahasiswa dalam : Mengidentifikasi syok obstetri Melakukan tindakan stabilisasi awal Menyiapkan rujukan kegawatdaruratan Melakukan komunikasi klinis efektif INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Data Tambahan (jika mahasiswa Bertanya)	Peserta: Apakah plasenta sudah lahir? Penguji: Plasenta sudah lahir lengkap Peserta: Bagaimana kontraksi uterus? Penguji: Uterus lembek Peserta:

No.	Komponen	Isi
		Apakah terdapat laserasi jalan lahir? Penguji: Tidak ditemukan laserasi Peserta: Apakah ibu sadar? Penguji: Ibu sadar tetapi tampak lemah
9	Kebutuhan manikin	-Phantom ibu bersalin
10	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar rujukan bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
11	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Manekin ibu bersalin 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Infus set 6. Cairan infus 7. Masker oksigen 8. Sarung tangan 9. Kasa/pembalut 10. Formulir rujukan
12	Penulis	Indah Kusmindarti,SST.,Bd.,M.Kes
13	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Kementerian Kesehatan RI. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. Ernawati. (2019). Kegawatdaruratan obstetri. Dalam Current update in obstetric and gynecologic emergency (pp. 76–94). CV Saga Jawadwipa

Cuplikan rubrik penilaian OSCE

Stasiun: Penanganan Awal Syok Obstetri

Aspek Penilaian	Kriteria Tidak Kompeten (0)	Kriteria Cukup (1)	Kriteria Kompeten (2)
Pengkajian kondisi pasien	Tidak melakukan pemeriksaan tanda vital atau salah menilai kondisi pasien	Melakukan sebagian pemeriksaan namun tidak sistematis	Melakukan pengkajian cepat secara sistematis (ABCDE)
Identifikasi tanda syok	Tidak mengenali tanda syok	Mengenali sebagian tanda syok	Mengenali tanda syok dengan tepat
Tindakan stabilisasi awal	Tidak melakukan tindakan stabilisasi	Melakukan tindakan tetapi tidak lengkap	Melakukan tindakan stabilisasi dengan benar dan lengkap
Pengendalian perdarahan	Tidak melakukan upaya menghentikan perdarahan	Melakukan tetapi kurang tepat	Melakukan tindakan yang tepat (misal pijat uterus)
Pemberian terapi awal	Tidak melakukan pemasangan infus/oksigen	Melakukan tetapi tidak tepat	Melakukan pemberian cairan dan oksigen dengan benar
Persiapan rujukan	Tidak menyiapkan rujukan	Menyiapkan rujukan tetapi tidak lengkap	Menyiapkan rujukan secara sistematis
Komunikasi SBAR	Tidak menggunakan SBAR	Menggunakan SBAR tetapi tidak lengkap	Menggunakan SBAR secara jelas dan sistematis
Profesionalisme	Tidak menjaga keselamatan pasien	Cukup menjaga keselamatan pasien	Bersikap profesional dan sistematis

Skor Penilaian

- **0 = Tidak dilakukan / salah**
- **1 = Dilakukan tetapi kurang tepat**
- **2 = Dilakukan dengan benar**

Total skor maksimum: 16

C. Ringkasan

Perdarahan intrapartum dan postpartum awal merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang harus dikenali secara cepat karena berisiko

menyebabkan syok hingga kematian ibu. Perdarahan postpartum didefinisikan sebagai kehilangan darah ≥500 ml setelah persalinan normal atau disertai tanda gangguan hemodinamik.

Penyebab utama perdarahan dapat diidentifikasi menggunakan konsep 4T, yaitu tone (atonia uteri) sebagai penyebab tersering, tissue (retensio plasenta), trauma (laserasi jalan lahir atau ruptur uteri), dan thrombin (gangguan pembekuan darah). Tanda-tanda yang harus diwaspadai meliputi perdarahan banyak, uterus lembek, pucat, nadi cepat, tekanan darah menurun, serta pernapasan meningkat.

Penilaian kondisi ibu dilakukan secara cepat dan sistematis menggunakan pendekatan ABCDE, untuk memastikan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, dan kondisi umum pasien. Setelah itu, tindakan awal harus segera dilakukan sesuai algoritme, yaitu dengan memanggil bantuan, melakukan pijat uterus, mengosongkan kandung kemih, memberikan uterotonika, memasang infus dan cairan, serta memberikan oksigen.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi penyebab perdarahan dan penanganan sesuai etiologi, disertai pemantauan tanda vital secara ketat. Jika kondisi tidak membaik, pasien harus segera dirujuk setelah dilakukan stabilisasi awal. Penanganan yang cepat, tepat, dan sistematis sangat penting untuk mencegah terjadinya syok dan menurunkan angka kematian ibu.

D. Daftar Pustaka

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.

Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2018). *Myles textbook for midwives* (16th ed.). Elsevier.

Hoffman, B. L., Schorge, J. O., Halvorson, L. M., Bradshaw, K. D., Cunningham, F. G., & Schaffer, J. I. (2020). *Williams gynecology* (4th ed.). McGraw-Hill Education.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.

Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2014). *Myles textbook for midwives* (15th ed.). Churchill Livingstone Elsevier.

World Health Organization. (2017). *WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage*. World Health Organization.

World Health Organization. (2018). *Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors* (2nd ed.). World Health Organization.

Ristanti, A. D., & Zuwariyah, N. (2020). Penerapan manajemen rujukan kegawatdaruratan obstetri dengan insiden kegawatdaruratan obstetri di pusat pelayanan primer. *Jurnal Ners dan Kebidanan*, 7(2), 239–246.

Julieta, N. P. N., & Giri, M. K. W. (2021). Postpartum hemorrhage: Kegawatdaruratan dalam persalinan ibu hamil. *Ganesha Medicina*, 1(1).

Ernawati. (2019). Kegawatdaruratan obstetri. Dalam *Current update in obstetric and gynecologic emergency* (pp. 76–94). CV Saga Jawadwipa

BAB 4

PREEKLAMPSIA/EKLAMPSIA SAAT INTRAPARTUM: PENANANGANAN AWAL, PENCEGAHAN KEJANG DAN RUJUKAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan clinical reasoning berbasis data untuk penapisan masalah dan pengambilan keputusan intrapartum.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV serta tindakan awal kegawatdaruratan intrapartum secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.	CPMK-7; CPMK-4; CPMK-1

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menerapkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan persalinan dan situasi kegawatdaruratan intrapartum.
CPMK-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed consent, dan kolaborasi interprofesional pada asuhan dan rujukan intrapartum.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menerapkan keselamatan ibu-bayi melalui PPI, K3, pemantauan terstruktur, dan manajemen risiko intrapartum.
CPMK-4	Melakukan pengkajian komprehensif ibu bersalin dan kesejahteraan janin serta menafsirkan temuan untuk penetapan masalah/prioritas.
CPMK-5	Merencanakan dan melaksanakan asuhan persalinan kala I–IV berbasis bukti termasuk dukungan, kenyamanan, manajemen nyeri, dan pencegahan komplikasi.
CPMK-6	Melakukan penatalaksanaan awal kegawatdaruratan intrapartum dan menetapkan indikasi rujukan berdasarkan kondisi klinis.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi klinis (termasuk partograf) dan dokumen rujukan secara akurat serta menggunakan data untuk evaluasi mutu.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Preeklampsia

Preeklampsia adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan hipertensi dalam kehamilan dan proteinuria yang terjadi pada kehamilan diatas 20 minggu (1). Preeklampsia sering dihubungkan dengan dua komponen, yaitu implantasi plasenta yang abnormal dan disfungsi endotel. Disfungsi endotel mengakibatkan dilepaskannya vasokonstriktor dan prokoagulan ke pembuluh darah plasenta (2).

Preeklampsia adalah suatu sindroma yang ditemukan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, dengan tanda hipertensi dan proteinuria, disertai atau tanpa edema. Hipertensi bila tekanan darah ≥ 140/90 mmHg atau terjadi kenaikan tekanan sistolik ≥30 mmHg atau tekanan diastolik ≥15 mmHg dari hasil pengukuran normal (3)

B. Patofisiologi Preeklampsi

Plasenta merupakan pusat preeklampsia. Preeklampsia hanya terjadi pada kehamilan dan hampir selalu sembuh setelah melahirkan. Seperti pada kasus mola hidatidosa, kehadiran janin tidak diperlukan untuk terjadinya preeklampsia. Demikian pula, dalam kasus preeklampsia dengan kehamilan di luar rahim, pengangkatan janin saja tidak cukup, dan gejala tetap ada sampai plasenta lahir (4). Kasus eklamsia postpartum telah dikaitkan dengan sisa fragmen plasenta, dengan perbaikan yang cepat setelah kuretase uterus (5). Preeklampsia berat dikaitkan dengan bukti patologis berupa hipoperfusi dan iskemia plasenta. Temuan termasuk atherosis akut, lesi obstruksi vaskular difus yang meliputi deposisi fibrin, penebalan intima, nekrosis, aterosklerosis, dan kerusakan endotel (6). Infark plasenta, yang kemungkinan disebabkan oleh oklusi arteri spiralis, juga sering terjadi. USG Doppler arteri uterina yang abnormal, konsisten dengan penurunan perfusi uteroplasenta diamati sebelum onset klinis preeclampsia (4). Tingkat keparahan patologi plasenta tampak berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit klinis, walaupun temuan ini tidak universal (6). Teori yang dipakai sampai sekarang adalah:

1. Kelainan vaskularisasi plasenta

Pada perempuan yang mengalami kehamilan normal, invasi trofoblastik akan dapat mengakibatkan pengaruh degenerasi pada lapisan otot arteria spiralis, sehingga akan mengakibatkan suatu dilatasi pada otot arteria spiralis. Dengan demikian pada Invasi trofoblast akan ikut masuk pada jaringan arteri spiralis, maka pada jaringan matriks akan menimbulkan gembur dan pada lumen arteri spiralis akan menimbulkan distensi dan dilatasi. Pada kehamilan akan mengalami namanya distensi dan vasodilatasi lumen arteri spiralis yang berfungsi sebagai pemberian aliran darah ke janin yang di kandung.

Pada kehamilan normal, plasentasi yang tepat sangat penting. Trofoblas ekstravili (EVT) dari kolom sitotrofoblas (CBT) ovum yang subur menginvasi desidua uterus ibu dan miometrium, menghasilkan remodeling arteri spiralis untuk memasok berlimpah darah ibu ke ruang intervillous plasenta guna mendukung pertumbuhan janin. Remodeling ini mengakibatkan hilangnya otot polos pembuluh darah, menyebabkan relaksasi arteri spiralis dan pelebaran lumen pembuluh darah dapat mempertahankan aliran darah yang melimpah bagi embrio (7).

Pada kehamilan yang dialami perempuan ketika mengalami preeklampsia, tidak terjadi invasi trofoblast ke dalam aliran seperti arteria spiralis dan sel jaringan di sekitarnya, sehingga terjadi ketidakkeberhasilan dalam proses remodelling arteri spiralis. Hal ini akan mengakibatkan hipoksia dan iskemia pada plasenta. Selama kehamilan normal, sitotrofoblas vili menginvasi sepertiga bagian dari miometrium, dan arteri spiralis kehilangan endotelium dan sebagian besar serat ototnya. Modifikasi struktural ini terkait dengan perubahan fungsional, seperti arteri spiralis menjadi pembuluh darah dengan resistansi rendah, dan dengan demikian kurang sensitif, atau bahkan tidak sensitif, terhadap zat vasokonstriktor (8).

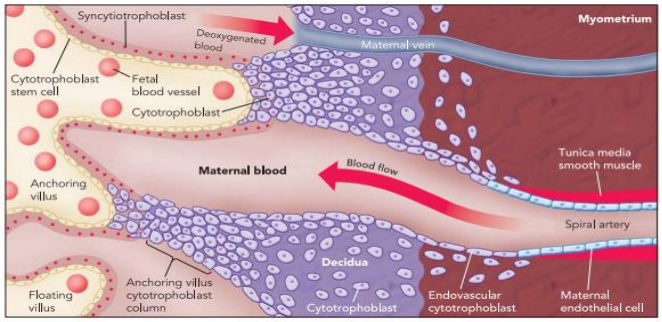
2. Iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel

Preeklampsia memiliki patofisiologi yang kompleks, Penyebab utamanya adalah plasentasi abnormal. Invasi arteri spiral yang rusak oleh sel sitotrofoblas diamati pada preeklampsia. Studi terbaru menunjukkan bahwa invasi sitotrofoblas ke dalam rahim sebenarnya merupakan hal yang unik, yaitu jalur diferensiasi di mana sel-sel janin mengadopsi atribut tertentu dari endotelium ibu yang secara normal mengganti. Pada pre-eklampsia, proses diferensiasi ini berjalan tidak normal (9).

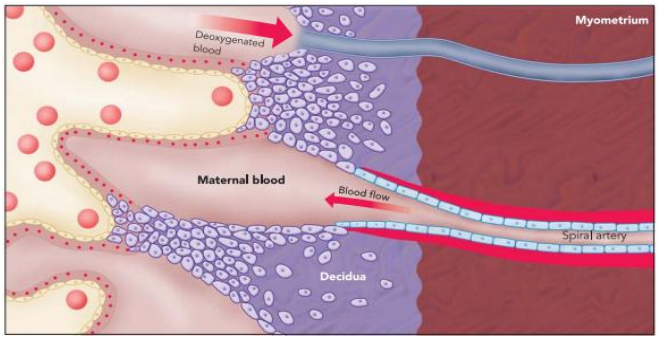
Kelainan mungkin terkait dengan jalur Nitric Oxide (NO), yang memberikan kontribusi substansial terhadap kontrol pembuluh darah. Selain itu, penghambatan sintesis NO dapat mencegah implantasi embrio. Peningkatan resistensi arteri uterina meningkatkan sensitivitas terhadap vasokonstriksi dan, dengan demikian, menyebabkan iskemia plasenta kronis dan stres oksidatif. Iskemia plasenta kronis ini dapat menyebabkan komplikasi pada janin, termasuk retardasi pertumbuhan intrauterin dan kematian intrauterin. Secara paralel, stres oksidatif menginduksi pelepasan ke dalam sirkulasi ibu zat-zat seperti radikal bebas, lipid teroksidasi, sitokin, dan serum soluble vascular endothelial growth factor 1 (VEGF1). Kelainan ini bertanggung jawab atas disfungsi endotel dengan vascular hiperpermeabilitas, trombofilia, dan hipertensi, sehingga untuk mengkompensasi penurunan aliran di arteri uterine karena vasokonstriksi perifer (10).

Sudah di jelaskan invasi trofoblast di atas, pada preeklamsia di dapatkan suatu kejang-galan yang dapat mengakibatkan kegagalan pada remodelling arteri spiralis. Maka akan terjadi iskemia dan hipoksia pada plasenta, sehingga akan menghasilkan radikal hidroksil yang sangat toksik pada pembuluh darah. Pada ibu hamil yang sedang hipertensi dapat dikatakan sebagai oksidan, pada saat peroksida lemak akan mengalami peningkatan maka mengakibatkan rusaknya suatu sel endotel yang dapat dikatakan sebagai disfungsi endotel. Terjadinya gangguan prostaglandin dan agregasi sel-sel trombosit. Sehingga dari Agregasi trombosit membuat suatu solusi yang diberikan nama (TXA2) artinya vasokonstriktor (11).

Plasenta yang mengalami iskemia atau hipoksia akan menghasilkan oksidan (disebut juga radikal bebas). Oksidan atau radikal bebas adalah senyawa atau atom/molekul yang menerima elektron atau memiliki elektron tidak berpasangan. Salah satu oksidan penting yang dihasilkan oleh plasenta iskemia adalah radikal hidroksil, yang sangat toksik, khususnya terhadap membran sel endotel pembuluh darah. Faktor angiogenik juga berperan dalam regulasi vaskular plasenta. Faktor-faktor ini antara lain VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), Flt (fms-like tyrosine kinase), dan PIGF (Placental Growth Factors) (4). VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) tidak hanya merupakan faktor proangiogenik, tetapi juga penting dalam menjaga kesehatan endotel dan vaskular. VEGF dapat memberikan efek melalui reseptornya, yaitu VEGFR-2 (Vascular Endothelial Growth Factor Reseptor-2) (12). PIGF (Placental Growth Factors) hanya akan mengikat Flt-1 (Flt-1, juga dikenal sebagai VEGFR-1) yang akan memicu angiogenesis patologis daripada fisiologis di bawah kondisi inflamasi atau hipoksia (13). Lingkungan hipoksia yang dihasilkan dalam plasenta juga merangsang pelepasan faktor plasenta, seperti tirosin soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1), endoglin terlarut (s-Eng), autoantibodi agonistik ke reseptor angiotensin tipe 1 (AT1-AA), dan sitokin inflamasi (14). sFlt-1 mampu memblok efek VEGF dengan cara menghambat interaksinya dengan reseptor, dan dapat menghambat PIGF. Peningkatan sFlt-1 selama preeklampsia dapat dikaitkan dengan penurunan VEGF dan PIGF bebas dalam darah (15,16).



Gambar 4.1 Plasentasi Normal



Gambar 4.2 Plasentasi Abnormal

Keterangan:

Pada plasenta yang normal, sitotrofoblas invasif yang berasal dari janin menginvasi arteri spiralis ibu, mengubahnya dari pembuluh resistansi berkaliber kecil menjadi pembuluh kapasitansi berkaliber tinggi yang mampu memberikan perfusi plasenta yang memadai untuk mempertahankan pertumbuhan janin. Selama proses invasi vaskular, sitotrofoblas berdiferensiasi dari fenotip epitel menjadi fenotipe endotel, proses yang disebut "pseudovaskulogenesis" atau "mimikri vaskular" (di atas). Pada preeklampsia, sitotrofoblas gagal mengadopsi fenotipe endotel invasif. Sebaliknya, invasi arteri spiral dangkal, dan mereka tetap kaliber kecil, pembuluh resistensi (bawah)

3. Intoleransi imunologik antara ibu dan janin

Menurut teori maladaptasi imun, hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa preeklampsia lebih sering ditemukan pada primigravida, multigravida yang menikah lagi, hiperplasentosis, kehamilan dengan inseminasi donor, penurunan konsentrasi komplemen C4, wanita dengan fenotipe HLA DR4, dan aktivasi sistem komplemen pada netrofil dan makrofag. Reaksi penolakan janin oleh ibu dapat disebabkan pula oleh perubahan histologis di perbatasan sel atau jaringan ibu dan plasenta sehingga terjadi gangguan pembentukan blocking antibodies di daerah perbatasan tersebut. Maladaptasi imunologi juga diduga disebabkan oleh rendahnya ekspresi HLA-G di jaringan ekstravili, yang berakibat pada gangguan

vaskularisasi plasenta. Peningkatan rasio Th1/Th2 menyebabkan produksi sitokin proinflamasi (TNF-α dan IL-1), enzim proteolitik, dan radikal bebas oleh desidua. Hal ini merupakan salah satu penyebab jejas endotel (17). Oral seks dan jarak antara menikah dan hamil yang lebih lama dapat menurunkan risiko terjadinya preeklampsia.

4. Adaptasi kardiovaskuler

Perempuan yang sedang hamil secara normal maka akan terjadinya suatu refrakter yang di akibatkan adanya pembuluh darah artinya suatu pembuluh darah apabila tidak merespon terhadap vasopresor. Sedangkan daya refrakter pada vasopresor akan berubah menjadi status hilang apabila diberikan inhibitor sintesis prostaglandin. Prostaglandin akan mengalami perubahan pada kemudian hari menjadi prostaglandin. Saat kehamilan, terjadi peningkatan kepekaan refrakter pembuluh darah terhadap vasopresor.

5. Defisiensi genetik

Faktor keturunan memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan terjadinya preeklampsia berat dan meningkatkan risiko preeklampsia berat hingga 7,11 kali lebih tinggi pada mereka yang memiliki keturunan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki keturunan. Ibu hamil yang mengalami preeklampsia terdapat kecenderungan akan diwariskan. Faktor tersebut dibuktikan oleh beberapa peneliti bahwa preeklampsia berat adalah penyakit yang bertendensi untuk timbul pada satu keturunan (anak perempuan atau saudara perempuan), preeklampsia merupakan penyakit yang diturunkan, penyakit ini lebih sering ditemukan pada anak perempuan dari ibu preeklampsia, atau mempunyai riwayat preeklampsia/eklampsia dalam keluarga.

6. Defisiensi gizi

Defisiensi besi sangat berperan terhadap preeklampsia. Beberapa penelitian menyebutkan wanita hamil yang diberikan kalsium cukup 14% mengalami preeklampsia, sedangkan kalau di beri glukosa 17% mengalami preeklampsia.

7. Inflamasi

Saat kehamilan normal terjadi pelepasan pada trofoblast, artinya baru melalui proses sisa-sisa apoptosis dan juga nekrosis akibat reaksi stres oksidatif. Saat preemklamsia pelepasan trofoblast sangat berlebihan sehingga adanya peningkatan stress oksidatif yang menimbulkan reaksi inflamasi.

C. Faktor Resiko Preeklampsi

Beberapa faktor predisposisi yang memengaruhi terjadinya PE antara lain usia, paritas, keturunan, faktor genetik, diet, lingkungan, status sosioekonomi, hipertensi kronis, dan hiperplasentosis. Beberapa faktor risiko telah dikaitkan dengan

perkembangan preeklampsia, tetapi yang paling banyak, seperti nuliparitas, kehamilan kembar, diabetes melitus (DM), riwayat penyakit ginjal, usia ibu > 35 tahun atau < 20 tahun, obesitas, preeklampsia sebelumnya, mutasi faktor V Leiden, mutasi pada gen angiotensinogen dan protrombin, dan sindrom antibodi antifosfolipid, juga menjadi faktor risiko pada wanita hamil. Beberapa faktor predisposisi yang memengaruhi terjadinya PE antara lain umur, paritas, keturunan, faktor genetik, diet, lingkungan, status sosioekonomi, hipertensi kronis, dan hiperplasia (18). Riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklampsia akan meningkatkan risiko preeklampsia pada ibu hamil hingga 3 kali lipat. Wanita dengan preeklampsia berat cenderung memiliki ibu kandung dengan riwayat preeklampsia pada kehamilannya terdahulu artinya ada faktor keturunan dan familial dengan model gen tunggal (19).

Faktor risiko utama preeklampsi meliputi: riwayat preeklampsia, hipertensi kronis, diabetes melitus pregestasional, sindrom antifosfolipid, dan obesitas (20). Faktor risiko lainnya termasuk usia ibu lanjut, nulipara, riwayat penyakit ginjal kronis, dan kehamilan dengan bantuan. Faktor risiko yang relatif jarang adalah riwayat keluarga dengan preeklampsia dan ibu yang memiliki janin trisomi 13. Kerentanan genetik terhadap preeklampsia telah dipelajari secara ekstensif (4).

D. Klasifikasi dan Definisi

Adanya peningkatan tekanan darah selama kehamilan dan persalinan dapat menunjukkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Diagnosis hipertensi dalam kehamilan ditegakkan bila didapatkan:
   Tekanan darah ≥140/90 mmHg untuk pertama kalinya selama kehamilan, tidak terdapat proteinuria, tekanan darah kembali normal dalam waktu 12 minggu pascapersalinan (jika peningkatan tekanan darah tetap bertahan, ibu didiagnosis hipertensi kronis), diagnosis akhir baru dibuat pada periode pascapersalinan, tanda-tanda lain preeklampsia seperti nyeri epigastrium dan trombositopenia mungkin ditemukan dan dapat memengaruhi penatalaksanaan yang diberikan.
2. Diagnosis preeklamsia ditegakkan bila didapatkan:
   Tekanan darah ≥ 140/90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu, proteinuria ≥ 1+ pada pengukuran dengan dipstick urine, atau kadar protein total ≥ 300 mg/24 jam.
3. Diagnosis preeklamsia dengan kondisi berat ditegakkan bila didapatkan (21):
   a. Hipertensi
      Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg atau tekanan darah diastolic ≥110 mmHg.
   b. Protein uria
      Kadar protein dalam kencing ≥ ++ pada pengukuran dipstick urine atau kadar protein total sebesar 2 gr/24 jam.

c. Kadar kreatinin darah melebihi 1,2 mg/dL, kecuali jika telah diketahui sebelumnya meningkat.
d. Tanda/gejala tambahan: Tanda/gejala tambahan lainnya dapat berupa keluhan subjektif, seperti nyeri kepala, nyeri ulu hati, dan mata kabur. Ditemukannya proteinuria ≥ 3 gram, jumlah produksi urine ≤ 500 cc/24 jam (oliguria), peningkatan kadar asam urat darah, peningkatan kadar BUN dan kreatinin serum, serta terjadinya sindroma HELLP yang ditandai dengan hemolisis, ikterus, hitung trombosit ≤ 100.000, serta peningkatan SGOT dan SGPT.

4. Pada eklampsia disertai kejang konvulsi yang bukan disebabkan oleh infeksi atau trauma.
5. Diagnosis Preeklamsia superimpos ditegakkan apabila protein awitan baru ≥ 300 mg/24 jam pada ibu penderita darah tinggi tetapi tidak terdapat protein uria pada usia kehamilan sebelum 20 minggu.
6. Diagnosis hipertensi kronis ditegakkan apabila hipertensi telah ada sebelum kehamilan atau didiagnosis sebelum usia kehamilan 20 minggu, atau hipertensi pertama kali didiagnosis setelah usia kehamilan 20 minggu dan terus bertahan setelah 12 minggu pascapersalinan.

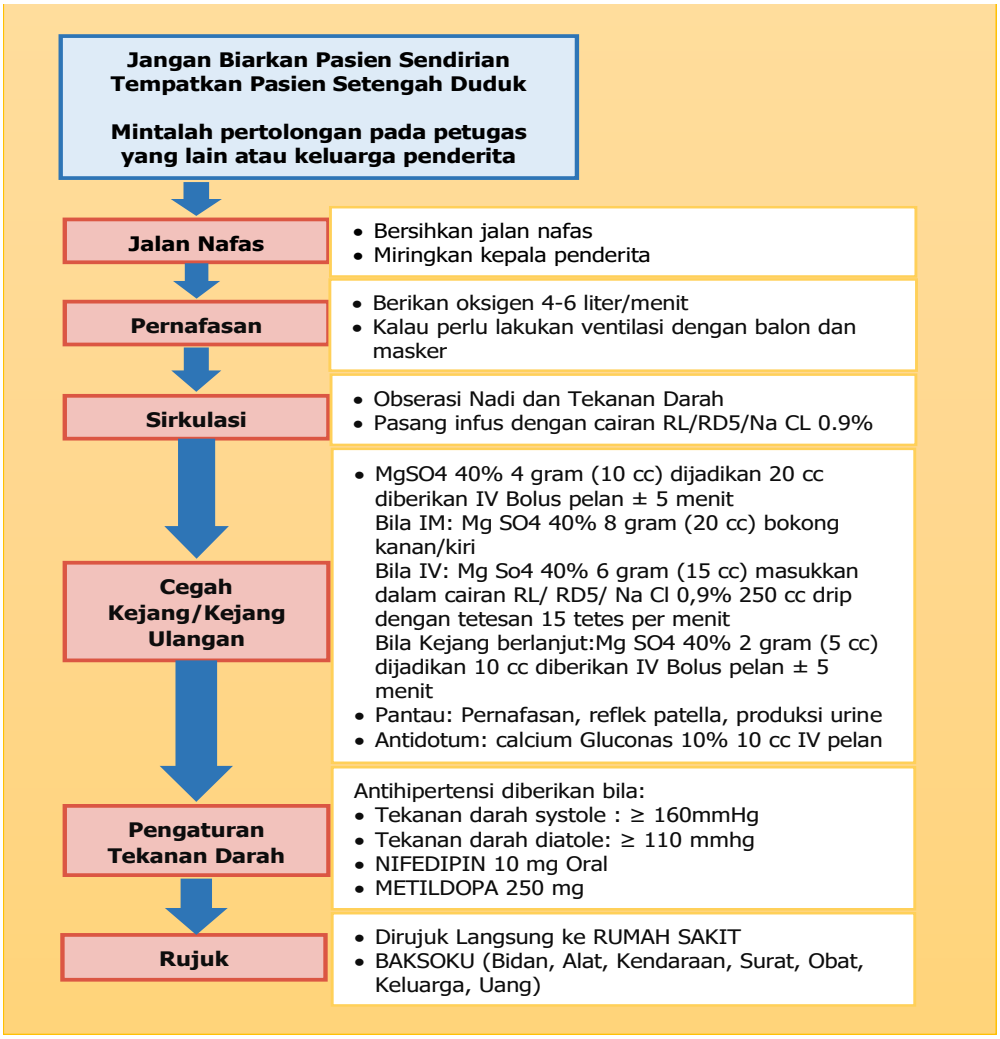
E. Penanganan Awal Preeklampsi, pencegahan kejang dan Rujukan

Prinsip pengobatan:

1. Pencegahan kejang
2. Pengobatan hipertensi
3. Pengelolaan cairan
4. Penanganan suportif terhadap penyulit organ
5. Saat yang tepat untuk persalinan

Terdapat perbedaan dalam manajemen hipertensi pada kehamilan dan di luar kehamilan. Kebanyakan kasus hipertensi di luar ke hamilan merupakan hipertensi esensial yang bersifat kronis. Terapi hipertensi di luar kehamilan ditujukan untuk mencegah komplikasi jangka panjang, seperti stroke dan infark miokard, sedangkan hipertensi pada kehamilan biasanya kembali normal pada masa post-partum, sehingga terapi tidak ditujukan untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Preeklampsia berisiko menjadi eklampsia, sehingga diperlukan penurunan tekanan darah yang cepat pada preeklampsia berat. Selain itu, preeklampsia melibatkan komplikasi multisistem dan disfungsi endotel, yang meliputi kecenderungan protrombotik, penurunan volume intravaskuler, dan peningkatan permeabilitas endotel (22).

Alur Pengelolaan Preeklampsi/Eklampsi



Gambar 4.3 Alur Pengelolaan Preeklampsi/Eklampsi

F. Komplikasi Preeklampsi

Preeklampsia dengan komplikasi adalah keadaan peningkatan tekanan darah pada wanita hamil di atas 160/110 mmHg disertai proteinuria pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih. 10 Penyakit ini merupakan penyakit multifaktorial yang memiliki beragam faktor risiko, meliputi: usia ibu, berat badan berlebih, kelainan ginjal, riwayat persalinan, gangguan plasenta, riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, dan masih banyak faktor risiko lainnya. Preeklampsia dengan komplikasi dikenal pula sebagai the *disease of theory* karena belum terdapat teori yang mampu menjelaskan etiologi dan patogenesis penyakit ini secara jelas. Hal ini berdampak dengan beragamnya kualitas dan teknik penanganan preeklampsia dengan komplikasi oleh praktisi dan rumah sakit di Indonesia (23).

Penelitian terkait preeklamsia berat di beberapa daerah di Indonesia. Penelitian kasus preeklampsia berat di Rumah rumah Dr. Soetomo Surabaya pada tahun 2012-2017, kompli-kasi maternal yang palingbanyak terjadi yaitu, sindrom HELLP sebanyak 13 kasus dan edema paru 10 kasus (24). Studi lain terkait komplikasi akibat preeklampsia yang dilakukan di Rumah rumah Dr. Cipto Mangunkusumo pada periode tahun 2003-2005 pada 210 pasien PEB dan eklampsia. Komplikasi langsung akibat preeklampsia yang paling serig terjadi yaitu sindrom HELLP 45 (21,4%) diikuti DIC 19 (8,9%) dan edema paru 15 (7,1%) (25).

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan, usia 35 tahun, G4P2A1, UK: 38 minggu, dibawa keluarga ke puskesmas dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil anamnesis: ada riwayat preeklampsia sebelumnya, tidak dapat makan dan minum, menggigil dan kejang 1 kali. Hasil pemeriksaan: KU lemah, TD 160/100 mmhg, N 88 x/menit, S 40°C, P 28 x/menit, DJJ 130 x/menit (teratur), keluar darah dan lendir dari kemaluan, pembukaan 4, tampak pucat di bagian dalam kelopak mata, lidah, dan tangan. Oliguri, urine berwarna kehitaman, protein urine ++, dan MAP (+).

Pertanyaan Diskusi

1. Apa diagnosis pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis anda?
3. Apa faktor risiko pada kasus diatas?
4. Tanda bahaya yang muncul pada ibu dan janin?
5. Apakah penatalaksanaan awal yang tepat pada kasus tersebut?
6. Bagaimana mencegah kejang pada kasus diatas?
7. Bagaimana prosedur rujukan pada kasus diatas?

G. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Preeklampsi/Eklampsia
3	Kasus	Preeklampsi/Eklampsi dengan tindakan awal, penanganan kejang dan rujukan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta mampu melakukan penanganan awal, penanganan kejang dan melakukan rujukan
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional

No.	Komponen	Isi
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 35 tahun, G4P2A1, UK: 38 minggu, dibawa keluarga ke puskesmas dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil anamnesis: ada riwayat preeklampsia sebelumnya, tidak dapat makan dan minum, menggigil dan kejang 1 kali. Hasil pemeriksaan: KU lemah, TD 160/100 mmhg, N 88 x/menit, S 40°C, P 28 x/menit, DJJ 130 x/menit (teratur), keluar darah dan lendir dari kemaluan, pembukaan 4, tampak pucat di bagian dalam kelopak mata, lidah, dan tangan. Oliguri, urine berwarna kehitaman, protein urine ++, dan MAP (+). TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan.

No.	Komponen	Isi
		5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS Jika peserta meminta data tambahan atau melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai, penguji dapat memberikan informasi berikut: 1. Kejang 1 kali di rumah 2. Riwayat Antenatal Care lengkap 3. Belum pernah mendapatkan obat anti hipertensi Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: 1. Menilai ulang kondisi ibu, janin dan tanda vital 2. Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas 3. Memposisikan ibu miring kiri 4. Memberikan O2 4-6liter 5. Menyiapkan/memasang infus cairan 6. Menganjurkan atau menyiapkan pengosongan kandung kemih- 7. Menyiapkan kolaborasi untuk pemberian magnesium sulfat loading dose untuk mencegah kejang berulang/rujukan segera 8. Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 4. PS berperan sebagai ibu eklampsi. 5. PS tampak cemas, lelah, dan gelisah serta mengeluh sakit kepala 6. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.

No.	Komponen	Isi
		7. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya saki kepala, mata berkunang-kunang Peserta: Sejak kapan merasa pusing dan mata berkunang-kunang? PS: Sejak tadi pagi setelah subuh Peserta: Apakah ibu minum obat? PS: tidak minum obat apapun Peserta: Apakah kehamilan sebelumnya pernah mengalami keluhan seperti ini PS: ya pada kehamilan ke 3 Peserta: Apakah ada Riwayat darah tinggi sebelumnya? PS: Tidak ada bu Peserta: Ibu sudah kejang 1 kali dirumah, maka perlu penanganan segera

No.	Komponen	Isi
		PS: baik bu, bisa bantu saya Peserta: Saya akan melakukan Tindakan awal untuk mencegah kejang berulang PS: ya bu Peserta: Ibu juga perlu dilakukan rujukan ke Rumah Sakit karena mengalami eklampsi atau kejang PS: ya bu, saya ikuti arahan bidan yang penting saya dan janin saya selamat Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar kasus preeklampsi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: -Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin sebelum dan sesudah ujian -Mengganti lembar kasus atau lembar instruksi bila diperlukan -Memastikan seluruh peralatan di setiap station siap digunakan oleh peserta berikutnya -Membantu memastikan cairan infus dummy dan alat simulasi dalam kondisi siap pakai
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1

No.	Komponen	Isi
		8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. O2 18. Magnesium Sulfat 20% dan 40% 19. Syring pump dan infus pump 20 Spuit 20 cc 21. Formulir rujukan — 1 lembar 22. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 23. Pena — 1
13	Penulis	Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. 3. World Health Organization. (2017). Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.). 4. Espinoza J, Vidaeff A, Pettker CM, Simhan H. ACOG PRACTICE BULLETIN Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists. Obstetrics & Gynecology [Internet]. 2020 Jun 22;135(6). Available from: http://journals.lww.com/greenjournal 5. Poon LC, Nguyen-Hoang L, Smith GN, Bergman L, O'Brien P, Hod M, et al. Hypertensive disorders of pregnancy and

No.	Komponen	Isi
		long-term cardiovascular health: FIGO Best Practice Advice. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2023 Jan 1;160(S1):22–34. doi:10.1002/ijgo.14540 PubMed PMID: 36635079.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Kegawatdaruratan Obstetri – Eklampsia

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama (Sakit kepala, mata berkunang-kunang)		
2. Riwayat Kehamilan sekarang (Sejak kapan tekanan darah tinggi muncul, berapa kali melakukan pemeriksaan, obat-obatan apa yang dikonsumsi)		
3. Riwayat preeklampsi seelumnya (kehamilan keberapa, apakah pernah kejang kehamilan sebelumnya, obat-obatan yang dikonsumsi)		
4. Keluhan yang menyertai (lemes, mual dan nyeri ulu hati)		
5. Kondisi bayi saat ini		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, persalinan sebelumnya)		
7. Riwayat kesehatan ibu (anemia, hipertensi, gangguan pembekuan darah, operasi)		
8. Kondisi ibu saat ini (asupan makan/minum, BAK terakhir, kelelahan)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Menilai jumlah perdarahan		
d. Menilai tonus uterus (palpasi fundus uteri)		
e. Menilai kemungkinan robekan jalan lahir		
f. Menilai kelengkapan plasenta		
g. Menyimpulkan adanya perdarahan postpartum		
h. Melakukan masase uterus		
i. Memberikan uterotonika sesuai kewenangan		
j. Memposisikan ibu dengan aman (misalnya posisi datar/miring kiri)		
k. Menyiapkan atau memasang infus cairan		
l. Mengosongkan kandung kemih		
m. Melakukan pemantauan ulang kondisi ibu		
n. Menyiapkan kolaborasi/rujukan segera		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mendokumentasikan temuan dan tindakan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.

- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan kemungkinan rujukan		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memperhatikan respons ibu		
4. Komunikasi jelas dan tenang		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 *(dicatat di rubrik penilaian)*

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kegawatdaruratan Obstetri: Preeklampsi/Eklampsi dan Tindakan awal, penanganan kejang dan rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Preeklampsi/Eklampsi dan Tindakan awal, penanganan kejang dan rujukan
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa selama praktik klinik. Penilai mengamati tindakan mahasiswa secara langsung pada situasi klinik nyata, kemudian memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai. Domain yang umumnya dinilai meliputi informed consent, persiapan pra-tindakan, keterampilan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu Ibu intrapartum preeklampsi/eklampsi, kemudian menilai keterampilan mahasiswa dalam melakukan tindakan awal seperti stabilisasi: pemberian O2, pemasangan infus dan magnesium sulfat, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta persiapan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan awal secara cepat, sistematis, dan aman pada kasus eklampsia intrapartum dengan tetap mengutamakan keselamatan ibu. WHO dan ACOG menekankan pentingnya penanganan cepat dan efektif pada eklampsia intrapartum untuk mencegah morbiditas dan mortalitas maternal..	Mahasiswa dinilai tidak hanya dari pemahamannya tentang konsep eklampsia intrapartum, tetapi juga dari kemampuannya mengenali tanda gejala dari preeklampsia/eklampsia, menilai kondisi ibu, melakukan stabilisasi awal, serta menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan..
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya kemampuan	Seorang perempuan, usia 35 tahun, G4P2A1, UK: 38 minggu, dibawa keluarga ke puskesmas dengan keluhan penurunan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Preeklampsi/Eklampsi dan Tindakan awal, penanganan kejang dan rujukan
	mengenali tanda eklampsia intrapartum, melakukan tindakan awal, serta menentukan kebutuhan rujukan. WHO dan ACOG menempatkan penanganan cepat dan pemberian MGSO4 sebagai langkah penting dalam pengelolaan eklampsia intrapartum.	kesadaran. Hasil anamnesis: ada riwayat preeklampsia sebelumnya, tidak dapat makan dan minum, menggigil dan kejang 1 kali. Hasil pemeriksaan: KU lemah, TD 160/100 mmhg, N 88 x/menit, S 40°C, P 28 x/menit, DJJ 130 x/menit (teratur), keluar darah dan lendir dari kemaluan, pembukaan 4, tampak pucat di bagian dalam kelopak mata, lidah, dan tangan. Oliguri, urine berwarna kehitaman, protein urine ++, dan MAP (+).
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur klinik tertentu, bukan sekadar mendiskusikan kasus. Pada topik ini, keterampilan yang diamati meliputi penilaian kondisi ibu, pemeriksaan tanda vital, palpasi uterus, pemasangan infus, pemberian mGSO4, dan pemantauan kondisi ibu. WHO dan ACOG juga menekankan pentingnya tindakan cepat seperti MGSO4.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan tanda vital, observasi tekanan darah dan kejang berulang, DJJ janin, pembukaan dan kontraksi uterus dan menjelaskan perlunya pemantauan serta kemungkinan rujukan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan meminta bantuan jika diperlukan, rencana pascatindakan, dan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu dalam penanganan awal kasus preeklampsi/eklampsi intrapartum, dan kesesuaian dosis MGSO4, dan tekanan darah serta mampu melakukan tindakan awal secara tepat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Preeklampsi/Eklampsi dan Tindakan awal, penanganan kejang dan rujukan
	profesionalisme. Dalam konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan penangan awal dan penanganan kejang serta rujukan	
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada kasus preeklampsi/eklampsi intrapartum, WHO dan ACOG menekankan pentingnya penanganan cepat untuk mencegah kejang berulang.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu mengenali kondisi gawat secara cepat, memberikan MGSO4 dengan benar, memasang infus cairan, memantau kondisi ibu, serta mempertimbangkan rujukan segera.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah tindakan selesai dan berisi hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik serta area yang perlu diperbaiki. Form DOPS biasanya juga memuat komentar assessor mengenai kekuatan mahasiswa dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pengkajian awal, tetapi masih perlu meningkatkan kecepatan dalam mengenali tanda kegawatan atau ketelitian dalam memperkirakan dosis MGSO4
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan didasarkan pada ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut dan aman. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila tidak mampu memberikan MGSO4 atau salah menentukan prioritas tindakan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Preeklampsi/Eklampsi dan Tindakan awal, penanganan kejang dan rujukan
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran pada level does, karena performa diamati secara langsung saat melakukan tindakan klinik pada pasien nyata atau simulasi.	Pada kasus preeklampsi/eklampsi intrapartum, mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan obstetri secara langsung, cepat, aman, dan profesional di lahan praktik.

PORTOFOLIO

Bukti yang Dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Portofolio bukan hasil dari satu kali ujian saja
- Portofolio menunjukkan **bukti konsistensi kompetensi mahasiswa dari waktu ke waktu**

Tabel. Portofolio pada Kegawatdaruratan Obstetri: Preeklampsi/Eklampsi dan Tindakan awal, penanganan kejang dan rujukan

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata	Pada topik preeklampsi/eklampsi intrapartum, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kondisi ibu intrapartum, mengenali tanda gejala preeklampsi/eklampsia, melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
	mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	berdasarkan umpan balik dari pembimbing.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu bersalin preeklampsi/eklampsi intrapartum, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI. Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu dengan preeklampsi/eklampsi intrapartum, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau Clinical Instructor (CI).
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan penanganan awal preeklampsi/eklampsi intrapartum di laboratorium keterampilan klinik. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian ibu intrapartum, memasang infus, memberikan MGSO4 dan mempersiapkan rujukan pada kasus preeklampsi/eklampsi intrapartum.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Seorang perempuan, usia 35 tahun, G4P2A1, UK: 38 minggu, dibawa keluarga ke puskesmas dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil anamnesis: ada riwayat preeklampsia sebelumnya, tidak dapat makan dan minum, menggigil dan kejang 1 kali.. Mahasiswa mencatat data pemeriksaan, tindakan awal yang dilakukan seperti pemberian MGSO4, pemasangan infus, serta keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan	Mahasiswa merefleksikan pentingnya mengenali preeklampsi/eklmapsia intrapartum secara dini, melakukan tindakan cepat seperti pemasangan infus dan pemberian MGSO4 serta pentingnya komunikasi dengan keluarga dan tim kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan obstetri.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pengkajian kondisi ibu dan dan pemberian MGSO4, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam memperkirakan dosis MGSO4 serta kecepatan dalam mengambil keputusan rujukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus : Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus preeklampsi/eklmapsia intrapartum, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu mengenali preeklampsi/eklmapsia intrapartum dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik pembimbing, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan penilaian awal ibu preeklampsi/eklmapsia intrapartum, mengenali tanda kegawatan, serta melakukan tindakan awal yang tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik preeklampsi/eklmapsia intrapartum, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep teori, tetapi juga mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan obstetri secara langsung, aman, dan profesional di lahan praktik.

Tabel. Case Report pada Kegawatdaruratan Obstetri: preeklampsi/eklampsia intrapartum, pananganan awal, kejang dan rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu intrapartum yang mengalami preeklampsia/eklampsia intrapartum dengan kejang
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, proses stabilisasi ibu, serta keputusan rujukan dan perkembangan kondisi ibu setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini mahasiswa menuliskan keluhan sakit kepala dan mata berkunang-kunang, serta nyeri uluhati dan kejang 1 kali, tekanan darah meningkat, protein urine ++, urine berwarna gelap dan oliguri, analisis Eklampsia kemungkinan faktor risiko paritas tinggi dan usia ekstreme, Riwayat preeklampsi sebelumnya, tindakan awal berupa pasang O2, pemasangan infus cairan, pemberian MGSO4 loading dose, serta persiapan rujukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan sakit

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
	klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	kepala dan mata berkunang-kunang, serta nyeri uluhati dan kejang 1 kali, tekanan darah meningkat, protein urine ++, urine berwarna gelap dan oliguri, analisis Eklampsia kemungkinan faktor risiko paritas tinggi dan usia ekstreme, Riwayat preeklampsi sebelumnya sebagai tanda eclampsia intrapartum yang memerlukan tindakan segera.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, serta kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah	Dari kasus eclampsia intrapartum mahasiswa belajar bahwa pengenalan dini preeklampsia/eclampsia intrapartum, tindakan cepat, serta stabilisasi awal ibu sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat..
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep preeklampsia/eclampsia intrapartum, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh dan sistematis.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Obstetri: preeklampsi/eklampsia intrapartum, pananganan awal, kejang dan rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus preeklampsi/eklampsia intrapartum, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali preeklampsi/eklampsia intrapartum dapat menyebabkan syok kejang berulang, koma dan membahayakan keselamatan ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti tidak memantau adanya kejang berulang, tidak observasi MGSO4, atau menunda tindakan dapat meningkatkan risiko komplikasi serius pada ibu.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah kejang berulang dan koma
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan mengenali preeklampsi/eklampsia intrapartum, tidak memberikan MGS4, serta keterlambatan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemantauan tekanan darah dan kejang berulang secara berkala selama intrapartum dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perdarahan Postpartum dan Tindakan Awal
		postpartum, pemberian MGS4 sesuai protokol, pemantauan tanda vital, stabilisasi awal ibu, serta komunikasi cepat kepada keluarga dan tim kesehatan.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal tersebut akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kasus preeklampsi/eklampsia intrapartum, deteksi dini, tindakan cepat, serta kemampuan mengambil keputusan rujukan merupakan bagian penting dari praktik kebidanan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan klinis, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko serta meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

H. Ringkasan

Preeklampsia (PE), penyakit multisistem yang merupakan karakteristik kehamilan pada manusia, ditandai dengan gangguan disfungsi endotel yang menyebabkan Hipertensi karena vasokonstriksi, ditandai proteinuria terkait dengan kerusakan glomerulus, dan edema sekunder akibat pening-katan permeabilitas pembuluh darah. PE diperkirakan menjadi komplikasi 2-8% dari semua kehamilan. PE adalah penyebab utama kematian ibu, morbiditas ibu yang parah, perawatan intensif di rumah sakit, operasi caesar, dan premature.

Banyak faktor yang sering ditemukan penyebab terjadinya preeklampsia (multiple causation), baik itu faktor internal (usia ibu, obesitas, paritas, jarak kehamilan, riwayat keturunan, riwayat preeklampsia, stres dan kecemasan, serta riwayat hipertensi) maupun eksternal ibu (paparan asap rokok, antioksidan, natrium, MSG, status pendidikan, riwayat antenatal care/ANC serta pengaruh zat gizi yang dikonsumsi ibu).

Penelitian yang dilakukan Ramie dkk, 2018 mengungkapkan bahwa Ada hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan preeklampsia sebelumnya dengan kejadian preeklampsi. Faktor risiko preeklampsia: kehamilan multifetal, diabetes pregestasional, hipertensi kronis (faktor risiko tinggi) dan nuliparitas, indeks massa tubuh lebih besar dari 30, usia ibu 35 tahun atau lebih, interval lebih dari 10- tahun sejak kelahiran terakhir, dan memiliki status sosial ekonomi rendah. Faktor risiko PE (usia ibu, obesitas, riwayat PE, gagal hamil/abortus, HT dan diabetes melitus, dan lain-lain.) telah dipelajari secara ekstensif dalam berbagai studi epidemiologi. Penelitian yang dilakukan Ramie dkk, 2018 mengungkapkan bahwa Ada hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan preeklampsia sebelumnya dengan kejadian preeklampsi.

Penatalaksanaan preeklampsia tidak berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, penata-laksanaan preeklampsia yang efektif dapat dibagi menjadi tiga kategori; pencegahan preeklampsia, deteksi dini, dan perlakuan. Wanita dianggap berisiko tinggi mengalami preeklampsia (seperti pada hipertensi kronis, penyakit ginjal atau sindrom antifosfolipid harus dirujuk untuk diberikan konseling pra-kehamilan untuk mengidentifikasi faktor risiko). Penatalaksanaan ini mungkin melibatkan penghentian nasihat merokok, saran diet, penyesuaian obat untuk mengoptimalkan kondisi medis seperti penyakit ginjal yang sudah ada sebelumnya, dan mengurangi makanan yang banyak mengan-dung MSG dan tinggi garam sehingga merangsang terjadinya hipertensi.

Alur Asuhan Singkat

Ibu intrapartum dengan preeklampsi/eklampsia → nilai cepat kondisi ibu dan tanda vital → identifikasi penyebab berdasarkan faktor risiko preeklampsi → lakukan

tindakan awal (pasang O2, pasang infus, pemberian MGSO4) → pantau kondisi ibu → tentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan → dokumentasi dan handover yang jelas.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Kegawatdaruratan Obstetri: Preeklampsia/Eklampsia intrapartum

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Tekanan darah 160/100mmHg	Mengarah pada preeklampsia intrapartum	Lakukan penilaian cepat dan tindakan awal
Adanya kejang 1 kali	Mengarah eclampsia intrapartum	Pemasangan infus dan pemberian MGSO4 sesuai dengan prosedur
Adanya oliguri, protein urine ++, urine berwarna gelap	Eclampsia disertai dengan gejala yang berat	Lakukan evaluasi adanya kejang berulang
Ibu tampak gelisah, lemas, sakit kepala dan mata berkunang-kunang	Kemungkinan kejang berulang	Pemantauan ketat dan stabilisasi segera
Penurunan kesadaran atau tanda syok	Kegawatdaruratan maternal	Resusitasi awal dan rujukan emergensi

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Bab: Preeklampsia/Eklampsia – Tindakan Awal, penanganan kejang dan rujukan

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi Preeklampsia/eclampsia intrapartum	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan klasifikasi preeklampsia	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan faktor risiko preeklampsia	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan anamnesis pada ibu intrapartum dengan preeklampsia/eklampsia	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali tanda dan gejala preeklampsia/eklampsia	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa observasi adanya kejang berulang pada eklampsia	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menilai faktor risiko preeklampsi	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada ibu dan janin	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan Tindakan awal pada preeklampsi/eklampsi intrapartum	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan MGSO4 sesuai dengan kewenangan	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyiapkan pemasangan infus cairan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memantau kondisi ibu secara sistematis	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu kepada keluarga	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dirujuk	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
15	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover dengan jelas	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan tindakan secara lengkap	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Daftar Pustaka

Zhong WG, Wang Y, Zhu H, Zhao X. Meta analysis of angiotensin-converting enzyme I/D polymorphism as a risk factor for preeclampsia in Chinese women. Genet Mol Res. 2012;11(3):2268–76. doi:10.4238/2012.May.21.1 PubMed PMID: 22653650.

Alladin AA, Harrison M. Preeclampsia: Systemic endothelial damage leading to increased activation of the blood coagulation cascade. J Biotech Res. 2012;4(1):26–43.

Fatkhiyah N. Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing), Volume 11, No.1, Maret 2016. Jurnal Keperawatan Soedirman. 2016;11(1):53–61.

Wang A, Rana S, Karumanchi SA. Preeclampsia: The role of angiogenic factors in its pathogenesis. Physiology. 2009;24(3):147–58. doi:10.1152/physiol.00043.2008 PubMed PMID: 19509125.

Matsuo K, Kooshesh S, Dinc M, Sun CCJ, Kimura T, Baschat AA. Late postpartum eclampsia: Report of two cases managed by uterine curettage and review of the literature. Am J Perinatol. 2007;24(4):257–66. doi:10.1055/s-2007-976548 PubMed PMID: 17447188.

Salafia CM, Pezzullo JC, Ghidini A, Lopèz-Zeno JA, Whittington SS. Clinical correlations of patterns of placental pathology in preterm pre-eclampsia. Placenta. 1998;19(1):67–72. doi:10.1016/S0143-4004(98)90100-X PubMed PMID: 9481787.

Matsubara K, Matsubara Y, Uchikura Y, Sugiyama T. Pathophysiology of preeclampsia: The role of exosomes. Int J Mol Sci. 2021;22(5):1–14. doi:10.3390/ijms22052572 PubMed PMID: 33806480.

Uzan Jennifer, Carbonnel Marie , Piconne Olivier , Asmar Roland MAJ. Pre-eclampsia: pathophysiology, diagnosis, and management. Environmental Science and Engineering. 2012;7:467–74. doi:10.1007/978-3-540-88256-5_13

Roberts JM, Escudero C. The placenta in preeclampsia. Pregnancy Hypertens. 2012;2(2):72–83. doi:10.1016/ j.preghy.2012.01.001 PubMed PMID: 22745921.

Young BC, Levine RJ, Karumanchi SA. Pathogenesis of preeclampsia. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease. 2010;5:173–92. doi:10.1146/annurev-pathol-121808-102149 PubMed PMID: 20078220.

Granger JP, Alexander BT, Llinas MT, Bennett WA, Khalil RA. Pathophysiology of Hypertension During Preeclampsia Linking Placental Ischemia With Endothelial Dysfunction. Hypertension. 2001;38(2):718–22.

Zachary I, Gliki G. Signaling transduction mechanisms mediating biological actions of the vascular endothelial growth factor family. Cardiovasc Res. 2001;49(3):568–81. doi:10.1016/S0008-6363(00)00268-6 PubMed PMID: 11166270.

De Falco S. The discovery of placenta growth factor and its biological activity. Exp Mol Med. 2012;44(1):1–9. doi:10.3858/emm.2012.44.1.025 PubMed PMID: 22228176.

Gilbert JS, Ryan MJ, Lamarca BB, Sedeek M, Murphy SR, Granger JP. Pathophysiology of hypertension during preeclampsia: Linking placental ischemia with endothelial dysfunction. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2008;294(2):718–22. doi:10.1152/ajpheart.01113.2007 PubMed PMID: 18055511.

Wolf M, Shah A, Lam C, Martinez A, Smirnakis K V., Epstein FH, et al. Circulating levels of the antiangiogenic marker sFLT-1 are increased in first versus second pregnancies. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(1):16–22. doi:10.1016/ j.ajog.2005.03.016 PubMed PMID: 16021053.

Levine RJ, Thadhani R, Lim K hak, Yu KF, Blink AL, Sachs BP, et al. Urinary Placental Growth Factor and Risk of Preeclampsia. JAMA - Journal of the American Medical Association. 2005;293(1):77–85.

Palei AC, Spradley FT, Warrington JP, George EM, Granger JP. Pathophysiology of hypertension in pre-eclampsia: A lesson in integrative physiology. Acta Physiologica. 2013;208(3):224–33. doi:10.1111/apha.12106 PubMed PMID: 23590594.

Tambunan GW, Wibisono AH. Gambaran Histopatologi Plasenta pada Kehamilan Normotensif dan Kehamilan dengan Klinis Preeklampsia. Vol. 39. 2006;39(1).

Ramie Agustine, Fahreza M. RIWAYAT KELUARGA PREEKLAMPSI MENINGKATKAN KEJADIAN PREEKLAMPSI. Jurnal Citra Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. 2018;6(2):35–51.

Bartsch E, Medcalf KE, Park AL, Ray JG, Al-Rubaie ZTA, Askie LM, et al. Clinical risk factors for pre-eclampsia determined in early pregnancy: Systematic review and meta-analysis of large cohort studies. The BMJ. 2016;353. doi:10.1136/bmj.i1753 PubMed PMID: 27094586.

Espinoza J, Vidaeff A, Pettker CM, Simhan H. ACOG PRACTICE BULLETIN Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists. Obstetrics & Gynecology [Internet]. 2020 Jun 22;135(6). Available from: http://journals.lww.com/greenjournal

Poon LC, Nguyen-Hoang L, Smith GN, Bergman L, O'Brien P, Hod M, et al. Hypertensive disorders of pregnancy and long-term cardiovascular health: FIGO Best Practice Advice. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2023 Jan 1;160(S1):22–34. doi:10.1002/ijgo.14540 PubMed PMID: 36635079.

Abarham Martadiansyah, Anugrah Qalbi BS. Prevalensi Kejadian Preeklampsia dengan Komplikasi dan Faktor Risiko yang Mempengaruhinya di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Studi Prevalensi Tahun 2015, 2016, 2017). SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE. 2017;2(December):14–25.

Wijayanti E. Luaran Maternal dan Neonatal pada Preeklampsia Berat Perawatan Maternal and Neonatal Outcomes in Severe Preeclampsia Patient with Conservative Treatment at Dr. Soetomo Surabaya Hospital. Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science. 2017;2(2):128–36.

Annafi MI, Jumsa MR, Budyono C. Gambaran Preeklampsia Berat dengan Komplikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Januari 2018 sampai Desember 2019. Vol. 1. 2022;1(1):17–22.

BAB 5

RUJUKAN INTRAPARTUM DAN TRANSPORT AMAN: KOMUNIKASI, DOKUMENTASI, DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

Capaian Pembelajaran

CAPAIAN PEMBELAJARAN BAB 7	
CPL 1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam pelayanan kebidanan
CPL 2	Menerapkan komunikasi terapeutik serta kolaborasi efektif dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.
CPL 3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko pada asuhan intrapartum.
CPL 7	Mendokumentasikan asuhan dan rujukan secara akurat serta memanfaatkan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi mutu dan pengembangan diri.
CPMK Utama	CPMK-2 (Komunikasi terapeutik & kolaborasi interprofesional pada rujukan)
CPMK Penguat`	CPMK 7 (Menyusun dokumentasi klinis (termasuk partograf) dan dokumen rujukan secara akurat serta menggunakan data untuk evaluasi mutu). CPMK 1 (Menerapkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan persalinan dan situasi kegawatdaruratan intrapartum).

Sub-CPMK 14.1	Menyampaikan informasi rujukan terstruktur (mis. SBAR) dan memperoleh persetujuan tindakan secara etis.
Sub-CPMK 14.2	Menyusun dokumentasi rujukan dan rencana transport aman termasuk pendampingan keluarga dan serah-terima.

Peta Kompetensi Bab

Sub-CPMK	Indikator Kunci
14.1 – Komunikasi & Informed Consent	Mampu menggunakan SBAR/ISBAR untuk serah-terima; memperoleh persetujuan secara etis dan terdokumentasi
14.2 – Dokumentasi & Transport Aman	Mampu menyusun surat rujukan, partograf, dan rencana transport; memastikan pendampingan keluarga & kontinuitas asuhan

Uraian Materi

A. Teori: Rujukan Intrapartum Dan Transport Aman

1. Konsep Dasar Rujukan Intrapartum

Rujukan intrapartum adalah proses memindahkan ibu yang sedang bersalin dari fasilitas kesehatan primer atau menengah ke fasilitas dengan kapasitas perawatan yang lebih tinggi. Hal ini biasanya dilakukan jika kondisi ibu atau janinnya memerlukan perawatan yang lebih intensif. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa keterlambatan dalam mengambil Keputusan untuk melakukan rujukan adalah salah satu penyebab utama kematian ibu. Selain itu, keterlambatan mendapatkan pertolongan dan keterlambatan mendapatkan pelayanan yang tepat juga berkontribusi terhadap kematian ibu (*Three Delays Model)* (WHO, 2023b).

Oleh karena itu, sistem rujukan yang efektif sangat penting. Sistem ini bukan hanya memindahkan pasien, tetapi juga melibatkan komunikasi yang baik, dokumentasi yang lengkap, stabilisasi kondisi pasien, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, ibu dan janin dapat menerima perawatan yang tepat dan mengurangi risiko kematian.

Dalam konteks kebidanan di Indonesia, merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap sesuai standar PONED dan PONEK adalah bagian dari manajemen risiko intrapartum. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% kematian ibu terjadi pada periode intrapartum dan pascapersalinan dini. Sebagian besar kematian ini dapat dicegah jika sistem rujukan berfungsi dengan optimal. Konsep rujukan berencana *(planned referral)* berbeda dengan rujukan darurat *(emergency referral).* Keduanya memerlukan persiapan yang berbeda, tetapi tetap mengutamakan keselamatan ibu dan janin sebagai prioritas utama. Rujukan berencana dan rujukan darurat keduanya penting dalam manajemen risiko intrapartum. Dengan demikian, keselamatan ibu dan janin dapat terjamin (Kemenkes RI, 2023c).

Penelitian yang dilakukan oleh (Radovich et al., 2021) di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa dokumentasi rujukan, komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan yang merujuk dan yang menerima, Jalur rujukan yang lebih singkat, dan kecepatan rujukan sangat penting untuk keberhasilan sistem rujukan. Bidan yang dapat menyampaikan informasi dengan jelas, benar, dan tepat waktu dapat membantu mengurangi waktu tunggu di tempat penerima dan membuat tim lebih siap untuk menangani kondisi darurat. Oleh karena itu,

kemampuan berkomunikasi dengan efektif sangatlah penting bagi bidan dalam memberikan asuhan yang berkualitas saat proses melahirkan.

2. Indikasi Rujukan Intrapartum

Pengambilan keputusan untuk melakukan rujukan intrapartum ini didasarkan pada penilaian klinis yang komprehensif terhadap kondisi ibu dan janin. Menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Obstetri dan Ginekologi, indikasi rujukan intrapartum dapat dibagi berdasarkan sistem organ yang terkena dampak dan tingkat urgensi klinis.(Kemenkes RI, 2025)

a. Indikasi Maternal

Kebijakan Kemenkes dalam menurunkan AKI di antaranya mengembangkan PONED dan PONEK, di mana beberapa komponen pelayanan maternal yang ditangani mencakup pre-eklampsia/eklampsia dan tindakan obstetri pada pertolongan persalinan.

1) Perdarahan intrapartum — meliputi plasenta previa dan solusio plasenta, yang merupakan ancaman jiwa langsung bagi ibu.
2) Pre-eklampsia berat / Eklampsia — ditandai tekanan darah ≥160/110 mmHg disertai tanda-tanda multiorgan, atau kejang aktif saat proses persalinan.
3) Persalinan lama / Partus macet — kemajuan persalinan tidak sesuai kurva partograf (garis waspada dan garis bertindak).
4) Ruptur uteri (iminens atau komplit) — nyeri perut hebat mendadak, kontraksi berhenti, perdarahan tersembunyi.
5) Infeksi / Sepsis intrapartum — korioamnionitis ditandai demam ≥38°C, air ketuban berbau, takikardi ibu dan janin.
6) Inversio uteri — uterus terbalik pada kala III persalinan disertai perdarahan dan syok.
7) Emboli air ketuban / pulmoner — kolaps mendadak, sesak napas berat, dan syok kardiogenik.

b. Komplikasi pada Janin / Proses Persalinan

Faktor pada saat persalinan yang menyebabkan kegawatdaruratan neonatal antara lain persalinan dengan infeksi intrapartum dan persalinan dengan penggunaan obat sedatif.

1) Gawat janin (fetal distress) — DJJ <100 atau >180 kali/menit, adanya mekonium dalam air ketuban.
2) Prolaps / tali pusat terkemuka — tali pusat berada di depan atau di samping bagian terendah janin.
3) Distosia bahu — kepala lahir tetapi bahu anterior macet di simfisis pubis (turtle sign).

4) Presentasi abnormal — letak lintang, presentasi bokong dengan komplikasi, atau presentasi dahi/muka yang tidak dapat dilahirkan pervaginam.
5) KPD dengan tanda infeksi atau preterm — air ketuban pecah >18 jam disertai tanda korioamnionitis atau usia gestasi <37 minggu.
6) Kehamilan ganda dengan komplikasi — gemeli dengan presentasi abnormal atau distosia.
7) Disproporsi kepala-panggul (CPD) — kepala tidak turun meskipun his adekuat.

3. Komunikasi Terstruktur dalam Rujukan: Metode SBAR dan ISBAR

Komunikasi sangat penting dalam menjaga keselamatan pasien. Ketika komunikasi gagal, hal ini dapat menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan dalam pelayanan obstetri. Komunikasi yang baik sangatlah penting, karena kegagalan komunikasi dapat menyebabkan cedera serius pada pasien. masalah ini dapat timbul karena kegagalan handover, kesalahan diagnosis, kesalahan tatalaksana, dan komunikasi yang tidak efisien antara pasien dan tenaga Kesehatan. Beberapa hal yang menghambat komunikasi dalam obstetri antara lain lingkungan klinis yang tidak mendukung, seperti beban kerja yang terlalu berat dan tekanan waktu, selain itu, dinamika hubungan antar profesi dan hierarki juga dapat mempengaruhi komunikasi. Faktor personal masing-masing tenaga kesehatan juga dapat menjadi hambatan, serta kurangnya pelatihan komunikasi yang terstruktur. dari semua faktor tersebut, tekanan waktu dan kekurangan staf adalah hambatan terbesar dalam praktik sehari-hari (Derksen et al., 2022; Schmiedhofer et al., 2021).

Penelitian telah membuktikan bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam pelayanan obstetri. Tinjauan sistematis terhadap 71 studi menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada aspek teknis komunikasi, termasuk efektivitas handover, dari 71 studi tersebut, 16 di antaranya melaporkan perbaikan luaran klinis nyata setelah intervensi komunikasi interprofesional. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan komunikasi tim dapat berdampak langsung dan terukur terhadap keselamatan ibu dalam pelayanan obstetric (Lippke et al., 2021) (Hüner et al., 2023).

Metode SBAR *(Situation, Background, Assessment, Recommendation*) dan variannya ISBAR *(Introduction, Situation, Background, Assessment, Recommendation)* adalah cara berkomunikasi yang direkomendasikan oleh WHO *Patient Safety Programme* yang menganjurkan penggunaan metode ini saat serah terima dan rujukan pasien kritis. Penelitian yang dilakukan De Meester et al. di Belgia menunjukkan hasil yang positif ketika metode ISBAR diterapkan dalam komunikasi obstetri darurat, kelengkapan informasi yang disampaikan

meningkat sebesar 62%. Selain itu, kesalahan medikasi selama proses transfer pasien dapat dikurangi sebesar 44% (De Meester et al., 2020).

a. Komponen ISBAR dalam Konteks Rujukan Intrapartum (Institute for Healthcare Improvement, 2017)

Tabel 5.1. Komponen ISBAR

I	**IDENTIFY (Identifikasi)**	• Nama petugas kesehatan yang melapor • Nama & identitas pasien (nama, usia, No. RM, No. KIA) • Lokasi perujuk (puskesmas/klinik/RS) • Waktu dan tanggal rujukan
S	**SITUATION (Situasi)**	• Status persalinan: fase laten / aktif / kala II / kala III • Tanda vital ibu: TD, Nadi, Suhu, RR, SpO2 • DJJ: frekuensi dan regularitas • Keluhan aktif: perdarahan, sesak, kejang
B	**BACKGROUND (Latar Belakang)**	• Riwayat obstetri: G_P_A_H_, HPHT, usia gestasi • Jumlah kunjungan dan hasil ANC • Penyulit: anemia, pre-eklampsia, kelainan letak • Obat/tindakan yang telah diberikan • Hasil lab/USG terakhir
A	**ASSESSMENT (Penilaian)**	• Diagnosis primer dan sekunder • Derajat kegawatan: Merah / Kuning / Hijau • Kondisi janin: baik / gawat janin / IUFD • Tren kondisi: memburuk / stabil / membaik
R	**RECOMMENDATION (Rekomendasi)**	• Persiapan dibutuhkan: OK, NICU, darah • Moda transportasi dan estimasi waktu tiba (ETA) • Kondisi pasien saat berangkat & pendamping • Konfirmasi penerimaan & nama dokter penerima

CONTOH PENERAPAN ISBAR: KASUS PARTUS MACET + PEB

Berikut adalah simulasi penerapan ISBAR pada kasus Kala II Macet dengan Pre-eklampsia Berat, yang merupakan salah satu indikasi rujukan intrapartum paling sering dan memiliki risiko kematian tertinggi apabila tidak ditangani segera.

Komponen	Contoh Komunikasi
I — Identify	*"Selamat pagi, saya Bidan Sari dari Puskesmas Cempaka. Saya ingin merujuk pasien Ny. Aminah, 28 tahun, No. KIA 12345, pada pukul 08.30 WIB."*
S — Situation	*"Pasien dalam kala II persalinan selama 2 jam tanpa kemajuan. TD 160/110 mmHg, Nadi 100x/mnt, DJJ 160x/mnt ireguler. Terdapat edema tungkai dan protein urine 3+."*
B — Background	*"G2P1A0, hamil 38 minggu, HPHT 1 Januari. ANC 6x di posyandu. Riwayat hipertensi dalam kehamilan. Sudah diberikan MgSO4 4g IV bolus dan infus RL. Hb 10,2 g/dL, golongan darah O+."*
A — Assessment	*"Kala II Macet dengan Pre-eklampsia Berat. Dicurigai gawat janin. Derajat kegawatan: MERAH."*
R — Recommendation	*"Mohon persiapan kamar operasi untuk seksio sesarea emergensi. Pasien berangkat 10 menit lagi dengan ambulans PONED, didampingi bidan dan dokter umum. Mohon konfirmasi kesiapan penerimaan."*

Kasus di atas mencontohkan bagaimana seluruh komponen ISBAR disampaikan dalam komunikasi telepon terstruktur selama kurang dari 3 menit, namun mengandung seluruh informasi kritis yang dibutuhkan oleh fasilitas penerima untuk bersiap melakukan seksio sesarea emergensi

b. Komunikasi dengan Keluarga: Prinsip Terapeutik

Selain komunikasi dengan sesama tenaga kesehatan, bidan juga harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada ibu dan keluarga saat proses rujukan sedang berlangsung. jika komunikasi dengan keluarga tidak berjalan dengan baik, maka dapat membuat keluarga menjadi cemas, kurang kooperatif, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan bisa menolak rujukan yang akhirnya berakibat fatal.

Pengalaman emosional keluarga selama rujukan obstetri emergensi bersifat intens dan multidimensional. Studi (Nabulo et al., 2023) di Uganda menemukan bahwa ibu yang menjalani rujukan emergensi menggambarkan proses tersebut sebagai *"a worrisome journey"* — perjalanan yang penuh kekhawatiran, kelelahan fisik, dan rasa tidak berdaya. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh ibu, tetapi juga ditularkan kepada anggota keluarga yang mendampingi.

Penelitian fenomenologis di Ghana oleh (Daniels & Abuosi, 2020) mengidentifikasi bahwa suami dan keluarga pasien mengalami kecemasan yang signifikan ketika menghadapi ketidakpastian tentang kondisi ibu dan janin. Mereka sering merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai dari tenaga kesehatan, yang memperburuk respons stress dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan.

Prinsip komunikasi terapeutik kepada keluarga dalam situasi rujukan mencakup beberapa hal penting diantaranya (WHO, 2023b)(WHO, 2023a):

1) Mmenyampaikan kondisi ibu dengan bahasa yang dipahami tanpa menyembunyikan kegawatdaruratannya. Ini sangat penting agar keluarga memahami situasi dengan jelas.
2) Menjelaskan alasan rujukan dan tujuan yang diharapkan, dengan demikian, keluarga akan memahami mengapa rujukan diperlukan dan apa yang diharapkan dari proses ini.
3) Memberikan kesempatan keluarga mengajukan pertanyaan.
   Ini memberi keluarga ruang untuk memahami lebih lanjut tentang situasi dan proses yang akan dijalani.
4) Menjelaskan peran keluarga selama transport dan di fasilitas penerima.
   Ini penting agar keluarga tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat membantu.
5) Memastikan keluarga memiliki informasi kontak dan lokasi fasilitas rujukan.
   Ini penting agar keluarga dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dan melakukan kontak jika diperlukan.

   Dengan demikian, proses komunikasi terapeutik dapat berjalan dengan efektif dan memenuhi kebutuhan keluarga dalam situasi rujukan.

4. Informed Consent dalam Rujukan Intrapartum

Informed consent merupakan elemen legal dan etis yang wajib dipenuhi sebelum setiap tindakan medis, termasuk rujukan. Pada masa intrapartum, terjadi ketegangan antara tanggung jawab untuk bertindak cepat demi keselamatan ibu-janin dan kewajiban untuk menghormati otonomi pasien. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 menegaskan bahwa persetujuan tindakan medis harus

diperoleh secara tertulis, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa di mana tindakan dapat dilakukan tanpa persetujuan demi menyelamatkan nyawa.

Syarat persetujuan diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai. Isi penjelasan minimal mencakup (Kemenkes RI, 2024):

a. Diagnosis
b. Indikasi
c. Tindakan yang dilakukan dan tujuannya
d. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan
e. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
f. Alternatif tindakan lain dan risikonya
g. Risiko apabila tindakan tidak dilakukan
h. Prognosis setelah tindakan

Persetujuan dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, untuk tindakan yang invasif dan memiliki risiko tinggi, persetujuan tertulis harus diperoleh terlebih dahulu. Pihak yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien itu sendiri. Jika pasien tidak mampu memberikan persetujuan, seperti anak-anak atau pasien yang tidak sadar, maka persetujuan dapat diberikan oleh orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan pasien, seperti suami atau istri, anak kandung, ayah atau ibu kandung, atau saudara kandung (Kemenkes RI, 2024).

Persetujuan tertulis harus ditandatangani oleh pasien atau wakilnya, dan disaksikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan tidak dilakukan jika:

a. Tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis
b. Terdapat penolakan dari Pasien atau keluarga Pasien.

Jika rujukan tidak dapat dilakukan, fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk dapat melakukan perawatan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Hal ini dilakukan agar pasien masih mendapatkan perawatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Kemenkes RI, 2024). Dalam situasi kegawatdaruratan obstetri, *informed consent* tidak boleh menjadi penghambat tindakan kegawatdaruratan, namun demikian, bidan wajib mendokumentasikan upaya untuk memperoleh persetujuan, alasan mengapa tindakan dilakukan tanpa persetujuan jika kondisi tidak memungkinkan, serta informasikan kepada keluarga sesegera mungkin setelah kondisi stabil.

Tantangan rujukan obstetri darurat di Indonesia bersifat multidimensi yang mencakup faktor komunitas (persepsi ibu dan keluarga), faktor individu (kepercayaan diri dan pengalaman bidan), faktor sistem kesehatan (alat, obat,

panduan, kebijakan), serta faktor lingkungan (infrastruktur jalan dan jaringan internet) (Rudiyanti & Utomo, 2024).

⚠ Catatan Etik dan Legal: Prinsip Persetujuan dalam Darurat Kebidanan
Prinsip 1 : Keselamatan jiwa selalu menjadi prioritas; jangan tunda tindakan darurat demi persetujuan lengkap.
Prinsip 2 : Dokumentasikan seluruh upaya persetujuan meskipun tidak lengkap.
Prinsip 3 : Gunakan bahasa sederhana; pastikan keluarga memahami, bukan hanya menandatangani.
Prinsip 4 : Jika pasien tidak sadar, izin diperoleh dari wali/keluarga terdekat.
Prinsip 5 : Setelah stabilisasi, lakukan penjelasan ulang dan minta persetujuan untuk tindakan selanjutnya.

5. Dokumentasi Rujukan: Standar, Komponen, dan Praktik Terbaik

Dokumentasi dalam proses rujukan intrapartum memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai alat komunikasi klinis yang memastikan terlaksananya asuhan. Kedua, sebagai dokumen legal yang melindungi pasien serta tenaga kesehatan. Sistem dokumentasi yang buruk, dapat menjadi salah satu faktor yang paling sering terjadi dalam analisis kasus kematian maternal di Indonesia dan di seluruh dunia (WHO, 2023b)(Kemenkes RI, 2024)

a. Komponen Wajib Surat Rujukan Obstetri

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 yang diperkuat oleh Pedoman Teknis Sistem Rujukan (2022), surat rujukan obstetri harus memuat komponen berikut:

1) Identitas lengkap pasien:
   - Nama
   - Tanggal lahir
   - Nomor rekam medis
   - Alamat
   - Nomor BPJS/asuransi
2) Data obstetri:
   - Gravida, paritas, abortus, usia kehamilan, HPHT
   - Riwayat kehamilan (jumlah kunjungan, temuan bermakna)
   - Taksiran persalinan,
   - Riwayat persalinan sebelumnya (cara persalinana, komplikasi)

3) Diagnosis kerja dan diagnosis banding (jika relevan).
4) Temuan klinis terkini:
   - Tanda vital ibu dan kesadaran
   - Hasil pemeriksaan obstetric (DJJ, TFU, presentasi dan posisi janin, kontraksi, pembukaan serviks, kondisi selaput ketuban)
   - Estimasi perdarahan yang telah terjadi dengan melampirkan lembar patograf.
5) Penatalaksanaan Pra-rujukan yang telah diberikan:
   - Obat-obatan yang telah diberikan
   - Tindakan stabilitas yang sudah dilakukan
   - Cairan yang telah diberikan
   - Hasil pemeriksaan penunjang
   - Kondisi pasien setelah stabilisasi.
6) Informasi Tenaga Pendamping
   - Nama dan kualifikasi tenaga kesehatan yang mendampingi selama transport
   - Alat dan obat yang dibawa selama perjalanan
   - Jenis kendaraan/ambulans yang digunakan
7) Alasan merujuk dan tujuan klinis yang diharapkan dari fasilitas penerima.
8) Identitas fasilitas dan tanda tangan tenaga kesehatan perujuk serta stempel fasilitas (nama, Alamat, nomor STR/SIP petugas perujuk, tanggal dan jam rujukan, nomor telepon fasilitas pengirim)
9) Waktu keberangkatan dan perkiraan waktu kedatangan.
   (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2012)

b. Peran Partograf dalam Dokumentasi Rujukan

Partograf adalah dokumen penting dalam perawatan intrapartum yang harus disertakan dalam berkas rujukan. Jika partograf diisi dengan lengkap dan konsisten, maka akan memberikan gambaran kemajuan proses persalinan, kondisi ibu, dan kesejahteraan bayi dengan jelas selama pengamatan di tempat perawatan.

Pada tahun 2018, WHO menerbitkan panduan komprehensif *'Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience'* yang memuat 56 rekomendasi berbasis bukti. Panduan ini merupakan revisi menyeluruh terhadap pendekatan pemantauan persalinan sebelumnya Menurut WHO, dalam panduan intrapartum terbaru, partograf yang lengkap sampai saat merujuk pasien memberikan informasi yang sangat berguna dan tidak bisa digantikan hanya dengan penjelasan lisan saja (WHO, 2018).

Tabel 5.2. Rekomendasi WHO pada Dokumen Partograf

Kategori Rekomendasi	Isi Rekomendasi
Rekomendasi Kuat	Penggunaan partograf untuk memantau kemajuan persalinan direkomendasikan sebagai alat pemantauan standar di fasilitas kesehatan.
Perubahan Penting	WHO 2018 merekomendasikan bahwa fase aktif persalinan dimulai pada pembukaan serviks 5 cm (bukan 4 cm), karena bukti menunjukkan bahwa dilatasi dari 4 ke 5 cm bisa memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.
Batas Waktu Persalinan	Tidak ada lagi batas universal 1 cm/jam. Durasi fase aktif hingga 12 jam (nullipara) dan 10 jam (multipara) dianggap normal sebelum dilakukan intervensi.
Kala Dua	Batas normal kala dua persalinan: 3 jam untuk nullipara (4 jam jika dengan epidural) dan 2 jam untuk multipara (3 jam jika dengan epidural).
Monitoring Janin	Auskultasi intermiten DJJ direkomendasikan sebagai metode standar pemantauan denyut jantung janin selama persalinan tanpa komplikasi.

Sebagai tindak lanjut panduan 2018, WHO mengembangkan *Labour Care Guide* (LCG) — alat pemantauan baru yang menggantikan partograf konvensional dengan pendekatan yang lebih berbasis bukti (WHO), 2020):

Perubahan Utama LCG dari Partograf Konvensional:

1) Garis waspada 1 cm/jam dan garis tindakan dihapus dan diganti dengan batas waktu berbasis bukti untuk setiap sentimeter dilatasi serviks, berdasarkan persentil ke-95 dari durasi persalinan dengan outcome perinatal normal.
2) Titik awal fase aktif persalinan adalah 5 cm (sebelumnya 4 cm atau kurang).
3) Ditambahkan seksi khusus untuk pemantauan kala dua persalinan.
4) Terdapat seksi penilaian dan promosi intervensi suportif untuk meningkatkan pengalaman persalinan (posisi ibu, dukungan persalinan, manajemen nyeri).

5) Kekuatan kontraksi uterus tidak lagi direkam (karena sulit dikuantifikasi dan distandarisasi secara klinis).
6) Setiap penyimpangan dari observasi yang diharapkan harus dilingkari dan respons klinis dicatat dalam bagian 'rencana'.

Bidan harus memastikan bahwa partograf yang diserahkan mencakup: (1) data awal masuk dan seluruh pemeriksaan, (2) grafik pembukaan serviks dan penurunan bagian terbawah janin, (3) data DJJ serial, (4) data tanda vital ibu serial, (5) data cairan amnion, moulase, dan penyusupan, serta (6) catatan intervensi yang dilakukan beserta waktunya. Partograf yang tidak lengkap sama buruknya dengan tidak ada partograf karena dapat menyebabkan kesalahan interpretasi di fasilitas penerima.

c. Dokumentasi Elektronik dan Sistem Informasi Rujukan

Perkembangan teknologi informasi kesehatan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas dokumentasi rujukan melalui sistem elektronik. Di Indonesia, sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang dikembangkan Kemenkes RI memungkinkan pengiriman data klinis secara real-time antara fasilitas perujuk dan penerima (Kemenkes RI, 2024). SISRUTE adalah sistem berbasis teknologi internet yang menghubungkan data pasien antar fasilitas kesehatan secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan mempercepat dan menyederhanakan proses rujukan (Zulharryansah Mesir Siregar & Rangkuti, 2024)

Manfaat utama SISRUTE adalah:

1) Mempercepat proses rujukan dengan informasi medis awal yang akurat.
2) Memudahkan fasyankes merujuk pasien sesuai dengan kompetensi RS tujuan.
3) Memastikan pelayanan cepat dan tepat bagi pasien, terutama kasus gawat darurat.

Meski demikian, dokumentasi elektronik tidak menggantikan dokumentasi fisik yang ditandatangani; keduanya bersifat komplementer. Bidan harus memastikan bahwa data yang dikirim secara elektronik identik dengan surat rujukan tertulis yang dibawa bersama pasien. Ketidaksesuaian antara data elektronik dan fisik dapat menimbulkan kebingungan klinis dan masalah medicolegal.

6. Transport Aman: Persiapan, Pemantauan, dan Pengelolaan Risiko

Transportasi pasien saat intrapartum adalah fase yang sangat berisiko dan sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Kondisi kesehatan ibu dapat berubah dengan sangat cepat selama perjalanan, termasuk kemajuan persalinan yang sangat cepat, kondisi gawat janin, atau munculnya komplikasi medis baru.

a. Persiapan Sebelum Transport

✓ Checklist Persiapan Transport Aman Intrapartum
PASIEN:
□ Stabilisasi kondisi ibu: IV line terpasang, cairan berjalan sesuai indikasi
□ Oksigen tersedia dan terpasang jika diperlukan (target SpO2 ≥ 95%)
□ Posisi optimal: left lateral decubitus untuk mengurangi kompresi aortocaval
□ Pemantauan DJJ terakhir terdokumentasi; alat Doppler dibawa
□ Obat-obatan darurat tersedia: MgSO4, oksitosin, nifedipine, epinefrin
□ Partus set lengkap tersedia (antisipasi persalinan di perjalanan)
DOKUMENTASI:
□ Surat rujukan lengkap dan ditandatangani
□ Partograf terisi hingga saat keberangkatan
□ Informed consent ditandatangani (atau didokumentasikan alasan ketidaklengkapan)
□ Fotokopi/salinan rekam medis relevan
KOMUNIKASI:
□ Fasilitas penerima telah dikonfirmasi siap menerima
□ Nomor kontak fasilitas penerima ada pada pendamping
□ Keluarga telah diinformasikan dan mengetahui tujuan serta rute
PENDAMPINGAN:
□ Minimal satu tenaga kesehatan terlatih mendampingi selama transport
□ Tenaga pendamping mengetahui prosedur darurat selama transport

b. Pemantauan Selama Transport

Pemantauan selama transportasi bertujuan untuk beberapa hal penting diantaranya (Kemenkes RI, 2025):

1) Melakukan deteksi dini perburukan kondisi ibu dan janin sebelum tiba di fasilitas rujukan. Ini sangat penting karena dapat membantu menyelamatkan nyawa mereka.
2) Pemantauan stabilisasi hemodinamik ibu yang telah dilakukan sebelum keberangkatan. Ini berarti bahwa kondisi ibu harus tetap stabil selama perjalanan ke fasilitas rujukan.
3) Pemantauan tata laksana emergensi, seperti cairan infus, oksigen, dan obat-obatan. Ini sangat penting dalam menghadapi situasi darurat.
4) Pendokumentasian terhadap perubahan kondisi klinis secara real-time sebagai informasi bagi di fasilitas penerima, yang diharapkan dapat membantu fasilitas penerima untuk memahami kondisi ibu dan janin secara akurat dan dapat memberikan perawatan yang tepat.

Parameter Pemantauan Kondisi Ibu Selama Transport

Pemantauan tanda vital ibu merupakan komponen utama yang tidak boleh diabaikan selama transport. Tanda vital yang tidak stabil mengindikasikan perlunya intervensi segera atau bahkan penghentian sementara transport untuk stabilisasi.

Tabel 4.3. Parameter Pemantauan Kondis Ibu Selama Rujukan (WHO, 2020)

Parameter	Frekuensi Pemantauan	Nilai Normal / Tindakan
Tekanan Darah	Setiap 15 menit	Sistol <160, Diastol <110 mmHg
Nadi	Setiap 15 menit	60–100 x/menit
Laju Pernapasan	Setiap 15 menit	12–20 x/menit
Saturasi Oksigen (SpO_2)	Kontinu / setiap 5 menit	≥ 95%
Suhu Tubuh	Satu kali saat keberangkatan	36,5–37,5°C
Tingkat Kesadaran (GCS/AVPU)	Setiap 15 menit	Alert / kompos mentis

Parameter	Frekuensi Pemantauan	Nilai Normal / Tindakan
Produksi Urine (bila kateter terpasang)	Setiap 30 menit	≥ 30 ml/jam

Pemantauan Denyut Jantung Janin (DJJ)

Pemantauan DJJ adalah bagian krusial selama proses rujukan intrapartum. Bila tidak tersedia CTG portabel, auskultasi intermiten menggunakan Doppler tetap dianjurkan. Pola deselerasi lambat, deselerasi variabel berat, atau bradikardia persisten merupakan tanda gawat janin yang memerlukan penanganan segera.

Tabel 4.4. Parameter Pemantauan Kondis Janin Selama Rujukan (Chandraharan et al., 2024)

Parameter	Frekuensi Pemantauan	Nilai Normal / Tindakan
DJJ (Doppler/fetoskop)	Setiap 15 menit (kala I) / setiap 5 menit (kala II)	110–160 dpm, tanpa deselerasi patologis
CTG Portabel (bila tersedia)	Kontinu	Kategori I / normal
Gerak janin (anamnesis)	Setiap 30 menit	Aktif bergerak

Pemantauan Kemajuan Persalinan

Meskipun pemeriksaan dalam (PD) tidak dianjurkan dilakukan di dalam kendaraan yang bergerak kecuali ada indikasi mendesak, tenaga kesehatan harus tetap memantau frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi uterus. Adanya tanda-tanda persalinan kala II aktif di perjalanan harus segera diantisipasi dengan persiapan persalinan darurat.

Tabel 4.5. Parameter Pemantauan Kemajuan Persalinan Selama Rujukan

Parameter	Frekuensi Pemantauan	Nilai Normal / Tindakan
Frekuensi kontraksi	Setiap 30 menit	Catat jumlah his per 10 menit
Durasi kontraksi	Setiap 30 menit	Catat dalam detik

Parameter	Frekuensi Pemantauan	Nilai Normal / Tindakan
Tanda kala II (dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol)	Kontinu (observasi)	Segera siapkan partus set darurat
Perdarahan pervaginam	Kontinu	Laporkan bila > 500 ml atau aktif mengalir

(Sormin, R. E. M. and Mangngi, 2025)

c. Pengelolaan Risiko Selama Transport

Setiap keputusan transport harus mempertimbangkan risiko secara cermat. Tenaga Kesehatan harus mempertimbangkan risiko dan manfaat transfer seperti kapan, apakah, dan bagaimana cara memindahkan pasien ke rumah sakit yang lebih tepat. Faktor-faktor yang dikumpulkan mencakup tanda vital, usia gestasi, dilatasi serviks, frekuensi kontraksi, dan status denyut jantung janin untuk membantu pengambilan keputusan (Lardaro et al., 2024).

Bagi pasien yang kondisinya sangat kritis, prinsip *stabilize before transfer* harus diterapkan, hal ini berarti tidak boleh memulai perjalanan sebelum kondisi pasien, terutama ibu, sudah cukup baik selama perjalanan, namun ada pengecualian jika menunda perjalanan itu sendiri dapat membahayakan nyawa pasien, seperti pada kasus solusio plasenta yang memerlukan operasi segera. Apabila persalinan tampak akan segera terjadi (*imminent*), harus dilakukan penilaian apakah melahirkan di lokasi saat ini lebih aman dibandingkan memindahkan ibu ke unit obstetri, dan keputusan ini harus didiskusikan bersama ibu dan bidan (Farine, 2017). Oleh karena itu, komunikasi *real-time* dengan tim yang akan menerima pasien selama perjalanan sangat penting. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat menyesuaikan rencana jika kondisi pasien berubah selama perjalanan (WHO, 2023a).

7. Pendampingan Keluarga: Hak, Peran, dan Dukungan Psikososial

"Pendampingan selama persalinan bukan sekadar tradisi — ia adalah hak ibu dan komponen klinis yang terbukti memperbaiki luaran maternal."

Hak ibu untuk didampingi selama proses persalinan telah diakui secara global, ini merupakan bagian penting dari perawatan intrapartum yang berfokus pada kebutuhan perempuan. Menurut WHO, setiap ibu yang akan melahirkan berhak memiliki pendamping pilihan mereka sendiri, baik suami, maupun keluarga sepanjang proses persalinan dan kelahiran. Hak ini berlandaskan prinsip

otonomi, martabat, dan hak asasi manusia dalam layanan kesehatan reproduksi (WHO, 2018).

Di Indonesia, hak pendampingan persalinan juga dijamin melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak pasien untuk memperoleh pendampingan keluarga selama proses perawatan, termasuk saat persalinan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan terkait standar pelayanan kebidanan menekankan keterlibatan keluarga sebagai bagian dari asuhan sayang ibu (*supportive care*) yang harus diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan, baik primer maupun rujukan (Kemenkes RI, 2023a).

Hak Ibu dalam Perawatan Intrapartum

Berhak memilih siapa yang mendampingi selama persalinan
Berhak mendapat informasi jelas tentang kondisi dan proses rujukan
Berhak atas privasi dan martabat selama perawatan intrapartum
Pendamping tidak dapat dilarang hadir kecuali ada indikasi klinis yang jelas

a. Peran Bidan dalam Mempersiapkan Keluarga

Mempersiapkan keluarga dalam proses rujukan intrapartum adalah tindakan penting bagi Bidan untuk memastikan keselamatan ibu dan janin serta meminimalkan hambatan non-medis. Peran Bidan dalam proses rujukan diantarnya:

1) Memberikan penjelasan tentang kondisi ibu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, termasuk seberapa gawat kondisinya tanpa membuat keluarga panik.
2) Menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari proses rujukan ini dan apa saja yang akan terjadi ketika tiba di fasilitas penerima.
3) Mengidentifikasi satu anggota keluarga sebagai orang yang akan dihubungi dan memberikan informasi tentang cara menghubungi fasilitas penerima.
4) Menjelaskan peran keluarga selama proses transportasi: menjaga ibu tetap tenang, tidak mengganggu pemantauan kondisi ibu, dan segera memberitahu pendamping jika ada perubahan kondisi ibu yang mereka lihat.
5) Memastikan keluarga membawa dokumen-dokumen penting seperti kartu identitas, kartu BPJS atau asuransi, dan buku KIA. Menyiapkan keluarga untuk kemungkinan prosedur darurat di fasilitas penerima.

(WHO, 2017) (Kemenkes RI, 2023b)(Kemenkes RI, 2020).

8. Serah Terima Klinis di Fasilitas Penerima

Serah terima atau *handover* adalah momen penting dalam proses rujukan di mana tanggung jawab perawatan pasien berpindah dari tim yang merujuk ke tim yang menerima. Menurut penelitian oleh (De Meester et al., 2020), banyak

kesalahan terjadi karena komunikasi yang buruk saat proses *handover*, ini sering menjadi penyebab utama *adverse events* dalam perawatan pasien, untuk itu, serah terima yang baik harus dilakukan dengan cara yang sistematis, lengkap, dan memberi kesempatan pada tim penerima untuk bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut.

a. Komponen Serah Terima yang Efektif

Komponen	**Konten**
Identifikasi pasien	Konfirmasi verbal dan visual identitas ibu (nama, tanggal lahir, nomor rekam medis)
Rangkuman klinis	Diagnosis, riwayat singkat, tindakan yang dilakukan, respons klinis, dan kondisi saat tiba
Status terkini	Tanda vital terakhir, DJJ, kemajuan persalinan, dan intervensi yang sedang berjalan
Tindakan mendesak	Hal yang perlu dilakukan segera oleh tim penerima berdasarkan kondisi klinis
Dokumentasi	Serah terima fisik seluruh dokumen: surat rujukan, partograf, informed consent, rekam medis
Konfirmasi pemahaman	Tim penerima merangkum ulang informasi kunci (read-back) untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman

9. Evaluasi Mutu Sistem Rujukan: Indikator dan Umpan Balik

Sistem rujukan yang bermutu memerlukan mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk mengidentifikasi hambatan, keberhasilan, dan area perbaikan. Beberapa indikator kunci mutu sistem rujukan maternal: (1) persentase kasus rujukan dengan dokumentasi lengkap, (2) waktu respons dari keputusan rujukan hingga keberangkatan, (3) angka kematian ibu dalam perjalanan, (4) kesesuaian diagnosis antara perujuk dan penerima, dan (5) kepuasan ibu dan keluarga terhadap proses rujukan (Kemenkes RI, 2024).

Mekanisme umpan balik (*feedback loop*) antara fasilitas penerima dan perujuk merupakan elemen penting yang sering diabaikan. Tanpa umpan balik, bidan perujuk tidak memiliki data untuk mengevaluasi ketepatan keputusan klinis mereka dan meningkatkan praktik di masa mendatang.

B. Asesmen (Piramida Miller)

Aktivitas 1: Know How : Analisis mini-case

MINI-KASUS DISKUSI KELOMPOK

Ny. Riska, 28 tahun, G2P1A0, UK 38 minggu, datang ke Puskesmas pukul 14.30 WIB dengan keluhan kenceng-kenceng sejak 6 jam lalu. Pemeriksaan: TD 160/110 mmHg, Nadi 96x/menit, RR 20x/menit, Suhu 37,1°C. DJJ 144 bpm teratur. VT: pembukaan 5 cm, ketuban utuh, kepala di station -1. Ibu mengeluh nyeri kepala hebat dan pandangan kabur sejak 2 jam terakhir. Urin dipstick proteinuria +++. Puskesmas tidak memiliki MgSO4 dan fasilitas SC. RS PONEK terdekat berjarak 45 menit.

Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok Anda:

1. Klasifikasikan kondisi Ny. Riska ke dalam kategori urgensi rujukan (MERAH/KUNING/HIJAU) dan jelaskan alasan klinisnya.
2. Susun komunikasi ISBAR lengkap yang akan Anda sampaikan kepada dokter SpOG di RS penerima. Tuliskan dalam format dialog.
3. Informasi apa saja yang harus ada dalam surat rujukan Ny. Riska? Buat draft surat rujukan.
4. Bagaimana Anda menyampaikan situasi ini kepada suami Ny. Riska yang tampak sangat cemas dan terus bertanya apakah istrinya akan baik-baik saja? Roleplay singkat.
5. Tindakan stabilisasi apa yang dapat Anda lakukan sebelum dan selama transport mengingat keterbatasan fasilitas?

Aktivitas 2: Show How: OSCE

C. Latihan Soal

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan : Rujukan Intrapartum
3	Kasus	Rujukan pada kasus kegawatdaruratan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam: pengegakan diagnose, pengambilan Keputusan klinis dan komunikasi pada proses rujukan
5	Kompetensi	1. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 2. Pendidikan Kesehatan

No.	Komponen	Isi
		3. Kolaborasi/rujukan 4. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Ny. Sari, 28 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke Puskesmas Rawat Inap pukul 09.00 WIB dengan keluhan kenceng-kenceng teratur sejak 4 jam yang lalu. Ketuban belum pecah. Riwayat persalinan pertama normal, bayi lahir 3.800 gram. Pemeriksaan dalam pertama (09.15 WIB): pembukaan 6 cm, presentasi kepala, penurunan Hodge II, selaput ketuban utuh. Bidan memulai observasi dan mengisi partograf. Empat jam kemudian (13.15 WIB), dilakukan pemeriksaan ulang. Pembukaan tetap 6 cm (tidak ada kemajuan), kepala masih di Hodge II. His berkurang menjadi 2× dalam 10 menit, durasi <20 detik. Ibu tampak cemas dan kelelahan. TUGAS 1. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh 2. Lakukan komunikasi terapeutik kepada pasien dan keluarga mengenai keputusan rujukan. 3. Lakukan komunikasi (ISBAR) pada proses kolaborasi/rujukan
7	Instruksi penguji	**Instruksi Umum** : 1. Tuliskan identitas peserta pada lembar atau form penilaian 2. Amati peserta menggunakan rubrik penilaian dan tentukan nilai *actual mark* (skor 0/1/2/3) *3. Berikan penilaian global performance/global rating* 4. Tidak boleh melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan dalam instruksi khusus 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE 6. Pastikan keadaaan *station* seperti semula sebelum peserta ujian berikutnya memasuki *station* INSTRUKSI KHUSUS

No.	Komponen	Isi
		1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 3. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 8. PS berperan sebagai ibu inpartu kala II. 9. PS tampak cemas, lelah, sesekali meringis saat kontraksi, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. 10. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 11. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang Bu. Perkenalkan, saya Bidan Rina, bidan jaga di sini PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: ini kenceng-kencengnya sudah sejak tadi malam, Bu... sudah tidak tahan rasanya juga. Peserta ini kehamilan Ibu yang ke berapa? PS: Ini yang kedua, Bu. Yang pertama lahir normal dua tahun lalu, bayinya besar, 3,8 kilo. Peserta: Ada keluar cairan banyak dari jalan lahir? PS: belum, yang ada lendir bercampur darah sedikit.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: zin Ibu, saya perlu melakukan pemeriksaan dalam untuk melihat sudah seberapa buka. Apakah Ibu bersedia? PS: iya bu, silahkan Sudah, sekitar 2 jam yang lalu. Peserta: Apakah ibu sudah merasa ingin mengejan? Peserta: Ibu, persalinannya belum maju dan bayi perlu segera ditolong di rumah sakit. PS: Baik, Bu, tolong bantu saya dan bayi saya ya. Peserta: Saya akan melakukan tindakan awal dan menyiapkan rujukan. PS: Iya, Bu. Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	1. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold 2. Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam 3. Lembar partograf kasus
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin 2. Mengganti lembar partograf/lembar instruksi bila diperlukan 3. Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Lembar partograf kasus — 1 set 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1 7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol

No.	Komponen	Isi
		12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Infus set dummy — 1 set 15. Cairan RL/NaCl dummy — 1 16. Abocath dummy — 1 17. Formulir rujukan — 1 lembar 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1
13	Penulis	Yuni Sari, SST, M. Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

Stase 1: Persalinan Gawatdarurat

KOMPETENSI 1. Perumusan diagnosis dan/atau masalah

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Merumuskan diagnosis kebidanan utama secara lengkap (format: kondisi + etiologi + tanda)		
2. Mengidentifikasi masalah aktual: kelelahan ibu sebagai masalah yang perlu dicantumkan dalam diagnosis kebidanan		
3. Mengidentifikasi masalah potensial: risiko gawat janin bila persalinan tidak segera ditangani		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **3 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 3 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1 dari 3 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Pendidikan Kesehatan/KIE

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan segera		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **5–6 langkah dari 6 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–4 langkah ari 6 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **2-3 langkah dari 6 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. Kolaborasi/Rujukan

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Memperkenalkan diri: nama, profesi, asal fasilitas, nomor kontak bila diperlukan		
2. Mengidentifikasi pasien secara akurat: nama lengkap, usia, nomor rekam medis / NIK, paritas		
3. Menyampaikan kondisi/masalah utama saat ini secara spesifik dan berbasis waktu		
4. Menyampaikan alasan kontak/rujukan secara langsung dan jelas di awal komunikasi		
5. Menyampaikan tingkat urgensi secara tepat (emergensi / segera / elektif)		
6. Melaporkan data tanda vital ibu secara lengkap dan akurat (TD, nadi, suhu, RR)		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
7. Melaporkan data persalinan: DJJ, his (frekuensi+durasi), hasil VT terakhir, kondisi ketuban		
8. Melaporkan riwayat obstetri yang relevan (G2P1A0, riwayat persalinan sebelumnya, BB anak pertama)		
9. Menyampaikan diagnosis/penilaian klinis secara tepat dan terstruktur		
10. Menggambarkan kecenderungan/tren kondisi pasien (stabil / memburuk / membaik) secara eksplisit		
11. Menyampaikan permintaan/rekomendasi secara eksplisit dan tidak ambigu kepada penerima laporan		
12. Melakukan konfirmasi penerimaan (read-back / teach-back): memastikan RS tujuan telah menerima dan memahami informasi		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **12 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **7–9 dari 12 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **4–6 dari 12 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Kejelasan bahasa: bicara dengan kecepatan, diksi, dan volume yang dapat dipahami pasien/keluarga dan tenaga kesehatan		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

Total Skor Dan Kelulusan

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3 *(dicatat di rubrik penilaian)*

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Aktivitas 3: Direct Observation of Procedural Skill (DOPS)

Tabel 4.6 Contoh soal DOPS pada Kasus Kegawatdaruratan Intrapartum

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
1	**Metode Penilaian**	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta secara nyata di lahan praktik, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. **Domain yang dinilai mencakup:** • Informed consent dan komunikasi terapeutik • Persiapan pra-tindakan dan kelengkapan alat/obat • Kemampuan teknis prosedural (stabilisasi, SBAR, dokumentasi) • Keselamatan pasien dan profesionalisme • Kemampuan pengambilan keputusan rujukan yang tepat waktu	Pembimbing/CI mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa menangani ibu inpartu yang memerlukan rujukan segera — mulai dari: • Pengenalan tanda kegawatan intrapartum (eklampsia, gawat janin, prolaps tali pusat, PPP) • Pengambilan keputusan dan komunikasi SBAR/ISBAR ke fasilitas penerima • Pelaksanaan stabilisasi pra-rujukan sesuai prioritas klinis • Persiapan dokumen dan pendampingan keluarga *Umpan balik diberikan dalam 24 jam setelah observasi oleh CI yang sama.*

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
2	**Tujuan Penilaian**	Tujuan DOPS pada topik rujukan kegawatdaruratan intrapartum adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan pra-rujukan yang aman, cepat, dan sistematis; menyusun komunikasi rujukan yang terstruktur; serta mendampingi proses transfer dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang kegawatan intrapartum, tetapi dari kemampuan nyata: • **Mengenali tanda kegawatan:** DJJ abnormal, perdarahan aktif, kejang — dalam < 3 menit • **Menstabilisasi pasien:** O2, IV line, obat emergensi — sesuai urutan prioritas yang benar • **Berkomunikasi:** ISBAR lengkap ke RS tujuan sebelum pasien berangkat • **Mendampingi keluarga:** penjelasan terapeutik, informed consent, peran keluarga selama transfer • **Mendokumentasikan:** partograf, surat rujukan, lembar observasi — akurat dan lengkap
3	**Kasus Klinik**	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik	**Skenario Kasus — Eklampsia Intrapartum:**

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan kondisi kegawatan intrapartum, pengambilan keputusan rujukan, komunikasi terstruktur (ISBAR), dan pelaksanaan transport aman.	Ny. R, 29 tahun, G2P1A0 hamil 36 minggu, datang ke Puskesmas PONED pukul 02.15 WIB dalam kondisi kejang. Riwayat TD 140/90 mmHg pada ANC ke-3, tidak kontrol SPOG. TD 180/120 mmHg, Nadi 112x/mnt, DJJ 170x/mnt irreguler. Pembukaan 5 cm, ketuban utuh.
4	**Aktivitas Mahasiswa yang Diamati**	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan rangkaian tindakan klinik nyata, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Keterampilan yang relevan pada rujukan kegawatdaruratan intrapartum: • Penilaian cepat (primary survey): jalan napas, pernapasan, sirkulasi, kesadaran, paparan • Penilaian tanda vital ibu dan DJJ janin secara akurat dan cepat	**Pada kasus eklampsia intrapartum, mahasiswa diamati saat:** • Membebaskan jalan napas, posisikan miring kiri, pasang OPA dalam < 2 menit • Memasang O2 masker non-rebreathing 10 L/mnt, mengukur SpO2 • Memasang IV line 2 jalur (Abocath 18G bilateral) dan infus RL • Melarutkan dan memberikan MgSO4 4g IV pelan (15–20 menit) — loading dose • Memantau refleks patella dan RR sebelum

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		• Identifikasi tanda kegawatan dan penetapan diagnosis kerja • Tindakan stabilisasi pra-rujukan sesuai kasus: O2, IV line, obat, posisi, monitoring • Penyusunan komunikasi ISBAR via telepon ke fasilitas penerima • Pengisian dokumen rujukan: surat rujukan, partograf, informed consent, lembar observasi • Komunikasi terapeutik kepada ibu dan keluarga • Pemantauan selama transport: TV, DJJ, respons obat • Serah terima klinis di fasilitas penerima menggunakan ISBAR + read-back	dan selama pemberian MgSO4 • Memberikan antihipertensi: Nifedipin 10 mg sublingual • Menyampaikan ISBAR terstruktur via telepon ke RSUD PONEK • Mengisi surat rujukan dan partograf sebelum pasien diberangkatkan • Menjelaskan kondisi pasien kepada suami dengan bahasa yang dapat dipahami
5	**Aspek yang Dinilai**	Aspek yang dinilai dalam DOPS rujukan intrapartum meliputi delapan domain utama:	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu: • Menghubungkan TD 180/120 mmHg +

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		• **Pemahaman indikasi tindakan:** mampu mengidentifikasi kapan, mengapa, dan ke mana harus merujuk • **Informed consent:** persetujuan diperoleh secara etis, jelas, dan terdokumentasi • **Persiapan pra-prosedur:** alat, obat, dan dokumen tersedia lengkap sebelum tindakan • **Kemampuan teknis:** urutan tindakan benar, dosis obat tepat, teknik prosedur aman • **Komunikasi:** ISBAR terstruktur, terapeutik kepada keluarga, read-back saat serah terima • **Kemampuan mencari bantuan:** mengenali kapan	kejang + DJJ 170x/mnt irreguler → eklampsia intrapartum + gawat janin dalam < 3 menit • Mengurut tindakan dengan benar: airway → O2 → IV line → MgSO4 → antihipertensi → kateter → ISBAR → dokumentasi • Memberikan dosis MgSO4 loading (4g dalam 15–20 menit) tanpa kesalahan pengenceran • Memantau tanda toksisitas MgSO4: refleks patella, RR > 12x/mnt, urin output > 25 mL/jam • Menyampaikan ISBAR lengkap (5 komponen) dalam < 3 menit via telepon • Mengisi surat rujukan dengan data klinis yang akurat dan kronologis • Menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dengan

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		perlu eskalasi dan berani memintanya • **Rencana pascatindakan:** monitoring selama transfer, persiapan partus di perjalanan • **Profesionalisme:** tenang di bawah tekanan, empati, dokumentasi jujur dan lengkap	empati tanpa menyembunyikan kegawatan
6	**Fokus Observasi Pembimbing**	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan klinik — bukan yang dikatakan mahasiswa tentang apa yang seharusnya dilakukan, melainkan apa yang benar-benar dilakukannya. Pada rujukan kegawatdaruratan intrapartum, pembimbing memfokuskan observasi pada: • Kecepatan pengenalan tanda	**Pembimbing memperhatikan:** • Menghubungkan TD 180/120 mmHg + kejang + DJJ 170x/mnt irreguler → eklampsia intrapartum + gawat janin dalam < 3 menit • Mengurut tindakan dengan benar: airway → O2 → IV line → MgSO4 → antihipertensi → kateter → ISBAR → dokumentasi • Memberikan dosis MgSO4 loading (4g dalam 15–20 menit) tanpa kesalahan pengenceran

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		kegawatan (waktu dari masuk pasien hingga diagnosis kerja) • Ketepatan urutan prioritas tindakan — jangan sampai IV line dipasang sebelum jalan napas aman • Kualitas dan kelengkapan komunikasi ISBAR — apakah RS tujuan mendapat semua informasi kritis • Waktu dari keputusan rujukan hingga pasien berangkat — target < 30 menit untuk kasus MERAH • Kelengkapan dan akurasi dokumentasi yang dibawa saat rujukan	• Memantau tanda toksisitas MgSO4: refleks patella, RR > 12x/mnt, urin output > 25 mL/jam • Menyampaikan ISBAR lengkap (5 komponen) dalam < 3 menit via telepon • Mengisi surat rujukan dengan data klinis yang akurat dan kronologis • Menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dengan empati tanpa menyembunyikan kegawatan • Apakah mahasiswa tetap tenang dan memberikan instruksi yang jelas kepada tim dan keluarga
7	**Umpan Balik**	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi (dalam 24 jam) dan berisi: • **Kekuatan:** apa yang sudah dilakukan	**Contoh umpan balik CI pada kasus eklampsia intrapartum:** *"Kekuatan: Mahasiswa berhasil mengenali eklampsia dalam 2 menit*

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		dengan baik dan harus dipertahankan • **Area perbaikan:** tindakan atau sikap yang spesifik perlu ditingkatkan • **Rencana perbaikan:** langkah konkret yang disepakati antara mahasiswa dan CI	*pertama, membebaskan jalan napas dengan benar, dan menyusun ISBAR yang lengkap sebelum berangkat. Komunikasi kepada suami sudah empatik dan jelas."* **Area perbaikan yang dikemukakan CI:** • Waktu penyiapan MgSO4: pengenceran memakan 9 menit — target adalah < 5 menit. Latihan pengenceran berkala diperlukan • Pemantauan refleks patella tidak dilakukan sebelum dosis pertama selesai — harus menjadi langkah rutin • DJJ hanya dipantau 2 kali selama 40 menit pra-rujukan — standar minimal adalah setiap 10–15 menit *Rencana perbaikan: mahasiswa akan berlatih simulasi pengenceran MgSO4 hingga dapat diselesaikan dalam < 5*

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			menit sebelum DOPS berikutnya.
8	**Keputusan Penilaian**	Hasil DOPS diringkas menjadi tiga keputusan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan rujukan: • **KOMPETEN:** mahasiswa mampu melakukan seluruh rangkaian tindakan pra-rujukan secara mandiri, runtut, aman, dan tepat — termasuk ISBAR dan dokumentasi • **PERLU SUPERVISI:** langkah utama sudah benar tetapi memerlukan arahan pada beberapa aspek teknis atau keputusan waktu rujukan • **REMEDIAL:** gagal mengenali kegawatan, salah urutan prioritas, tidak menyiapkan	**Kriteria keputusan untuk kasus rujukan intrapartum:** **KOMPETEN — mahasiswa dinyatakan kompeten apabila:** – Mengenali tanda kegawatan dalam < 3 menit dan menetapkan diagnosis kerja dengan benar – Melakukan tindakan stabilisasi sesuai urutan prioritas tanpa langkah yang terlewat – Menyampaikan ISBAR lengkap dan terstruktur sebelum pasien diberangkatkan – Mengisi dokumen rujukan secara akurat dan memantau pasien selama transfer **PERLU SUPERVISI — apabila:** – Langkah utama benar tetapi waktu pengambilan

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		ISBAR, atau melakukan tindakan yang membahayakan pasien	keputusan rujukan > 30 menit untuk kasus MERAH – ISBAR disusun tetapi ada komponen yang tidak lengkap atau kurang akurat – Dosis obat benar tetapi teknik pemberian memerlukan koreksi CI **REMEDIAL — apabila:** – Tidak mengenali tanda eklampsia, gawat janin, atau prolaps sebagai kegawatan yang memerlukan rujukan – Salah urutan prioritas: misalnya mengisi surat rujukan sebelum membebaskan jalan napas – Tidak melakukan ISBAR atau mengirim pasien tanpa konfirmasi kesiapan RS tujuan – Melakukan tindakan berbahaya: memberikan MgSO4

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			tanpa memantau refleks patella
9	**Makna dalam OBE**	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does — performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik nyata di lahan praktik. Dalam kerangka Miller's Pyramid, DOPS menempatkan penilaian pada puncak piramida: bukan knows, bukan knows how, bukan shows how — tetapi does. *Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS instrumen paling valid untuk menilai kompetensi klinik berbasis situasi gawat yang tidak dapat disimulasikan sepenuhnya di laboratorium.*	Pada kasus rujukan kegawatdaruratan intrapartum, DOPS dalam kerangka OBE membuktikan bahwa mahasiswa: • **Bukan hanya memahami teori Three Delay,** tetapi secara nyata mampu memutus rantai keterlambatan — mengenali kegawatan dalam < 3 menit, memutuskan rujukan dalam < 15 menit, dan memastikan RS tujuan siap sebelum berangkat • **Bukan hanya hafal langkah MgSO4,** tetapi mampu melarutkan dan memberikannya dengan benar dalam kondisi panik, dini hari, dengan refleks patella tetap dipantau • **Bukan hanya tahu konsep ISBAR,** tetapi

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			mampu menyampaikannya secara terstruktur via telepon dalam < 3 menit dengan seluruh komponen I-S-B-A-R terpenuhi • **Bukan hanya paham informed consent,** tetapi mampu memperoleh persetujuan secara etis dalam situasi gawat dengan keluarga yang cemas

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5.7 Portofolio Tindakan Pra-Rujukan Dan Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
1	**Hakikat Portofolio**	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan Perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik rujukan kegawatdaruratan intrapartum, portofolio Memuat bukti bahwa mahasiswa mampu: • Mengenali tanda kegawatan intrapartum secara cepat (eklampsia, PPP, prolaps tali pusat) • Melakukan stabilisasi pra-rujukan sesuai protokol tanpa menunda transfer • Mendokumentasikan tindakan secara kronologis dan berbasis fakta • Merefleksikan proses penanganan dan memperbaiki performa dari waktu ke waktu
2	**Tujuan Portofolio**	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik, sehingga kompetensi tidak hanya	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah mendampingi proses rujukan kasus gawat intrapartum, tetapi juga membuktikan: • Bagaimana kemampuannya

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		dinilai dari satu momen ujian tetapi dari konsistensi performa di berbagai situasi klinis nyata.	mengenali tanda syok hipovolemik pasca partus berkembang setelah mendapat umpan balik dari CI • Bahwa ia mampu menyusun komunikasi SBAR dengan lebih terstruktur pada kasus rujukan kedua dibanding pertama • Adanya peningkatan kecepatan pemberian MgSO4 loading dose pada kasus eklampsia yang ia tangani
3	**OSCE dan DOPS**	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium (OSCE) dan bukti performa nyata di lahan praktik (DOPS). Keduanya saling melengkapi sebagai bukti kompetensi yang terverifikasi.	**OSCE memuat:** • Hasil ujian keterampilan pengenalan tanda kegawatan intrapartum (DJJ abnormal, perdarahan aktif, kejang) • Simulasi pemberian MgSO4 loading dose pada manikin kasus eklampsia • Keterampilan penyusunan komunikasi SBAR secara tertulis dan lisan

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			pada skenario terstandar **DOPS memuat:** • Observasi langsung saat mahasiswa melakukan stabilisasi pra-rujukan pada kasus PPP atonia uteri di ruang bersalin • Penilaian kemampuan KBI/KBE oleh CI dengan formulir DOPS terstandar • Dokumentasi performa mahasiswa mempertahankan posisi elevasi kepala janin pada simulasi prolaps tali pusat
4	**Catatan Kasus Singkat**	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, meliputi data penting, masalah kebidanan yang teridentifikasi, tindakan utama yang dilakukan, dan hasil yang dicapai. Catatan ini bersifat objektif dan kronologis.	**Contoh catatan kasus:** Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Ny. R, 29 tahun, G2P1A0 hamil 36 minggu, datang dengan kejang pukul 02.15 WIB, TD 180/120 mmHg, DJJ 170x/mnt irreguler. • Masalah kebidanan: Eklampsia intrapartum + gawat janin • Tindakan awal: O2 masker, MgSO4 4g IV

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			loading, Nifedipin 10 mg sublingual, pasang kateter, infus RL • Keputusan rujukan: Pukul 02.50 WIB ke RSUD Meuraxa disertai komunikasi SBAR • Hasil: Ibu dan bayi selamat, SC emergensi, Apgar 7/9, ibu dirawat ICU 1 hari
5	**Refleksi Patient Safety**	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan dalam penanganan, dan menyusun langkah pencegahan konkret dalam asuhan kebidanan — khususnya dalam situasi gawat yang memerlukan respons segera.	**Mahasiswa merefleksikan:** • Pentingnya tidak menunda keputusan rujukan meskipun kondisi pasien tampak 'masih bisa ditangani' — keterlambatan merujuk kasus PPP >500 mL tanpa respons uterotonika berisiko fatal • Risiko amniotomi pada multigravida dengan kepala janin belum engaged — pelajaran dari kasus prolaps tali pusat yang hampir terjadi • Bahaya pemberian MgSO4 tanpa

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			memantau refleks patella dan RR — potensi depresi napas sebagai tanda toksisitas • Perlunya double-check komunikasi SBAR: apakah RS tujuan benar-benar sudah menyiapkan UTD dan OK sebelum pasien diberangkatkan
6	**Feedback CI / Dosen**	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan. Feedback harus spesifik, tertulis, dan dapat diverifikasi.	**Contoh umpan balik CI:** *"Mahasiswa sudah baik dalam mengenali tanda eklampsia dan segera memberikan MgSO4 loading dose. Komunikasi SBAR ke RS tujuan juga sudah terstruktur.* **Hal yang perlu ditingkatkan:** • Kecepatan penyiapan MgSO4: pengenceran masih memakan waktu 7 menit, target adalah < 5 menit • Pemantauan DJJ selama transfer masih dilakukan setiap 30 menit — perlu

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			ditingkatkan menjadi setiap 10–15 menit
7	**Karakteristik Penilaian Portofolio**	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa pada berbagai konteks klinis, bukan hanya kemampuan di satu kasus terbaik.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus rujukan gawat intrapartum, melainkan dari konsistensi performa pada beberapa kasus, misalnya: • **Kasus 1 (Eklampsia):** mampu memberikan MgSO4 sesuai protokol, SBAR lengkap • **Kasus 2 (PPP Atonia):** mampu melakukan KBI/KBE, uterotonika bertahap, dan komunikasi rujukan tepat waktu • **Kasus 3 (Prolaps Tali Pusat):** mampu mengambil posisi knee-chest dan elevasi kepala janin secara refleks
8	**Bukti Konsistensi Kompetensi**	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik CI, terlihat

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda. Ini mencakup kemampuan beradaptasi terhadap kasus yang berbeda-beda dengan tetap mempertahankan standar tindakan yang benar.	bahwa mahasiswa secara konsisten: • Mengenali tanda bahaya intrapartum dalam waktu < 3 menit pada setiap simulasi maupun kasus nyata • Selalu melakukan komunikasi SBAR sebelum pasien diberangkatkan. • Memantau DJJ dan tanda vital ibu selama proses rujukan pada setiap kasus yang didampingi • Mendokumentasikan tindakan secara kronologis pada seluruh rekam medis / lembar observasi yang ditandatanganinya • Menuliskan refleksi pada setiap kasus.
9	**Makna dalam OBE**	Dalam OBE (Outcome-Based Education), portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam	Pada topik rujukan kegawatdaruratan intrapartum, portofolio dalam kerangka OBE menunjukkan bahwa mahasiswa: • Tidak hanya paham teori Three delay

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi di lingkungan klinis nyata.	(terlambat mengenali, memutuskan, tiba) — tetapi konsisten mampu memutus rantai keterlambatan tersebut dalam praktik nyata • Mampu mengintegrasikan kompetensi kognitif (pengetahuan kegawatan), psikomotor (KBI, MgSO4, SBAR), dan afektif (empati terhadap keluarga, keberanian mengambil keputusan) dalam satu episode klinis • Menunjukkan perkembangan terukur dari kasus pertama hingga kasus terakhir: waktu respons lebih cepat, komunikasi lebih terstruktur, dokumentasi lebih lengkap

Tabel 5.7 Case Report pada Kegawatdaruratan Intrapartum

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
1	**Hakikat Case Report**	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis. *Pada kasus kegawatdaruratan intrapartum, case report bersifat kritis dan berorientasi tindakan — mencerminkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan pengenalan tanda bahaya, pengambilan keputusan pra-rujukan, dan proses komunikasi rujukan yang terstruktur.*	Mahasiswa menyusun laporan kasus singkat tentang Ny. R, 29 tahun, G2P1A0 hamil 36 minggu, datang pukul 02.15 WIB dalam kondisi kejang, dengan tekanan darah 180/120 mmHg dan DJJ 170x/menit irreguler. **Laporan mencakup:** • Pengenalan tanda eklampsia intrapartum secara cepat dan tepat • Analisis ilmiah hubungan hipertensi berat — kejang — gawat janin • Dokumentasi kronologis tindakan pra-rujukan yang dilakukan • Keputusan dan proses komunikasi rujukan ke RSUD PONEK
2	**Tujuan Case Report**	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga membuktikan kemampuan:

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan menjadi satu narasi klinis yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	• **Mengintegrasikan data:** TD 180/120 mmHg + proteinuria + kejang → diagnosis eklampsia intrapartum • **Merencanakan tindakan:** urutan prioritas O2 → MgSO4 loading → antihipertensi → kateter → SBAR • **Mengevaluasi hasil:** penurunan TD dari 180/120 → 146/94 mmHg selama 95 menit pra-rujukan • **Merefleksikan outcome:** bayi lahir hidup SC emergensi, Apgar 7/9, ibu bebas kejang pasca MgSO4
3	**Isi Laporan Case Report**	Isi case report mencakup: identitas singkat pasien (disamarkan), keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan dan implementasi, evaluasi hasil, serta pembelajaran klinis yang diperoleh dari kasus.	**Pada kasus PPP atonia uteri, mahasiswa menuliskan:** • **Data subjektif:** ibu merasa lemas, pusing, dan mual setelah melahirkan • **Data objektif:** perdarahan ±900 mL, uterus lembek, TD 88/60 mmHg, Nadi 120x/mnt • **Analisis masalah:** Atonia Uteri → PPP →

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			Syok Hipovolemik Kompensata • **Tindakan:** masase → oksitosin drip → KBI 5 menit → KBE → misoprostol 800 mcg rektal → tampon kondom kateter → resusitasi RL 1.500 mL • **Evaluasi:** perdarahan mereda pasca tampon, TD naik ke 96/66 mmHg saat berangkat • **Pembelajaran:** grandemultipara + anemia = risiko PPP yang WAJIB dirujuk antepartum
4	**Fokus Penilaian Case Report**	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik (clinical reasoning), ketepatan urutan tindakan awal, dan kemampuan mahasiswa mengevaluasi hasil asuhan secara objektif dan jujur.	Pada kasus atonia uteri Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan: • masase uterus → memberikan oksitosin drip → melakukan KBI 5 menit → KBE → misoprostol 800 mcg rektal → memasang tampon kondom kateter → melakukan resusitasi RL 1.500 mL • Melakukan evaluasi perdarahan pasca

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			tampon, TD naik ke 96/66 mmHg saat berangkat • Membuktikan ketepatan keputusan rujukan
5	**Nilai Edukatif Case Report**	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi klinis yang sistematis, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah — sehingga setiap kasus menjadi sumber pembelajaran yang berkelanjutan.	Dari kasus eklampsia intrapartum, mahasiswa belajar bahwa: • Hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol adalah prediktor eklampsia yang dapat dicegah sejak ANC • Pemberian MgSO4 loading dalam < 5 menit adalah penentu keberhasilan stabilisasi — setiap menit penundaan meningkatkan risiko kejang berulang • Komunikasi SBAR yang dilakukan sebelum berangkat — bukan saat di perjalanan — menentukan kesiapan tim PONEK di RS tujuan • Monitoring DJJ tiap 10–15 menit selama transfer adalah standar yang tidak boleh dikompromikan, bahkan

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			dalam kondisi perjalanan yang sulit
6	**Makna dalam OBE**	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab. Case report yang baik menunjukkan penguasaan domain kognitif (analisis), psikomotor (tindakan), dan afektif (refleksi dan tanggung jawab klinis).	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep kegawatdaruratan intrapartum, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh: • **Domain kognitif:** analisis patofisiologi eklampsia → kejang → gawat janin tercermin dalam narasi yang logis • **Domain psikomotor:** daftar tindakan MgSO4, KBI/KBE, dan komunikasi SBAR yang rinci dan terurut • **Domain afektif:** refleksi jujur tentang keterlambatan 7 menit dalam menyiapkan MgSO4 dan komitmen perbaikan

Tabel 5.8 Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Intrapartum

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
1	**Hakikat Refleksi Patient Safety**	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah yang dapat terjadi, dan merencanakan tindakan pencegahan konkret dalam asuhan kebidanan — khususnya dalam situasi gawat yang memerlukan respons segera. *Dalam kegawatdaruratan intrapartum, refleksi ini menjadi sangat kritis karena keselamatan ibu dan janin ditentukan dalam hitungan menit.*	Pada kasus PPP atonia uteri, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali atonia uteri — uterus yang tidak berkontraksi dalam 15 menit pasca partus tanpa tindakan masase yang benar — dapat menyebabkan perdarahan masif hingga kematian ibu dalam 2 jam. Mahasiswa juga merefleksikan bahwa faktor risiko PPP (grandemultipara, anemia Hb 9,8 g/dL) yang teridentifikasi saat ANC ke-2 TIDAK ditindaklanjuti dengan rujukan antepartum — sebuah kegagalan sistem yang berkontribusi langsung pada kegawatan yang terjadi.
2	**Tujuan Refleksi Patient Safety**	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian inti dari setiap tindakan kebidanan —	Mahasiswa memahami bahwa dalam kasus rujukan kegawatdaruratan intrapartum, kesalahan atau kelalaian sekecil apapun dapat berdampak fatal, antara lain:

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		bukan hanya tanggung jawab institusi, tetapi tanggung jawab pribadi setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan kasus.	• Tidak memantau refleks patella sebelum dosis berikutnya MgSO4 → risiko toksisitas hingga henti napas • Melepas tangan dari posisi elevasi kepala janin saat transfer pada kasus prolaps tali pusat → DJJ turun drastis, hipoksia janin permanen • Menunda keputusan rujukan >30 menit pada PPP karena menunggu 'respons lebih baik' → syok irreversibel • Tidak mengonfirmasi kesiapan RS tujuan sebelum berangkat → pasien tiba tanpa persiapan tim PONEK
3	**Fokus Refleksi**	Fokus refleksi meliputi empat elemen utama: (1) identifikasi risiko yang ada dalam kasus, (2) analisis penyebab mengapa risiko tersebut muncul, (3) tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan, dan (4) pembelajaran	**Pada kasus eklampsia intrapartum, fokus refleksi mahasiswa:** • **Identifikasi risiko:** pasien riwayat TD 140/90 di ANC ke-3 namun tidak kontrol SPOG — celah pengawasan yang fatal

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		yang akan mengubah praktik mahasiswa ke depannya.	• **Analisis penyebab:** tidak ada sistem aktif recall pasien berisiko oleh kader/bidan desa • **Tindakan pencegahan:** perlu protokol kunjungan rumah aktif oleh bidan desa untuk ibu dengan riwayat hipertensi kehamilan • **Pembelajaran:** setiap ibu dengan TD ≥140/90 pada ANC wajib dirujuk ke SPOG dan dipantau kehadiran kunjungan berikutnya
4	**Risiko yang Diidentifikasi**	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien, baik yang berasal dari kondisi klinis pasien, keterbatasan fasilitas, maupun perilaku tenaga kesehatan — termasuk kesalahan yang hampir terjadi (near-miss).	Risiko yang diidentifikasi pada kasus rujukan kegawatdaruratan intrapartum: • **Risiko klinis:** DJJ turun ke 90x/mnt pasca amniotomi pada multigravida belum engaged → prolaps tali pusat • **Risiko tindakan:** amniotomi dilakukan tanpa memastikan engagement kepala — langkah yang memicu kegawatan

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			• **Risiko komunikasi:** jika bidan tidak langsung menelepon RS saat menangani prolaps, pasien bisa terlambat ditangani di kamar operasi • **Risiko transfer:** ambulans klinik bidan mandiri tidak memiliki oksigen portable → SpO2 ibu tidak terpantau selama 47 menit perjalanan • **Near-miss:** tali pusat masih berdenyut saat tiba di RS dan SC berhasil — namun jika waktu transfer 10 menit lebih lama, outcome bisa berbeda
5	**Tindakan Pencegahan**	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko keselamatan pasien pada kasus serupa di masa mendatang. Tindakan pencegahan harus spesifik, realistis, dan dapat	Tindakan pencegahan yang dirumuskan mahasiswa dari kasus-kasus rujukan intrapartum: • **Pencegahan eklampsia:** buat sistem recall aktif: setiap ibu hamil dengan TD ≥140/90 yang tidak datang ANC dalam 2

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
		diimplementasikan di fasilitas tempat praktik.	minggu harus dikunjungi bidan desa • **Pencegahan prolaps:** pada multigravida, wajib konfirmasi engagement kepala janin dengan Leopold IV sebelum amniotomi — jika kepala belum fixed, amniotomi DITUNDA • **Pencegahan PPP:** setiap grandemultipara dengan Hb <10 g/dL WAJIB dirujuk ke RS untuk rencana persalinan — tidak boleh bersalin di fasilitas tanpa UTD • **Pencegahan keterlambatan transfer:** protocol card SBAR harus tersedia di setiap ruang bersalin agar komunikasi rujukan dapat dilakukan dalam < 3 menit • **Pencegahan toksisitas MgSO4:** pasang lembar checklist pemantauan MgSO4 (refleks patella, RR, urin output) di

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			samping tempat tidur pasien
6	**Pembelajaran Mahasiswa**	Refleksi harus menunjukkan secara eksplisit apa yang dipelajari mahasiswa dari kasus tersebut dan bagaimana pembelajaran itu akan memengaruhi praktiknya ke depan — bukan hanya pernyataan umum, melainkan perubahan perilaku klinis yang spesifik dan terukur.	**Pernyataan pembelajaran mahasiswa dari kasus prolaps tali pusat:** *"Dari kasus ini saya belajar bahwa refleks tindakan pertama pada prolaps tali pusat — elevasi kepala janin secara manual — harus menjadi respons otomatis yang tidak membutuhkan waktu berpikir. Ke depan, saya akan berlatih skenario ini dalam simulasi minimal 1 kali per bulan agar respons saya semakin cepat dan tepat. Saya juga belajar bahwa keberanian mempertahankan posisi tangan selama 78 menit bukan hanya keterampilan fisik, tetapi juga keteguhan mental yang harus dilatih."* **Perubahan perilaku konkret yang akan dilakukan:** • Selalu cek engagement kepala janin dengan Leopold IV sebelum setiap amniotomi

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			• Hafalkan urutan 5 langkah pertama pada setiap kasus kegawatan (eklampsia, PPP, prolaps) tanpa membuka buku • Biasakan mengisi lembar observasi kronologis pada setiap kasus partus — bukan hanya kasus gawat
7	**Makna dalam OBE**	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien. Refleksi yang baik membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya melakukan tindakan, tetapi mampu mengevaluasi dan meningkatkan mutu praktiknya secara berkelanjutan.	Mahasiswa membuktikan pencapaian OBE melalui refleksi patient safety yang: • **Spesifik dan berbasis kasus nyata:** bukan pernyataan generik 'saya harus lebih hati-hati', tetapi 'saya akan memastikan kepala engaged sebelum amniotomi pada setiap multigravida' • **Menunjukkan kesadaran sistem:** mampu mengidentifikasi bahwa kegagalan bukan hanya individual tetapi juga sistemik — tidak ada protokol recall pasien

No.	Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Rujukan Kegawatdaruratan Intrapartum
			risiko tinggi di Puskesmas • **Berorientasi perbaikan terukur:** merumuskan langkah konkret yang dapat diverifikasi dalam praktik berikutnya • **Menunjukkan integritas profesional:** jujur mendokumentasikan kesalahan atau keterlambatan sendiri sebagai bahan pembelajaran, bukan disembunyikan

D. Ringkasan

Kemenkes RI (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% kematian ibu terjadi pada periode intrapartum dan pascapersalinan dini, dan sebagian besar dapat dicegah bila sistem rujukan berfungsi optimal. WHO menegaskan bahwa keterlambatan dalam mengambil keputusan, mendapatkan pertolongan, dan tiba di fasilitas yang tepat — dikenal sebagai *Three Delays Model* — adalah penyebab utama kematian ibu yang dapat dihindari.

Indikasi rujukan intrapartum didasarkan pada penilaian klinis komprehensif terhadap ibu dan janin. Dari sisi maternal, indikasi mencakup hipertensi berat atau eklampsia, perdarahan antepartum maupun postpartum, prolaps tali pusat, ruptur uteri, gawat janin, kelainan letak, distosia bahu, dan CPD.

Rujukan intrapartum adalah proses memindahkan ibu yang sedang bersalin dari fasilitas kesehatan primer ke fasilitas dengan kapasitas lebih tinggi ketika

kondisi ibu atau janin memerlukan perawatan intensif. Proses ini bukan sekadar perpindahan fisik pasien, melainkan sebuah rangkaian asuhan yang mencakup komunikasi terstruktur, stabilisasi klinis, dokumentasi yang akurat, dan pendampingan berkelanjutan.

Komunikasi yang terstruktur dan akurat merupakan tulang punggung keberhasilan rujukan. Metode ISBAR *(Identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation*) yang direkomendasikan WHO digunakan saat menghubungi fasilitas penerima sebelum pasien diberangkatkan.

Informed consent adalah elemen legal dan etis yang wajib dipenuhi sebelum tindakan rujukan. Dalam situasi kegawatan intrapartum, keselamatan jiwa selalu menjadi prioritas.

Dokumentasi rujukan memiliki dua fungsi utama: sebagai alat komunikasi klinis yang memastikan kesinambungan asuhan, dan sebagai dokumen legal yang melindungi pasien serta tenaga kesehatan. Komponen wajib yang harus dibawa meliputi surat rujukan obstetri (berisi identitas, diagnosis, tindakan yang diberikan beserta respons pasien, dan kondisi saat berangkat), partograf yang dilengkapi hingga saat keberangkatan, lembar informed consent, serta lembar observasi tanda vital dan DJJ yang dicatat secara berkala.

Transport aman mensyaratkan persiapan sistematis sebelum pasien diberangkatkan: ambulans dilengkapi oksigen portable, suction, doppler, partus set darurat, dan kit obat emergensi. Selama perjalanan, pemantauan tanda vital ibu dilakukan setiap 15 menit dan DJJ setiap 10–15 menit. Nakes pendamping harus mampu melakukan RJP dan menangani persalinan darurat di perjalanan.

Serah terima di fasilitas penerima dilakukan menggunakan ISBAR verbal kepada tim penerima, dilanjutkan dengan teknik *read-back* di mana penerima mengulang informasi kritis untuk memverifikasi pemahaman. Seluruh dokumen diserahkan dan berita acara serah terima ditandatangani oleh kedua pihak.

Prinsip yang paling fundamental dan harus dipegang oleh setiap tenaga kesehatan adalah: *stabilisasi bukan delay*. Rujukan bukan tanda kegagalan asuhan namun keputusan klinis yang menyelamatkan nyawa.

Red Flags & Eskalasi

Kegawatdaruratan Persalinan: Rujukan Intrapartum

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Tekanan darah ≥ 160/110 mmHg secara tiba-tiba selama intrapartum, disertai nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, atau nyeri epigastrik	Menandakan Pre-eklampsia Berat yang dapat berevolusi menjadi eklampsia kapan saja. Risiko perdarahan serebral dan kematian ibu meningkat signifikan bila tidak ditangani dalam menit pertama	Berikan antihipertensi segera (Nifedipin 10 mg sublingual atau Labetalol IV); pantau TD tiap 15 menit; pertimbangkan MgSO4 bila ada tanda eklampsia impending; lakukan ISBAR ke RSUD PONEK dan rujuk MERAH bila tidak respons dalam 30 menit
Kejang intrapartum yang terjadi mendadak, dengan atau tanpa riwayat hipertensi yang terdokumentasi sebelumnya	Eklampsia — kegawatan obstetri tertinggi. Setiap menit keterlambatan meningkatkan risiko hipoksia janin berat, perdarahan serebral ibu, dan kematian. Tidak dapat ditangani definitif di fasilitas primer	Bebaskan jalan napas dan posisikan miring kiri dalam 60 detik; pasang O2 masker non-rebreathing 10–15 L/mnt; berikan MgSO4 4g IV pelan 15–20 menit sebagai loading dose; pasang IV line 2 jalur; rujuk MERAH sambil maintenance MgSO4 tetap berjalan
DJJ < 100 x/menit (bradikardia berat) yang berlangsung lebih dari 3 menit dan tidak membaik setelah reposisi ibu	Menunjukkan hipoksia janin akut yang mengancam jiwa. DJJ < 100 x/menit yang persisten tanpa koreksi akan menyebabkan asidosis janin berat dan kerusakan otak permanen dalam 10–20 menit. Penyebab paling sering	Hentikan oksitosin segera; posisikan ibu miring kiri penuh; berikan O2 masker 8 L/mnt; bolus RL 500 mL IV cepat; evaluasi apakah partus operatif dapat dilakukan segera di tempat; bila tidak, rujuk MERAH dan pantau DJJ

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
	adalah kompresi tali pusat atau solusio plasenta	tiap 5 menit selama transfer
Tali pusat terlihat atau teraba di vulva/vagina segera setelah ketuban pecah, dengan atau tanpa denyutan yang terasa	Kegawatan obstetri ekstrem. Kompresi tali pusat antara kepala janin dan dinding pelvis menyebabkan hipoksia janin dalam hitungan menit. Tali pusat yang masih berdenyut menandakan janin masih hidup namun dalam bahaya segera	Masukkan tangan ke vagina dan elevasi kepala janin secara manual dalam 60 detik — tangan tidak boleh dilepas selama transfer; posisikan knee-chest atau Trendelenburg ekstrem; balut tali pusat dengan kain lembab hangat; berikan Terbutalin 0,25 mg SC; rujuk MERAH dengan komunikasi 'siapkan SC dalam 15 menit kedatangan'
Air ketuban bercampur mekonium kental (hijau tua atau hitam) bersamaan dengan DJJ yang abnormal	Mekonium kental menunjukkan distres janin yang sudah berlangsung. Kombinasi dengan DJJ abnormal merupakan indikator gawat janin bermakna yang memerlukan tindakan segera. Meningkatkan risiko aspirasi mekonium neonatal bila tidak ditangani sebelum kelahiran	Hentikan oksitosin; posisikan miring kiri; berikan O2 masker 8–10 L/mnt; lakukan hidrasi IV cepat; beritahu tim neonatus untuk menyiapkan resusitasi aktif; evaluasi apakah partus operatif dapat dilakukan segera; rujuk bila tidak ada fasilitas operatif di tempat
Perdarahan pervaginam aktif tanpa nyeri yang terjadi mendadak	Perdarahan tanpa nyeri mengarah pada plasenta previa; perdarahan dengan nyeri dan uterus	Dilarang melakukan pemeriksaan dalam pada kasus plasenta previa; pasang O2 masker dan IV

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
selama intrapartum, atau perdarahan disertai nyeri abdomen hebat dan uterus tegang seperti papan	tegang mengarah pada solusio plasenta berat. Keduanya dapat menyebabkan syok hemoragik dan kematian janin dalam waktu singkat. Solusio dapat menyembunyikan perdarahan retroplasenta yang masif	line 2 jalur besar; berikan bolus RL 1–2 L cepat; pasang kateter Foley; rujuk MERAH ke RS dengan UTD dan fasilitas SC emergensi; komunikasikan kebutuhan darah cross-match minimal 4 unit PRC
Perdarahan postpartum > 500 mL dalam 1 jam pertama pasca persalinan, disertai uterus yang lembek dan tidak berkontraksi	Atonia uteri — penyebab utama perdarahan postpartum primer. Keterlambatan mengenali, memutuskan, dan mendapat pertolongan (Three Delays) adalah penyebab utama kematian ibu karena PPP. Grandemultipara dengan anemia adalah kelompok risiko tertinggi	Lakukan masase uterus terus-menerus; berikan Oksitosin 10 IU IM dan 20 IU drip IV; lakukan Kompresi Bimanual Interna 5 menit; berikan Misoprostol 800 mcg rektal; pasang tampon kondom kateter sebagai bridging; rujuk MERAH bila tidak respons dalam 20–30 menit
Nyeri abdomen hebat yang tiba-tiba muncul lalu mereda secara mendadak, disertai berhentinya kontraksi dan DJJ yang menghilang	Tanda klasik ruptur uteri. Nyeri yang tiba-tiba lalu mereda mencerminkan robekan dinding uterus yang menghilangkan tekanan kontraksi. Perdarahan intraabdomen masif dan kematian janin dapat terjadi dalam 30–60 menit. Riwayat SC atau	Hentikan oksitosin segera dan mutlak; berikan O2 masker 10–15 L/mnt; pasang IV line 2 jalur besar dan bolus RL 2 L cepat; pasang kateter; lakukan informed consent keluarga tentang kemungkinan histerektomi; rujuk MERAH dengan

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
	miomektomi sebelumnya adalah faktor risiko utama	komunikasi 'siapkan laparotomi emergensi dan darah O negatif'
Ibu tampak pucat, akral dingin, nadi lemah dan cepat > 120 x/menit, tekanan darah sistolik < 90 mmHg, atau penurunan kesadaran selama intrapartum	Kegawatdaruratan maternal: syok hipovolemik atau distributif. Pada ibu hamil, kompensasi tubuh dapat menyembunyikan hipovolemia hingga kehilangan 30–35% volume sirkulasi. Penurunan kesadaran menandakan syok stadium lanjut yang mengancam jiwa dalam menit	Posisikan Trendelenburg — kaki lebih tinggi; O2 masker non-rebreathing 10–15 L/mnt; bolus RL 1–2 L IV cepat melalui 2 jalur besar; identifikasi dan tangani sumber perdarahan; pantau urin output tiap jam; rujuk MERAH setelah stabilisasi minimal TD > 80 mmHg sistolik; hubungi UTD RS tujuan untuk siapkan darah
Demam > 38,5°C intrapartum disertai nyeri tekan uterus, air ketuban berbau busuk, dan takikardia ibu > 100 x/menit bersamaan dengan takikardia janin > 160 x/menit	Korioamnionitis atau sepsis maternal. Kombinasi takikardia ibu dan janin bersamaan adalah pasangan tanda infeksi aktif yang paling kuat. Tanpa tata laksana, dapat berkembang menjadi sepsis berat dalam 2–4 jam dan meningkatkan risiko sepsis neonatal secara bermakna	Mulai Ampisilin 2g IV dan Gentamisin 80 mg IV segera; berikan antipiretik Parasetamol IV atau rektal; percepat persalinan bila memungkinkan; beritahu tim neonatus bahwa bayi memerlukan antibiotik; rujuk bila tidak ada respons dalam 1–2 jam atau bila tanda sepsis berat muncul
Keputusan untuk merujuk sudah jelas secara klinis tetapi	Keterlambatan dalam proses rujukan itu sendiri adalah red flag sistemik.	Aktifkan rencana rujukan tanpa delay; lakukan ISBAR via telepon ke RS

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
proses rujukan tertunda karena alasan administrasi, logistik, atau komunikasi yang tidak terstruktur	Setiap menit penundaan setelah keputusan rujukan ditetapkan menambah risiko kematian ibu dan janin. Kegagalan komunikasi adalah penyebab tersering keterlambatan fase ketiga dari Three Delays Model	tujuan sebelum pasien berangkat; lengkapi partograf, surat rujukan, dan informed consent secara paralel — bukan berurutan; komunikasikan kondisi kepada keluarga dan faskes penerima; tujuan: pasien berangkat dalam < 30 menit untuk kasus MERAH

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab 14: Rujukan pada Kegawatdaruratan Persalinan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Mengidentifikasi indikasi rujukan intrapartum berdasarkan kondisi ibu dan janin.	☐	☐	_____
2	Menyampaikan komunikasi SBAR/ISBAR secara terstruktur dan efisien dalam situasi darurat.	☐	☐	_____
3	Mengisi surat rujukan obstetri dengan komponen wajib yang lengkap.	☐	☐	_____
4	Melengkapi partograf hingga saat keberangkatan dan menyertakannya dalam berkas rujukan.	☐	☐	_____
5	Memperoleh informed consent secara etis dan mendokumentasikannya dengan benar.	☐	☐	_____
6	Mempersiapkan transport aman menggunakan checklist sistematik.	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
7	Memberikan penjelasan kepada keluarga dengan bahasa yang jelas, empati, dan terapeutik.	☐	☐	_____
8	Melaksanakan serah terima klinis yang efektif di fasilitas penerima.	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

E. Daftar Pustaka

Chandraharan, E., Pereira, S., Ghi, T., Gracia Perez-Bonfils, A., Fieni, S., Jia, Y. J., Griffiths, K., Sukumaran, S., Ingram, C., Reeves, K., Bolten, M., Loser, K., Carreras, E., Suy, A., Garcia-Ruiz, I., Galli, L., & Zaima, A. (2024). International expert consensus statement on physiological interpretation of cardiotocograph (CTG): First revision (2024). *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, *302*(September), 346–355. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2024.09.034

Daniels, A. A., & Abuosi, A. (2020). Improving emergency obstetric referral systems in low and middle income countries: A qualitative study in a tertiary health facility in Ghana. *BMC Health Services Research*, *20*(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12913-020-4886-3

De Meester, K., Verspuy, M., Monsieurs, K. G., & Van Bogaert, P. (2020). SBAR improves nurse-physician communication and reduces unexpected death: A pre and post intervention study. *Resuscitation*, *84*(9), 1192–1196. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2013.03.016

Derksen, C., Kötting, L., Keller, F. M., Schmiedhofer, M., & Lippke, S. (2022). Psychological Intervention to Improve Communication and Patient Safety in Obstetrics: Examination of the Health Action Process Approach. *Frontiers in Psychology*, *13*(February), 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.771626

Farine, D. (2017). Intrapartum care. *Journal of Perinatal Medicine*, *45*(3), 269–271. https://doi.org/10.1515/jpm-2017-0019

Hüner, B., Derksen, C., Schmiedhofer, M., Lippke, S., Riedmüller, S., Janni, W., Reister, F., & Scholz, C. (2023). Reducing preventable adverse events in obstetrics by improving interprofessional communication skills – Results of an intervention study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *23*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s12884-022-05304-8

Institute for Healthcare Improvement. (2017). *SBAR Tool (Situation Background Assessment Recommendation): A framework for communication between members of the health care team about a patient's condition*. http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/sbartoolkit.aspx

Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*.

Kemenkes RI. (2023a). 1. Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang. 2023;(187315):1–

300.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Undang-Undang*, *187315*, 1–300.

Kemenkes RI. (2023b). *Kepdirjen Juknis Aplikasi Sisrute*.

Kemenkes RI. (2023c). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*.

Kemenkes RI. (2024). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN*. *5*(1), 70–80.

Kemenkes RI. (2025). *KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/560/2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT*. 1–29.

Lardaro, T., Balaji, A., Yang, D., Kuhn, D., Glober, N., Brent, C. M., Couturier, K., Breyre, A., Vaizer, J., & Hunter, B. R. (2024). Assessing the Risk of Interfacility Transport in Pregnant Patients Due to Progression of Labor: Lessons From a Specialized Maternal-Fetal Transport Program. *Cureus*, *16*(9). https://doi.org/10.7759/cureus.70542

Lippke, S., Derksen, C., Keller, F. M., Kötting, L., Schmiedhofer, M., & Welp, A. (2021). Effectiveness of communication interventions in obstetrics—a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(5), 1–28. https://doi.org/10.3390/ijerph18052616

Nabulo, H., Gottfredsdottir, H., Joseph, N., & Kaye, D. K. (2023). Experiences of referral with an obstetric emergency: voices of women admitted at Mbarara Regional Referral Hospital, South Western Uganda. *BMC Pregnancy and Childbirth*, *23*(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12884-023-05795-z

Peraturan Menteri Kesehatan RI. (2012). *Permenes RI Nomor 001 tahun 2012*. *7*(122), 1–25.

Radovich, E., Banke-Thomas, A., Campbell, O. M. R., Ezeanochie, M., Gwacham-Anisiobi, U., Ande, A. B. A., & Benova, L. (2021). Critical comparative analysis of data sources toward understanding referral during pregnancy and childbirth: three perspectives from Nigeria. *BMC Health Services Research*, *21*(1), 1–17. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06945-9

Rudiyanti, N., & Utomo, B. (2024). Challenges of health workers in primary health facilities in implementing obstetric emergency referrals to save women from

death in Indonesia: A qualitative study. *Belitung Nursing Journal*, *10*(6), 644–653. https://doi.org/10.33546/bnj.3525

Schmiedhofer, M., Derksen, C., Keller, F. M., Dietl, J. E., Häussler, F., Strametz, R., Koester-Steinebach, I., & Lippke, S. (2021). Barriers and facilitators of safe communication in obstetrics: Results from qualitative interviews with physicians, midwives and nurses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(3), 1–16. https://doi.org/10.3390/ijerph18030915

Sormin, R. E. M. and Mangngi, A. P. (2025). *60 Langkah Asuhan Persalinan Normal \& Partograf*. https://www.researchgate.net/publication/389660841_ASUHAN_KEBIDANAN_PERSALINAN_BAYI_BARU_LAHIR_60_Langkah_Asuhan_Persalinan_Normal_Partograf

WHO. (2017). Managing Complications in Pregnancy and Childbirth. In *Integrated Management of Pregnancy And Childbirth*.

WHO. (2018). *Intrapartum care for a positive childbirth experience*. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260178/1/9789241550215-eng.pdf?ua=1%0Ahttp://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/

WHO. (2020). *WHO Labour Care Guide : manuel des utilisateurs*.

WHO. (2023a). *Maternal mortality: Evidence brief*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-19.20

WHO. (2023b). *Maternal mortality in fragile and conflict-affected situations : technical brief*.

Zulharryansah Mesir Siregar, & Rangkuti, Z. A. (2024). Implementation of An Integrated Referral System (Sisrute) In Improving Health Service Referrals at Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik Medan. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *4*(5), 1285–1295. https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.503

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb. Tempat dan Tanggal Lahir Sumenep, 04 Desember 1978. Riwayat Pendidikan, STIKes Insan Unggul Surabaya bidang ilmuKebidanan 2004-2006, S2 UNPAD Bandung bidang ilmu kebidanan 2008- 2010, S3 UNAIR Surabaya Ilmu Kedokteran 2016- 2019. memiliki pengalaman sebagai bidan, dosen, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Asesor BKD Nasional, auditor mutu internal, editor, serta reviewer berbagai jurnal ilmiah. Bidang keilmuan dan penelitian yang banyak dikembangkan berfokus pada kebidanan, preeklampsia, kesehatan ibu hamil, biomarker dan faktor genetik, serta yoga prenatal. Aktif memperoleh hibah penelitian nasional, mempublikasikan karya pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi, menjadi pembicara dalam berbagai forum ilmiah, serta menulis dan menyunting sejumlah buku kebidanan, antara lain tentang kegawatdaruratan maternal-neonatal, persalinan, preeklampsia, dan UKOM Kebidanan.

PROFIL PENULIS



Bdn. Nana Usnawati, S.S.T., M.Keb. Lahir di Ponorogo, 12 Maret 1979. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Ponorogo tahun 1998. Lulus Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Depkes Kediri tahun 2001. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Lulus Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014. Sejak tahun 2002 hingga saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan.
Beberapa buku yang sudah di terbitkan antara lain:
Modul Ajar Kebidanan: Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Book Chapter: Kesehatan Masyarakat di era 5.0; Book Chapter: Konsep Pelayanan Kontrasepsi dan KB; Book Chapter: Kesehatan Keluarga; Book Chapter: Aplikasi Terapi Komplementer di Kebidanan; Buku Ajar Prakonsepsi; Monograf: Kombinasi *Accupressure Points for Lactations* dan *Breast Massage* untuk Memantau Kecukupan ASI bagi Bayi; Monograf: Aplikasi *Mobile* Bunda ASI Pemantauan Waktu Pengeluaran dan Kecukupan ASI bagi Bayi; Monograf: Percepatan Produksi dan Kecukupan ASI bagi Bayi dengan Teknik Breast Care dan Accupressure Point for Lactation (BREAC); Monograf: *m-Health* Aplikasi Bunda ASI: Solusi Meningkatkan ASI Eksklusif; Buku Pemberdayaan Kelompok Pendukung ASI dan Pendampingan Menyusui; Buku Sukses UKOM D3 Bidan; Buku Prakonsepsi; Buku Asuhan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal; Buku Evidence Based Kasus Soal Kebidanan Komunitas II; Monograf: Edu-Fas Deteksi Dini Depresi Postpartum Berbasis Android; Monograf: Gadget dan Perkembangan Emosional bagi Anak Usia Dini; Buku Diagnosis Bidan Perimenopause; Buku Asuhan Kebidanan Reproduksi Remaja dan Pasangan Usia Subur; Buku Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Bencana; Buku Standar Operasional Prosedur Asuhan Kebidanan Masa Persalinan; Buku OSCE Profesi Bidan; Buku Ajar Konsep Kebidanan; Monograf: Aplikasi Edu-Fas: Solusi Inovatif Berbasis Android untuk Deteksi Dini Depresi Postpartum; Book Chapter: Pentingnya Nutrisi dan Bahaya *Stunting.* Book Chapter; Ilmu Kebidanan Dasar; Monograf: "SIMANIS" **(**SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL) Inovasi Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Deteksi dini Infeksi Menular Seksual Pada Remaja; Buku Referensi Deteksi Dini pada Kehamilan Dari Perkembangan Janin hingga Persiapan Kelahiran; Buku Bank Soal UKOM Kebidanan Terstandar Nasional & Pembahasan Mendalam; Buku: Asuhan Kebidanan Kehamilan; Bunga Rampai: Penerapan Continuity of Care Dalam Praktik Kebidanan Modern; Bunga Rampai: Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui; Menapak Masa Menopause Dengan Bahagia: Pemberdayaan Wanita Menuju Hidup Sehat, Mandiri, dan Berkualitas.

PROFIL PENULIS



Susiani Endarwati, SST.M.Kes. adalah nama lengkap penulis, penulis lahir di Blitar pada tanggal 13 November 1983. Penulis adalah salah satu dosen pengajar di Universitas STRADA Indonesia Kediri Jawa Timur.
Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Blitar, kemudian pada tahun 2002 penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan D3 di Polteknik Kesehatan Malang Prodi Kebidanan Kediri. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan ke jenjang D4 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Prodi Kebidanan DIV Bidan Pendidik. Pendidikan Master (S2) pada tahun 2012 di Universitas Sebelas Maret Surakarta di Prodi Magister Kedokteran Keluarga Minat Pendidikan Profesi Kesehatan.
Penulis juga telah memiliki Sertifikat Pendidik dari Kemenristekdikti, penulis juga aktif menyusun buku ajar, mengikuti pelatihan dan seminar. Mata kuliah yang d ampu adalah Persalinan, Nifas, KB dan Kesehatan Reproduksi, selain mengajar penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pernah mendapatkan Hibah Penelitian Dosen Pemula dari Ristekdikti. Jalin kerjasama dengan penulis melalui susianiendarwati1@gmail.com



Indah Kusmindarti, SST., Bd., M.Kes. Lahir di Jombang, 11 Juli 19XX. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Kebidanan di Universitas Kadiri tahun 2006. S2 Kesehatan di Universitas Negeri Surakarta tahun 2011 dan Profesi Bidan pada Program Studi Pendidikan Bidan Universitas Bina Sehat PPNI tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995-1996 di RSI Sakinah Mojokerto, tahun 1997- 2000 sebagai bidan PTT di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Membuka layanan PMB mulai 2000-sekarang di Jombang Jawa Timur. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mulai tahun 2005- sekarang. Home base pada Prodi Pendidikan Profesi Bidan, mengampu mata kuliah KDPK, Asuhan Kebidanan Pada Persalinan, KB dan Komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indahk903@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yuni Sari, SST, M.Keb. lahir di Banda Aceh tanggal 17 Juni 1984. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Banda Aceh, kemudian pada tahun 2002 penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan DIII Kebidanan di Polteknik Kesehatan Banda Aceh Prodi Kebidanan. Pada tahun 2006 penulis kembali melanjutkan ke jenjang DIV di Poltekkes Kemenkes Aceh Prodi Kebidanan DIV Bidan Pendidik. Pendidikan Master (S2) pada tahun 2013 di Universitas Brawijaya Malang Prodi Magister Kebidanan.

Penulis juga telah memiliki Sertifikat Pendidik dari Kemenristekdikti, penulis juga aktif menyusun buku ajar, mengikuti pelatihan dan seminar. Mata kuliah yang diampu adalah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Persalinan, dan Ketarmpilan Dasar Kebidanan, selain mengajar penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sinopsis

BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan untuk memahami proses persalinan secara komprehensif, mulai dari fisiologi persalinan, pengkajian kondisi ibu dan janin, hingga pelaksanaan asuhan kebidanan pada setiap kala persalinan.

Buku ini membahas keterampilan klinis dalam pertolongan persalinan, pengambilan keputusan, pemantauan kemajuan persalinan, manajemen kala III, pencegahan perdarahan, serta identifikasi tanda bahaya dan kegawatdaruratan intrapartum. Pembahasan juga menekankan pentingnya stabilisasi awal, kolaborasi, rujukan, komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, dan dokumentasi asuhan.

Melalui pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan penalaran klinis, keterampilan prosedural, serta kemampuan merespons perubahan kondisi secara cepat dan tepat. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran teori, praktikum laboratorium, simulasi klinis, maupun praktik lapangan kebidanan.

BUKU AJAR ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN DAN KEGAWATDARURATAN INTRAPARTUM disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan untuk memahami proses persalinan secara komprehensif, mulai dari fisiologi persalinan, pengkajian kondisi ibu dan janin, hingga pelaksanaan asuhan kebidanan pada setiap kala persalinan.

Buku ini membahas keterampilan klinis dalam pertolongan persalinan, pengambilan keputusan, pemantauan kemajuan persalinan, manajemen kala III, pencegahan perdarahan, serta identifikasi tanda bahaya dan kegawatdaruratan intrapartum. Pembahasan juga menekankan pentingnya stabilisasi awal, kolaborasi, rujukan, komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, dan dokumentasi asuhan.

Melalui pendekatan yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan penalaran klinis, keterampilan prosedural, serta kemampuan merespons perubahan kondisi secara cepat dan tepat. Buku ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran teori, praktikum laboratorium, simulasi klinis, maupun praktik lapangan kebidanan.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-55-2 (PDF)
9 786347 927552